IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

01/03/2026 07:00

Recibo paciente femenino, 57 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: secuelas de infarto cerebral,encefalopatía no especificada pielectas renal izquierda, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, crisis hepilepticas, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable dormida con buen patrón respiratorio presenta pequeños hematomas en miembros inferiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria, con barandas de seguridad elevadas en posición en posición decúbito supino.

Paciente estable desorientada en las 3 desferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO:
Paciente tolero por via oral medicamentos concilio sueño temprano.

OBSERVACIONES
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50pm, se administra una dosis adicional según orden médica.
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (++)
Deposición (+)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral (Cena)

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal,(Se Realizo higiene bucal)

SIGNOS VITALES:
TA: 108/80 mmhg
Fc:83 x'
FR: 17×'
SPO2: 94 %
T: 36.7°C
Recibe Aux- Adriana Beltran
Entrega Aux- karen Behaine

01/03/2026 17:47 Se realiza higiene bucal con cepillo electrico y crema colgate y agua.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

01/03/2026 17:48 Se administra tableta losartan 50mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

01/03/2026 17:48 Se administra tableta Esomeprazol 20mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

01/03/2026 17:49 Se administra capsula Amantadina 100mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

01/03/2026 17:49 Se administra tableta Citicolina 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

01/03/2026 17:49 Se administra tableta Citicolina 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

01/03/2026 17:49 Se asiste a la hora del desayuno, proporcionándole una dieta sólida, se le da tiempo suficiente para que mastique y trague cada bocado, antes de ofrecerle el siguiente, tolera por via oral sin complicacion, paciente colaborador, apetito conservado.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

01/03/2026 17:50 Se asiste media mañana dieta blanda paciente tolera por vía oral sin complicacion.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

01/03/2026 17:50	Ingreso al domicilio congresista el ayudante del padre de la iglesia a darle la ostia a la paciente	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
01/03/2026 17:50	Se administra tableta Ácido acetilsalicílico 100mg vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
01/03/2026 17:50	Se realiza traslado del paciente con ayuda de grúa hacia la silla poceta. Se lleva a cabo baño general, aplicando shampoo en cuero cabelludo y retirando con enjuague; posteriormente se aplica jabón líquido corporal, se enjuaga y se procede al secado completo de la piel. Finalizado el aseo, se traslada a la cama hospitalaria con apoyo de grúa. Se realiza secado cuidadoso de la región genital y glútea, aplicando crema con nistatina y crema Almipro. Se coloca pañal limpio y se viste con ropa limpia y adecuada. Durante el procedimiento, el paciente presentó episodios de nerviosismo.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
01/03/2026 17:51	Se asiste a la hora del almuerzo, proporcionándole una dieta sólida, se le da tiempo suficiente para que mastique y trague cada bocado, antes de ofrecerle el siguiente, tolera por via oral sin complicacion, paciente colaborador, apetito conservado.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
01/03/2026 17:52	Después del almuerzo se administra jarabe Escitalopram en solución oral, 20 cc, según indicación médica(psiquiatra) Tolera la administración por vía oral sin complicaciones, sin presencia de náuseas ni vómito, Paciente tranquila.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
01/03/2026 17:52	Se realiza higiene bucal con cepillo electrico y crema colgate y agua.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
01/03/2026 17:52	Se aplica crema (Betametafona +Clotrimazol+ Neomocina) Parte de la espalda y hombros.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
01/03/2026 17:54	Se observa paciente dormida con buen patrón respiratorio, se realiza cambio de posiciónes lateral izquierdo.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
01/03/2026 17:55	Se realiza aseo y organización de la unidad del paciente en domicilio, incluyendo limpieza de cama, colchón, barandas y superficie del entorno inmediato.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
01/03/2026 18:56	Se realiza cambio de pañal empleando los elementos necesarios (pañal limpio, toallitas húmedas, crema antipañalitis, guantes de látex). Se asegura la cama hospitalaria contra la pared.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

01/03/2026 18:57

Se realiza cambio de sábanas garantizando limpieza y comodidad del paciente, dejando la superficie libre de arrugas. Posteriormente se efectúa cambio de posición Fowler observándose paciente estable con episodios de nerviosismos y llanto.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

01/03/2026 19:00

Entrego paciente femenino, 57 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: secuelas de infarto cerebral,encefalopatía no especificada pielectas renal izquierda, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, crisis hepilepticas, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable despierta con buen patrón respiratorio presenta pequeños hematomas en miembros inferiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria, con barandas de seguridad elevadas en posición en posición decúbito supino.

Paciente estable desorientada en las 3 desferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO:
Paciente tolero por via oral medicamentos y alimentación, presentó depósitos semiliquido con trozos pequeños.
SE ADMINISTRO ACETAMINOFÉN 500MG POR VIA ORAL, PACIENTE TOLERA SIN COMPLICACION

OBSERVACIONES
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50pm, se administra una dosis adicional según orden médica.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (++)
Deposición (+)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral (Desayuno, almuerzo)
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal,(Se Realizo higiene bucal, baño en silla poceta).
Entrega Aux-Adriana Beltrán
Recibe Aux- Karen Behaine

01/03/2026 19:00

Recibo paciente femenino, 57 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: secuelas de infarto cerebral,encefalopatía no especificada pielectas renal izquierda, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, crisis hepilepticas, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable despierta con buen patrón respiratorio presenta pequeños hematomas en miembros inferiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria, con barandas de seguridad elevadas en posición en posición decúbito supino.

Paciente estable desorientada en las 3 desferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO:
Paciente tolero por via oral medicamentos y alimentación, presentó depósitos semiliquido con trozos pequeños.
SE ADMINISTRO ACETAMINOFÉN 500MG POR VIA ORAL, PACIENTE TOLERA SIN COMPLICACION

OBSERVACIONES
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
* Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
* Pendiente cita psicóloga (Mayo)

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H

Karen Behaine

BEHAINE GÓMEZ KAREN JULIETH

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50pm, se administra una dosis adicional según orden médica.
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (++)
Deposición (+)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral (Desayuno, almuerzo)
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal,(Se Realizo higiene bucal, baño en silla poceta)

01/03/2026 19:01 se realiza higene bucal

Karen Behaine

BEHAINE GÓMEZ KAREN JULIETH

01/03/2026 20:00 Se administra tableta losartan 50mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

Karen Behaine

BEHAINE GÓMEZ KAREN JULIETH

01/03/2026 21:00 Se administra tableta Amlodipino 5mg vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

Karen Behaine

BEHAINE GÓMEZ KAREN JULIETH

01/03/2026 22:00 Se administra capsula Amantadina 100mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

Karen Behaine

BEHAINE GÓMEZ KAREN JULIETH

01/03/2026 23:00 Se administra tableta Citicolina 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

Karen Behaine

BEHAINE GÓMEZ KAREN JULIETH

02/03/2026 00:00 se acompaña ala paciente a su almuerzo se le da su respectiva comida con cuidado pollo, ensalada y patacón y agua tolera sin problema la alimentación

Karen Behaine

BEHAINE GÓMEZ KAREN JULIETH

02/03/2026 00:00 se acompaña ala paciente a su almuerzo se le da su respectiva comida con cuidado pollo, ensalada y patacón y agua tolera sin problema la alimentación

Karen Behaine

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

02/03/2026 01:00	se observa paciente tranquila sin ninguna novedad	BEHAINE GÓMEZ KAREN JULIETH
02/03/2026 02:00	se realiza cambio de pañal se limpia zona íntima con pañitos humedos para evitar infecciones y malos olores se le aplica crema antipañalitis y se le coloca pañal seco y limpio	BEHAINE GÓMEZ KAREN JULIETH
02/03/2026 03:00	se realiza cambio de posición lateral izquierdo sin problema	BEHAINE GÓMEZ KAREN JULIETH
02/03/2026 04:00	se observa paciente tranquila sin ninguna novedad	BEHAINE GÓMEZ KAREN JULIETH
02/03/2026 05:00	se realiza cambio de pañal se limpia zona íntima con pañitos humedos se le coloca su respectivo pañal se le aplica crema antipañalitis para evitar lecciones de la Piel sin problema	BEHAINE GÓMEZ KAREN JULIETH
02/03/2026 06:00	se traslada paciente para la silla de ruedas para sus terapias con el fonodiologo acompañada de su familiar	BEHAINE GÓMEZ KAREN JULIETH
02/03/2026 07:00	Entrego paciente femenino, 57 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO DX: secuelas de infarto cerebral,encefalopatía no especificada pielectas renal izquierda, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, crisis hepilepticas, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida. Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable despierta con buen patrón respiratorio presenta pequeños hematomas en miembros inferiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes. Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria, con barandas de seguridad elevadas en posición en posición decúbito supino. Paciente estable desorientada en las 3 desferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica, Ojos normoreactivos a la luz, Mucosa nasal húmeda sin laceraciones, Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados,	BEHAINE GÓMEZ KAREN JULIETH

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO:
Paciente tolero por via oral medicamentos y alimentación, presentó depósitos semiliquido con trozos pequeños.
SE ADMINISTRO ACETAMINOFÉN 500MG POR VIA ORAL, PACIENTE TOLERA SIN COMPLICACION

OBSERVACIONES
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
* Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
* Pendiente cita psicóloga (Mayo)

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50pm, se administra una dosis adicional según orden médica.
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (++)
Deposición (+)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral (Desayuno, almuerzo)
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal,(Se Realizo higiene bucal, baño en silla poceta)

02/03/2026 07:00

Recibo paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: Encefalopatia hipoxica,crisis epilépticas, cuadriplejia flácida y polineuropatia no especificada, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable dormida con buen patrón respiratorio presenta pequeños hematomas en miembros inferiores y superiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria, con barandas de seguridad elevadas posición semifowler.

Paciente estable desorientada en las 3 esferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO:
Paciente se mantiene nerviosa, ansiosa con episodios de llanto, paciente Tolera adecuadamente la vía oral para la administración de medicamentos, concilio sueño temprano.

OBSERVACIONES
* Dentro del domicilio Se observa hace tiempo material mecánicos, a fuera llenos de polvo y mugre.(a Jefe de ruta ordeno cerrar las ventan que va directo del paciente).
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
* Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
* Pendiente cita psicóloga (Mayo)
* Pendiente terapias fisioterapeuta
* pendiente terapias ocupacional
•Pendiente terapias fonoaudiologo

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50pm, se administra una dosis adicional según orden médica.
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (++)
Deposición (--)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral (cena)
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal.
terapia con la pelota ejercicios en miembros superiores e inferiores.

02/03/2026 08:00 Se administra tableta losartan 50mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

02/03/2026 08:09	Se realiza higiene bucal con cepillo electrico y crema colgate y agua.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
02/03/2026 08:12	Se administra tableta Esomeprazol 20mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
02/03/2026 08:20	Se administra capsula Amantadina 100mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
02/03/2026 08:30	Se administra tableta Citicolina 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
02/03/2026 09:18	Se asiste a la hora del desayuno, proporcionándole una dieta sólida, se le da tiempo suficiente para que mastique y trague cada bocado, antes de ofrecerle el siguiente, tolera por via oral sin complicacion, paciente colaborador, apetito conservado.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
02/03/2026 10:10	se realiza higiene bucal con cepillo electrico y crema colgate y agua.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
02/03/2026 11:12	Se realiza tendido de cama garantizando limpieza y comodidad del paciente, dejando la superficie libre de arrugas. Posteriormente se efectúa cambio de posición decúbito lateral izquierdo observándose paciente estable, tranquila y con adecuada tolerancia al procedimiento.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
02/03/2026 11:34	Se administra tableta Ácido acetilsalicílico 100mg vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
02/03/2026 12:13	Se realiza cambio de posición lateral derecho, paciente estable tranquila.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
02/03/2026 13:04	Se administra Acido valproico 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

02/03/2026 13:04	Se administra Acido valproico 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
02/03/2026 13:25	Se asiste a la hora del almuerzo, proporcionándole una dieta sólida, se le da tiempo suficiente para que mastique y trague cada bocado, antes de ofrecerle el siguiente, tolera por via oral sin complicacion, paciente colaborador, apetito conservado.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
02/03/2026 13:26	Después del almuerzo se administra jarabe Escitalopram en solución oral, 20 cc, según indicación médica(psiquiatra) Tolera la administración por vía oral sin complicaciones, sin presencia de náuseas ni vómito, Paciente tranquila.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
02/03/2026 14:13	Se realiza higiene bucal con cepillo electrico y crema colgate y agua.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
02/03/2026 15:26	Se realiza traslado del paciente con ayuda de grúa hacia la silla poceta. Se lleva a cabo baño general, aplicando shampoo en cuero cabelludo y retirando con enjuague; posteriormente se aplica jabón líquido corporal, se enjuaga y se procede al secado completo de la piel. Finalizado el aseo, se traslada a la cama hospitalaria con apoyo de grúa. Se realiza secado cuidadoso de la región genital y glútea, aplicando crema con nistatina y crema Almipro. Se coloca pañal limpio y se viste con ropa limpia y adecuada. Durante el procedimiento, el paciente presentó episodios de nerviosismo.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
02/03/2026 17:35	se realiza cambio de pañal empleando los elementos necesarios (pañal limpio, toallitas húmedas, crema antipañalitis, guantes de látex). Se asegura la cama hospitalaria contra la pared para aportar mayor seguridad al paciente durante el procedimiento. Se traslada paciente en grúa a la silla de ruedas, traslado paciente a la sala.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
02/03/2026 18:35	Ingresa al domicilio el fonoaudiólogo particular Jhonathan Ibáñez, quien realiza terapia con electroestimulación y masajes en región cervical. Paciente se encuentra estable, tranquila y colaboradora durante el procedimiento.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
02/03/2026 18:55	Se realiza aseo y organización de la unidad del paciente en domicilio, incluyendo limpieza de cama, colchón, barandas y superficie del entorno inmediato.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
02/03/2026 18:57	Se traslada paciente en grúa a la cama hospitalaria,se realiza cambio de posición lateral izquierdo paciente estable, con episodios de nerviosismos.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
02/03/2026 19:00	Recibo paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO DX: secuelas de infarto cerebral,encefalopatía no especificada pielectas renal izquierda, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, crisis hepilepticas, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH Karen Behaine

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

BEHAINE GÓMEZ KAREN JULIETH

hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable despierta con buen patrón respiratorio presenta pequeños hematomas en miembros inferiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria, con barandas de seguridad elevadas en posición en posición decúbito lateral izquierdo.

Paciente estable desorientada en las 3 desferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO:
Paciente tolero por via oral medicamentos y alimentación, paciente estable tranquila, concilio sueño temprano

OBSERVACIONES
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50pm, se administra una dosis adicional según orden médica.
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (++)
Deposición (-)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral (cena)
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal,(Se Realizo higiene bucal).

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

Entrega Aux - Karen Behaine

02/03/2026 19:00 Se Realizo higiene bucal, baño en silla poceta

Karen Behaine

BEHAINE GÓMEZ KAREN JULIETH

02/03/2026 19:00 Entrego paciente femenino, 57 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: secuelas de infarto cerebral,encefalopatía no especificada pielectas renal izquierda, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, crisis hepilepticas, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable despierta con buen patrón respiratorio presenta pequeños hematomas en miembros inferiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria, con barandas de seguridad elevadas en posición en posición decúbito lateral izquierdo.

Paciente estable desorientada en las 3 desferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO:
Paciente tolero por via oral medicamentos y alimentación, paciente estable tranquila, Ingreso al domicilio fonoaudiologo particular Jhonathan Ibañez.

OBSERVACIONES
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50pm, se administra una dosis adicional según orden médica.
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre

Adriana

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (++)
Deposición (-)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral (desayuno, almuerzo)
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal,(Se Realizo higiene bucal, baño en silla poceta).
Entrega Aux - Adriana Beltrán
Recibe Aux- Karen Behaine

02/03/2026 20:00 Se administra tableta losartan 50mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

Karen Behaine

BEHAINE GÓMEZ KAREN JULIETH

02/03/2026 20:00 Se administra tableta losartan 50mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

Karen Behaine

BEHAINE GÓMEZ KAREN JULIETH

02/03/2026 21:00 Se administra Quetiapina 200mg, mas dos tabletas Quetiapina 25mg un total administrados 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

Karen Behaine

BEHAINE GÓMEZ KAREN JULIETH

02/03/2026 22:00 se le retira su respectivo pañal y pijama se traslada para la silla pato para su respectivo baño al paciente removiendo impurezas con agua y jabón se seca y se traslada a su camilla se seca bien, se le coloca pañal a seco y limpio se le aplica crema antipañalitis para evitar lecciones de la piel se hidrata su piel con crema de humectante se le coloca su pantalón y camisa se realiza cambio de sábanas limpias para su mejor comodidad al paciente

Karen Behaine

BEHAINE GÓMEZ KAREN JULIETH

02/03/2026 23:00 se administra medicamentos v.o con agua asa tableta de 100mg tolera sin problema

Karen Behaine

BEHAINE GÓMEZ KAREN JULIETH

03/03/2026 01:00 se observa paciente tranquila sin ninguna novedad

Karen Behaine

BEHAINE GÓMEZ KAREN JULIETH

03/03/2026 02:00 se realiza cambio de pañal se limpia zona íntima con pañitos humedos para evitar infecciones y malos olores se le aplica crema antipañalitis y se le coloca pañal seco y limpio

Karen Behaine

BEHAINE GÓMEZ KAREN JULIETH

03/03/2026 03:00 se realiza cambio de posición lateral izquierdo sin problema

Karen Behaine

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

03/03/2026 04:00

se observa paciente tranquila sin ninguna novedad

BEHAINE GÓMEZ KAREN JULIETH

Karen Behaine

03/03/2026 05:00

se realiza cambio de pañal se limpia zona íntima con pañitos humedos se le coloca su respectivo pañal se le aplica crema antipañalitis para evitar lecciones de la Piel sin problema

BEHAINE GÓMEZ KAREN JULIETH

Karen Behaine

03/03/2026 06:00

se traslada paciente para la silla de ruedas para sus terapias con el fonodiologo acompañada de su familiar

BEHAINE GÓMEZ KAREN JULIETH

Karen Behaine

03/03/2026 07:00

Entrego paciente femenino, 57 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: secuelas de infarto cerebral,encefalopatía no especificada pielectas renal izquierda, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, crisis hepilepticas, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable despierta con buen patrón respiratorio presenta pequeños hematomas en miembros inferiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria, con barandas de seguridad elevadas en posición en posición decúbito supino.

Paciente estable desorientada en las 3 desferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO:
Paciente tolero por via oral medicamentos y alimentación, presentó depósitos semiliquido con trozos pequeños.
SE ADMINISTRO ACETAMINOFÉN 500MG POR VIA ORAL, PACIENTE TOLERA SIN COMPLICACION

OBSERVACIONES
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
* Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.

BEHAINE GÓMEZ KAREN JULIETH

Karen Behaine

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

* Pendiente cita psicóloga (Mayo)

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50pm, se administra una dosis adicional según orden médica.
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (++)
Deposición (+)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral (Desayuno, almuerzo)
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal,(Se Realizo higiene bucal, baño en silla poceta)

03/03/2026 07:00

Recibo paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: Encefalopatia hipoxica,crisis epilépticas, cuadriplejia flácida y polineuropatia no especificada, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable dormida con buen patrón respiratorio presenta pequeños hematomas en miembros inferiores y superiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria, con barandas de seguridad elevadas posición semifowler.

Paciente estable desorientada en las 3 esferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO:
Paciente se mantiene nerviosa, ansiosa con episodios de llanto, paciente Tolera adecuadamente la vía oral para la administración de medicamentos, concilio sueño temprano.

OBSERVACIONES
* Dentro del domicilio Se observa hace tiempo material mecánicos, a fuera llenos de polvo y mugre.(a Jefe de ruta ordeno cerrar las ventan que va directo del paciente).
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
* Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
* Pendiente cita psicóloga (Mayo)
* Pendiente terapias fisioterapeuta
* pendiente terapias ocupacional
•Pendiente terapias fonoaudiologo

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50pm, se administra una dosis adicional según orden médica.
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (++)
Deposición (--)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral (cena)
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal.
terapia con la pelota ejercicios en miembros superiores e inferiores.

03/03/2026 08:04 Se retira bata y se realiza lubricación de la piel con crema corporal. Posteriormente, se coloca ropa limpia y seca, paciente estable con ropa limpia piel hidratada, permanece en cama hospitalaria bajo vigilancia y acompañamiento.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

03/03/2026 08:05 Se realiza higiene bucal con cepillo electrico y crema colgate y agua.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

03/03/2026 08:05 Se administra tableta losartan 50mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

03/03/2026 08:11 Se administra tableta Esomeprazol 20mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

03/03/2026 08:22 Se administra capsula Amantadina 100mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

03/03/2026 08:30	Se administra tableta Citicolina 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
03/03/2026 09:38	Se hace acompañamiento y supervisa el desarrollo de las terapia realizada por el Fisioterapeuta partículas (Andrés Rodríguez).Realiza terapias de estiramiento en cama y postura en posición sentado, paciente permanece nerviosa signos de dificultad irritabilidad, inquietud, llanto, paciente tolera las terapias.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
03/03/2026 11:18	Se realiza traslado del paciente con ayuda de grúa hacia la silla poceta. Se lleva a cabo baño general, aplicando shampoo en cuero cabelludo y retirando con enjuague; posteriormente se aplica jabón líquido corporal, se enjuaga y se procede al secado completo de la piel. Finalizado el aseo, se traslada a la cama hospitalaria con apoyo de grúa. Se realiza secado cuidadoso de la región genital y glútea, aplicando crema con nistatina y crema Almipro. Se coloca pañal limpio y se viste con ropa limpia y adecuada. Durante el procedimiento, el paciente presentó episodios de nerviosismo.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
03/03/2026 11:32	Se administra tableta Ácido acetilsalicílico 100mg vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
03/03/2026 13:01	Se administra Acido valproico 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
03/03/2026 13:01	Se administra Acido valproico 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
03/03/2026 13:26	Se asiste a la hora del almuerzo, proporcionándole una dieta sólida, se le da tiempo suficiente para que mastique y trague cada bocado, antes de ofrecerle el siguiente, tolera por via oral sin complicacion, paciente colaborador, apetito conservado.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
03/03/2026 13:27	Después del almuerzo se administra jarabe Escitalopram en solución oral, 20 cc, según indicación médica(psiquiatra) Tolera la administración por vía oral sin complicaciones, sin presencia de náuseas ni vómito, Paciente tranquila.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
03/03/2026 14:08	Se realiza higiene bucal con cepillo electrico y crema colgate y agua.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

03/03/2026 16:33 Se realiza cambio de pañal y aseo general, incluyendo higiene íntima. Paciente tolera el procedimiento sin complicaciones.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

03/03/2026 16:34 Posteriormente, se realiza traslado a silla de ruedas con ayuda de grúa, sin incidencias durante la movilización.
Más tarde, se efectúa arreglo personal, incluyendo planchado de cabello y maquillaje. Paciente queda en silla de ruedas, cómoda y en adecuadas condiciones.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

03/03/2026 17:07 Se hace acompañamiento en su dia de cumpleaños, en compañia de los familiares y amigos.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

03/03/2026 18:40 Se asiste a la hora de la cena , proporcionándole una dieta sólida, se le da tiempo suficiente para que mastique y trague cada bocado, antes de ofrecerle el siguiente, tolera por via oral sin complicacion, paciente colaborador, apetito conservado.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

03/03/2026 19:00 Entrego paciente femenino, 57 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: secuelas de infarto cerebral,encefalopatía no especificada pielectas renal izquierda, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, crisis hepilepticas, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable despierta con buen patrón respiratorio presenta pequeños hematomas en miembros inferiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria, con barandas de seguridad elevadas en posición en posición decúbito lateral izquierdo.

Paciente estable desorientada en las 3 desferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO:
Paciente tolero por via oral medicamentos y alimentación, paciente estable tranquila, Ingreso al domicilio fonoaudiologo particular Jhonathan Ibañez.

OBSERVACIONES
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50pm, se administra una dosis adicional según orden médica.
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (++)
Deposición (-)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral (desayuno, almuerzo)
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal,(Se Realizo higiene bucal, baño en silla poceta).
Entrega Aux - Adriana Beltrán
Recibe Aux- Karen Behaine

03/03/2026 19:00

recibo paciente femenino, 57 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: secuelas de infarto cerebral,encefalopatía no especificada pielectas renal izquierda, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, crisis hepilepticas, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

Karen Behaine

BEHAINE GÓMEZ KAREN JULIETH

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable despierta con buen patrón respiratorio presenta pequeños hematomas en miembros inferiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria, con barandas de seguridad elevadas en posición en posición decúbito supino.

Paciente estable desorientada en las 3 desferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO:
Paciente tolero por via oral medicamentos y alimentación, presentó depósitos semiliquido con trozos pequeños.
SE ADMINISTRO ACETAMINOFÉN 500MG POR VIA ORAL, PACIENTE TOLERA SIN COMPLICACION

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

OBSERVACIONES
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
* Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
* Pendiente cita psicóloga (Mayo)

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50pm, se administra una dosis adicional según orden médica.
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (++)
Deposición (+)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral (Desayuno, almuerzo)
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal,(Se Realizo higiene bucal, baño en silla poceta)

03/03/2026 20:00 Se administra tableta losartan 50mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

Karen Behaine

BEHAINE GÓMEZ KAREN JULIETH

03/03/2026 21:00 Se administra Quetiapina 200mg, mas dos tabletas Quetiapina 25mg un total administrados 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

Karen Behaine

BEHAINE GÓMEZ KAREN JULIETH

03/03/2026 22:00 se le retira su respectivo pañal y pijama se traslada para la silla pato para su respectivo baño al paciente removiendo impurezas con agua y jabón se seca y se traslada a su camilla se seca bien, se le coloca pañal a seco y limpio se le aplica crema antipañalitis para evitar lecciones de la piel se hidrata su piel con crema de humectante se le coloca su pantalón y camisa se realiza cambio de sábanas limpias para su mejor comodidad al paciente

Karen Behaine

BEHAINE GÓMEZ KAREN JULIETH

03/03/2026 23:00 se administra medicamentos v.o con agua asa tableta de 100mg tolera sin problema

Karen Behaine

BEHAINE GÓMEZ KAREN JULIETH

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

04/03/2026 00:00	se acompaña ala paciente a su almuerzo se le da su respectiva comida con cuidado pollo, ensalada y patacón y agua tolera sin problema la alimentación	BEHAINE GÓMEZ KAREN JULIETH
04/03/2026 01:00	se observa paciente tranquila sin ninguna novedad	BEHAINE GÓMEZ KAREN JULIETH
04/03/2026 02:00	Se asiste a la hora del almuerzo, proporcionándole una dieta sólida, se le da tiempo suficiente para que mastique y trague cada bocado, antes de ofrecerle el siguiente, tolera por via oral sin complicacion, paciente colaborador, apetito conservado.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
04/03/2026 02:00	se realiza cambio de pañal se limpia zona íntima con pañitos humedos para evitar infecciones y malos olores se le aplica crema antipañalitis y se le coloca pañal seco y limpio	BEHAINE GÓMEZ KAREN JULIETH
04/03/2026 03:00	se realiza cambio de posición lateral izquierdo sin problema	BEHAINE GÓMEZ KAREN JULIETH
04/03/2026 03:30	Se realiza cambio de posición lateral izquierdo, se coloca de soporte almohadas entre piernas, paciente estable dormida con buen patrón respiratorio.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
04/03/2026 04:00	se observa paciente tranquila sin ninguna novedad	BEHAINE GÓMEZ KAREN JULIETH
04/03/2026 05:00	se realiza cambio de pañal se limpia zona íntima con pañitos humedos se le coloca su respectivo pañal se le aplica crema antipañalitis para evitar lecciones de la Piel sin problema	BEHAINE GÓMEZ KAREN JULIETH
04/03/2026 06:00	se traslada paciente para la silla de ruedas para sus terapias con el fonodiologo acompañada de su familiar	BEHAINE GÓMEZ KAREN JULIETH
04/03/2026 07:00	Recibo paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO DX: secuelas de infarto cerebral,encefalopatía no especificada pielectas renal izquierda, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, crisis hepilepticas, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.	BEHAINE GÓMEZ KAREN JULIETH

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable dormida con buen patrón respiratorio presenta pequeños hematomas en miembros inferiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria, con barandas de seguridad elevadas en posición en Silla de ruedas.

Paciente estable desorientada en las 3 desferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO:
Paciente tolero por via oral medicamentos y alimentación, paciente estable tranquila.

OBSERVACIONES
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50pm, se administra una dosis adicional según orden médica.
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (++)
Deposición (-)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral ()
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal,(Se Realizo higiene bucal).
Recibe Aux- Adriana Beltrán

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

Entrega Aux- Karen Behaine

04/03/2026 07:00

Entrego paciente femenino, 57 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: secuelas de infarto cerebral,encefalopatía no especificada pielectas renal izquierda, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, crisis hepilepticas, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable despierta con buen patrón respiratorio presenta pequeños hematomas en miembros inferiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria, con barandas de seguridad elevadas en posición en posición decúbito supino.

Paciente estable desorientada en las 3 desferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO:
Paciente tolero por via oral medicamentos y alimentación, presentó depósitos semiliquido con trozos pequeños.
SE ADMINISTRO ACETAMINOFÉN 500MG POR VIA ORAL, PACIENTE TOLERA SIN COMPLICACION

OBSERVACIONES
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
* Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
* Pendiente cita psicóloga (Mayo)

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50pm, se administra una dosis adicional según orden médica.
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (++)
Deposición (+)

Karen Behaine

BEHAINE GÓMEZ KAREN JULIETH

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral (Desayuno, almuerzo)
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal,(Se Realizo higiene bucal, baño en silla poceta)

04/03/2026 07:10 Se realiza cambio de posición lateral izquierdo paciente estable dormida con buen patrón respiratorio.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

04/03/2026 07:31 se retira ropa bata y pongo ropa de vestir ropa, se realiza higiene facial y se peina paciente.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

04/03/2026 08:00 Se administra tableta losartan 50mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

04/03/2026 08:10 Se administra tableta Esomeprazol 20mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

04/03/2026 08:15 Se realizo higiene bucal con cepillo electrico y crema colgate y agua.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

04/03/2026 08:20 Se administra capsula Amantadina 100mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

04/03/2026 08:30 Se administra tableta Citicolina 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

04/03/2026 09:05 Se asiste a la hora del desayuno, proporcionándole una dieta sólida, se le da tiempo suficiente para que mastique y trague cada bocado, antes de ofrecerle el siguiente, tolera por via oral sin complicacion, paciente colaborador, apetito conservado.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

04/03/2026 11:30 Se administra tableta Ácido acetilsalicílico 100mg vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

04/03/2026 11:40 Se realiza traslado del paciente con ayuda de grúa hacia la silla poceta. Se lleva a cabo baño general, aplicando shampoo en cuero cabelludo y retirando con enjuague; posteriormente se aplica jabón líquido corporal, se enjuaga y se procede al secado completo de la piel. Finalizado el aseo, se traslada a la cama hospitalaria con apoyo de grúa. Se realiza secado cuidadoso de la región genital y glútea, aplicando crema con nistatina y crema Almipro. Se coloca pañal limpio y se viste con ropa limpia y adecuada. Durante el procedimiento, el paciente presentó episodios de nerviosismo.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

04/03/2026 13:00 Se administra Acido valproico 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

04/03/2026 13:00 Se administra Acido valproico 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

04/03/2026 14:05 Después del almuerzo se administra jarabe Escitalopram en solución oral, 20 cc, según indicación médica(psiquiatra) Tolera la administración por vía oral sin complicaciones, sin presencia de náuseas ni vómito, Paciente tranquila.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

04/03/2026 14:42 Se realiza higiene bucal con cepillo electrico y crema colgate y agua.
se realiza cambio de posición semiFowler paciente estable tranquila.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

04/03/2026 15:30 Se realiza cambio de posición lateral izquierdo, se coloca de soporte entre piernas almohadas, paciente estable dormida con buen patrón respiratorio.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

04/03/2026 17:00 Se realiza cambio de pañal empleando los elementos necesarios (pañal limpio, toallitas húmedas, crema antipañalitis, guantes de látex). Se asegura la cama hospitalaria contra la pared para aportar mayor seguridad al paciente durante el procedimiento.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

04/03/2026 17:25 Se traslada paciente en grúa a la silla de ruedas, se traslada paciente a la sala en compañia de los familiares. Se realiza tendido de cama garantizando limpieza y comodidad del paciente, dejando la superficie libre de arrugas.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

04/03/2026 18:12 Ingresa al domicilio el fonoaudiólogo particular Jhonathan Ibáñez, quien realiza terapia con electroestimulación y masajes en región cervical. Paciente se encuentra estable, tranquila y colaboradora durante el procedimiento.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

04/03/2026 19:00 Recibo paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: secuelas de infarto cerebral,encefalopatía no especificada pielectas renal izquierda, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, crisis hepilepticas, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable dormida con buen patrón respiratorio presenta pequeños hematomas en miembros inferiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria, con barandas de seguridad elevadas en posición decúbito dorsal.

Paciente estable desorientada en las 3 desferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

OBSERVACIONES
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
* Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
* Pendiente cita psicóloga (Mayo)

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50pm, se administra una dosis adicional según orden médica.
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

SIGNOS VITALES:
TA:120/60mmhg
Fc: 74x'
FR: 18×'
SPO2: 97%
T: 36.8°C

Recibe Aux- Lizeth Hernández
Entrega Aux- Adriana Beltrán

04/03/2026 19:00 Entrego paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: secuelas de infarto cerebral,encefalopatía no especificada pielectas renal izquierda, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, crisis hepilepticas, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

Adriana

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable dormida con buen patrón respiratorio presenta pequeños hematomas en miembros inferiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria, con barandas de seguridad elevadas en posición en Silla de ruedas.

Paciente estable desorientada en las 3 desferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO:
Paciente tolero por via oral medicamentos y alimentación, ingreso al domicilio fonoaudiologo particular Jhonathan Ibañez y familiar sobrina (Julia Angarita)

OBSERVACIONES
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50pm, se administra una dosis adicional según orden médica.
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (++)
Deposición (-)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral (desayuno, almuerzo)
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal,(Se Realizo higiene bucal, baño en silla de poceta).

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

Entrega Aux-Adriana Beltrán
Recibe Aux- lizceth hernadez.

04/03/2026 19:19	se recibe induccion por parte de la auxiliar de turno adriana beltran.	HERNANDEZ DELGADO LIZETH
04/03/2026 20:00	Se administra tableta losartan 50mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	HERNANDEZ DELGADO LIZETH
04/03/2026 20:10	Se administra tableta Amlodipino 5mg vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	HERNANDEZ DELGADO LIZETH
04/03/2026 20:20	Se administra capsula Amantadina 100mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	HERNANDEZ DELGADO LIZETH
04/03/2026 20:30	Se administra tableta Citicolina 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	HERNANDEZ DELGADO LIZETH
04/03/2026 20:50	Se administra dos cápsulas de Ácido valproico 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	HERNANDEZ DELGADO LIZETH
04/03/2026 21:00	Se administra Quetiapina 200mg, mas dos tabletas Quetiapina 25mg un total administrados 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	HERNANDEZ DELGADO LIZETH
04/03/2026 21:30	Se realiza cambio de posición a la paciente se lubrica la piel con crema se realiza masaje y ejercicio de flexión y estiramiento sin complicaciones se observa a la paciente tranquila con buen patrón respiratorio sin cambios en su estado general	HERNANDEZ DELGADO LIZETH
04/03/2026 22:00	Se le da dieta corriente cena a la paciente, paciente recibe y tolera sin complicaciones	HERNANDEZ DELGADO LIZETH
04/03/2026 23:40	Se realiza a la paciente comodidad y confort se realiza cambio de pañal y se realiza aseo genital aplicando cremas antidermatitis y antiulceras sin complicaciones se deja pañal limpio se observa paciente con buen patrón respiratorio sin cambios en su estado general	

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

05/03/2026 00:30	se observa a la paciente dormida tranquila afebril con buen patrón respiratorio sin cambios en su estado genera	HERNANDEZ DELGADO LIZETH
05/03/2026 02:30	se observa a la paciente dormida tranquila afebril con buen patrón respiratorio sin cambios en su estado general	HERNANDEZ DELGADO LIZETH
05/03/2026 04:00	Se realiza cambio de posición a la paciente se lubrica la piel con crema se realiza masaje y ejercicio de flexión y estiramiento sin complicaciones se observa a la paciente tranquila con buen patrón respiratorio sin cambios en su estado general	HERNANDEZ DELGADO LIZETH
05/03/2026 05:00	Se administra Acido valproico 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	HERNANDEZ DELGADO LIZETH
05/03/2026 06:00	Se realiza a la paciente comodidad y confort se realiza cambio de pañal y se realiza aseo genital aplicando cremas antidermatitis y antiulceras sin complicaciones se deja pañal limpio se observa paciente con buen patrón respiratorio sin cambios en su estado general	HERNANDEZ DELGADO LIZETH
05/03/2026 07:00	Entrego paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO DX: secuelas de infarto cerebral,encefalopatía no especificada pielectas renal izquierda, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, crisis hepilepticas, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida. Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable dormida con buen patrón respiratorio presenta pequeños hematomas en miembros inferiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes. Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria, con barandas de seguridad elevadas en posición decúbito dorsal posición semiflower. Paciente estable desorientada en las 3 desferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica, Ojos normoreactivos a la luz, Mucosa nasal húmeda sin laceraciones, Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis). NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO:	HERNANDEZ DELGADO LIZETH

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

Paciente tolero por via oral medicamentos, Concilio sueño temprano.

OBSERVACIONES
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
* Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
* Pendiente cita psicóloga (Mayo)

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50pm, se administra una dosis adicional según orden médica.
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (++)
Deposición (+)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral (Cena)
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal,(Se Realizo limpieza bucal)

SIGNOS VITALES:
TA:120/80mmhg
Fc: 84x'
FR: 18×'
SPO2: 97%
T: 36.5°C

05/03/2026 07:00

Recibo paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: secuelas de infarto cerebral,encefalopatía no especificada pielectas renal izquierda, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, crisis hepilepticas, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable dormida con buen patrón respiratorio presenta pequeños hematomas en miembros inferiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria, con barandas de seguridad elevadas en posición en Silla de ruedas.

Paciente estable desorientada en las 3 desferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO:
Paciente tolero por via oral medicamentos, Concilio sueño temprano.

OBSERVACIONES
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50pm, se administra una dosis adicional según orden médica.
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (++)
Deposición (+)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral (Cena)
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal,(Se Realizo higiene bucal)

SIGNOS VITALES:
TA:110/60mmhg
Fc: 82x'
FR: 17×'
SPO2: 96%
T: 36.5°C .
Recibe Aux- Adriana Beltrán
Entrega Aux- lizeth Hernandez

05/03/2026 08:00 Se administra tableta losartan 50mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

05/03/2026 08:10	Se administra tableta Esomeprazol 20mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
05/03/2026 08:20	Se administra capsula Amantadina 100mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
05/03/2026 08:30	Se administra tableta Citicolina 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
05/03/2026 08:35	Se hace acompañamiento y supervisa el desarrollo de las terapia realizada por el Fisioterapeuta partículas (Andrés Rodríguez).Realiza terapias de estiramiento en cama y postura en posición sentado, paciente permanece nerviosa signos de dificultad irritabilidad, inquietud, llanto, paciente tolera las terapias.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
05/03/2026 10:44	Ingresa al domicilio jefe de ruta Sledy tolera, hace toma de fotos al domicilio, medicamentos, canecas, al baño y al armario ,hace observacion sobre la fuga del agua(se le informa al familiar) hace preguntas evaluativas. firmamento tanto como familiar y auxiliar de turno compromiso. No hizo revisión a la paciente motivo por que estaba la paciente en terapias con en fisioterapeuta particular Andrés Rodríguez.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
05/03/2026 10:48	Se asiste a la hora del desayuno, proporcionándole una dieta sólida, se le da tiempo suficiente para que mastique y trague cada bocado, antes de ofrecerle el siguiente, tolera por via oral sin complicacion, paciente colaborador, apetito conservado.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
05/03/2026 11:30	Se administra tableta Ácido acetilsalicílico 100mg vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
05/03/2026 12:00	Se realiza cambio de posición semiFowler, paciente estable tranquila.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
05/03/2026 12:24	Se hace arreglo en los medicamentos, en tocador de la paciente, se hace asepsia y antiasepsia entorno del tocador.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
05/03/2026 13:00	Se administra Acido valproico 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

05/03/2026 13:55	Se asiste a la hora del almuerzo, proporcionándole una dieta sólida, se le da tiempo suficiente para que mastique y trague cada bocado, antes de ofrecerle el siguiente, tolera por via oral sin complicacion, paciente colaborador, apetito conservado.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
05/03/2026 13:55	Después del almuerzo se administra jarabe Escitalopram en solución oral, 20 cc, según indicación médica(psiquiatra) Tolera la administración por vía oral sin complicaciones, sin presencia de náuseas ni vómito, Paciente tranquila.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
05/03/2026 14:30	Se realiza traslado del paciente con ayuda de grúa hacia la silla poceta. Se lleva a cabo baño general, aplicando shampoo en cuero cabelludo y retirando con enjuague; posteriormente se aplica jabón líquido corporal, se enjuaga y se procede al secado completo de la piel. Finalizado el aseo, se traslada a la cama hospitalaria con apoyo de grúa. Se realiza secado cuidadoso de la región genital y glútea, aplicando crema con nistatina y crema Almipro. Se coloca pañal limpio y se viste con ropa limpia y adecuada. Durante el procedimiento, el paciente presentó episodios de nerviosismo.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
05/03/2026 14:45	Se realiza tendido de cama hospitalaria con cambio de sábanas, garantizando condiciones óptimas de higiene y confort para el paciente, dejando la superficie lisa y libre de arrugas.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
05/03/2026 15:30	se aplica crema corporal los miembros superiores y inferiores.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
05/03/2026 15:35	Se realiza cambio de posición en cama, colocando al paciente en decúbito derecho . Se garantiza alineación corporal adecuada y extendido de sábana sin arrugas, favorecer comodidad y prevenir lesiones por presión. Paciente permanece estable, dormida.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
05/03/2026 16:40	Se asiste a la hora de la media tarde dieta sólida y líquida, paciente tolera ingiere, por via oral sin complicacion.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
05/03/2026 16:45	Se realiza higiene bucal con cepillo electrico y crema colgate y agua.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
05/03/2026 17:00	Se realiza aseo y organización de la unidad del paciente en domicilio, tocador, organizador de medicamentos.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
05/03/2026 18:43	Se realiza cambio de pañal empleando los elementos necesarios (pañal limpio, toallitas húmedas, crema antipañalitis, guantes de látex). Se asegura la cama hospitalaria contra la pared para aportar mayor seguridad al paciente durante el procedimiento.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

05/03/2026 19:00

Entrego paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: secuelas de infarto cerebral,encefalopatía no especificada pielectas renal izquierda, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, crisis hepilepticas, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable dormida con buen patrón respiratorio presenta pequeños hematomas en miembros inferiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria, con barandas de seguridad elevadas en posición lateral izquierdo.

Paciente estable desorientada en las 3 desferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO:
Paciente tolero por via oral medicamentos, alimentación, Ingreso al domicilio fisioterapeuta particular Andrés Rodríguez, y jefe de ruta de la ips clinical house. Se realizo limpieza orden medicamentos.

OBSERVACIONES
• Dentro del domicilio Se observo hace tiempo fuga en el baño donde se baña la paciente, familiar niega que las auxiliares no avisaron.
• Dentro del domicilio Se observa hace tiempo material mecánicos, a fuera llenos de polvo y mugre.(a Jefe de ruta ordeno cerrar las ventan que va directo del paciente).
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50pm, se administra una dosis adicional según orden médica.
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (++)
Deposición (-)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral (desayuno, almuerzo)
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal,(Se Realizo higiene bucal, baño en silla poceta).
Entrego Aux- Adriana Beltrán
Recibe Aux- lizeth Hernandez

05/03/2026 19:00

Entrego paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: secuelas de infarto cerebral,encefalopatía no especificada pielectas renal izquierda, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, crisis hepilepticas, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable dormida con buen patrón respiratorio presenta pequeños hematomas en miembros inferiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria, con barandas de seguridad elevadas en posición lateral izquierdo.

Paciente estable desorientada en las 3 desferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO:
Paciente tolero por via oral medicamentos, alimentación, Ingreso al domicilio fisioterapeuta particular Andrés Rodríguez, y jefe de ruta de la ips clinical house. Se realizo limpieza orden medicamentos.

OBSERVACIONES
• Dentro del domicilio Se observo hace tiempo fuga en el baño donde se baña la paciente, familiar niega que las auxiliares no avisaron.
• Dentro del domicilio Se observa hace tiempo material mecánicos, a fuera llenos de polvo y mugre.(a Jefe de ruta ordeno cerrar las ventan que va directo del paciente).
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50pm, se administra una dosis adicional según orden médica.
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (++)
Deposición (-)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral (desayuno, almuerzo)
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal,(Se Realizo higiene bucal, baño en silla poceta).
Entrego Aux- Adriana Beltrán
Recibe Aux- lizeth Hernandez

05/03/2026 19:00

Recibo paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: secuelas de infarto cerebral,encefalopatía no especificada pielectas renal izquierda, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, crisis hepilepticas, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable dormida con buen patrón respiratorio presenta pequeños hematomas en miembros inferiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria, con barandas de seguridad elevadas en posición decúbito dorsal.

Paciente estable desorientada en las 3 desferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

OBSERVACIONES
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)

ALERGICOS: DIPIRONA

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50pm, se administra una dosis adicional según orden médica.
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

SIGNOS VITALES:
TA:120/60mmhg
Fc: 74x'
FR: 18×'
SPO2: 97%
T: 36.8°C

Recibe Aux- Lizeth Hernández
Entrega Aux- Adriana Beltrán

05/03/2026 20:00	Se administra tableta losartan 50mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	HERNANDEZ DELGADO LIZETH
05/03/2026 20:10	Se administra tableta Amlodipino 5mg vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	HERNANDEZ DELGADO LIZETH
05/03/2026 20:20	Se administra capsula Amantadina 100mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	HERNANDEZ DELGADO LIZETH
05/03/2026 20:30	Se administra tableta Citicolina 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	HERNANDEZ DELGADO LIZETH
05/03/2026 20:35	Se le da dieta corriente a la paciente, paciente recibe y tolera sin complicaciones	HERNANDEZ DELGADO LIZETH
05/03/2026 20:50	Se administra dos cápsulas de Ácido valproico 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	HERNANDEZ DELGADO LIZETH
05/03/2026 21:00	Se administra Quetiapina 200mg, mas dos tabletas Quetiapina 25mg un total administrados 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

05/03/2026 21:15	Se realiza cambio de posición a la paciente se lubrica la piel con crema se realiza masaje y ejercicio de flexión y estiramiento sin complicaciones se observa a la paciente tranquila con buen patrón respiratorio sin cambios en su estado general	HERNANDEZ DELGADO LIZETH
05/03/2026 22:15	Se realiza a la paciente comodidad y confort se realiza cambio de pañal y se realiza aseo genital aplicando cremas antidermatitis y antiulceras sin complicaciones se deja pañal limpio se observa paciente con buen patrón respiratorio sin cambios en su estado general	HERNANDEZ DELGADO LIZETH
05/03/2026 23:30	se observa a la paciente dormida tranquila afebril con buen patrón respiratorio sin cambios en su estado general	HERNANDEZ DELGADO LIZETH
06/03/2026 01:46	se observa a la paciente dormida tranquila afebril con buen patrón respiratorio sin cambios en su estado general	HERNANDEZ DELGADO LIZETH
06/03/2026 04:24	Se realiza cambio de posición a la paciente se lubrica la piel con crema se realiza masaje y ejercicio de flexión y estiramiento sin complicaciones se observa a la paciente tranquila con buen patrón respiratorio sin cambios en su estado general	HERNANDEZ DELGADO LIZETH
06/03/2026 05:05	05 : 00 AM Se administra Acido valproico 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	HERNANDEZ DELGADO LIZETH
06/03/2026 06:40	Se realiza cambio de posición a la paciente se lubrica la piel con crema se realiza masaje y ejercicio de flexión y estiramiento sin complicaciones se observa a la paciente tranquila con buen patrón respiratorio sin cambios en su estado general.	HERNANDEZ DELGADO LIZETH
06/03/2026 07:00	Recibo paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO DX: secuelas de infarto cerebral,encefalopatía no especificada pielectas renal izquierda, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, crisis hepilepticas, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida. Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable dormida con buen patrón respiratorio presenta pequeños hematomas en miembros inferiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes. Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria, con barandas de seguridad elevadas en posición decúbito dorsal semiflower. Paciente estable desorientada en las 3 desferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO:
Paciente tolero por via oral medicamentos, Concilio sueño temprano.

OBSERVACIONES
Dentro del domicilio Se observo hace tiempo fuga en el baño donde se baña la paciente, familiar niega que las auxiliares no avisaron.
• Dentro del domicilio Se observa hace tiempo material mecánicos, a fuera llenos de polvo y mugre.(a Jefe de ruta ordeno cerrar las ventan que va directo del paciente).
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50pm, se administra una dosis adicional según orden médica.
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (++)
Deposición (+)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral (cena)
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal,(Se Realizo limpieza bucal).
Recibe Aux- Adriana Beltrán
Entrega Aux- lizeth Hernandez

06/03/2026 07:00

Entrego paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: secuelas de infarto cerebral,encefalopatía no especificada pielectas renal izquierda, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, crisis hepilepticas, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez),

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable dormida con buen patrón respiratorio presenta pequeños hematomas en miembros inferiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria, con barandas de seguridad elevadas en posición decúbito dorsal posición semiflower.

Paciente estable desorientada en las 3 desferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO:
Paciente tolero por via oral medicamentos, Concilio sueño temprano.

OBSERVACIONES
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50pm, se administra una dosis adicional según orden médica.
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (++)
Deposición (+)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral (Cena)
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal,(Se Realizo limpieza bucal)

SIGNOS VITALES:
TA:120/80mmhg

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

Fc: 84x'
FR: 18×'
SPO2: 97%
T: 36.5°C

Recibe Aux- Adriana Beltrán
Entrega Aux- lizeth Hernandez

06/03/2026 07:00

Entrego paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: secuelas de infarto cerebral,encefalopatía no especificada pielectas renal izquierda, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, crisis hepilepticas, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable dormida con buen patrón respiratorio presenta pequeños hematomas en miembros inferiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria, con barandas de seguridad elevadas en posición decúbito dorsal posición semiflower.

Paciente estable desorientada en las 3 desferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO:
Paciente tolero por via oral medicamentos, Concilio sueño temprano.

OBSERVACIONES
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50pm, se administra una dosis adicional según orden médica.
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (++)
Deposición (+)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral (Cena)
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal,(Se Realizo limpieza bucal)

SIGNOS VITALES:
TA:120/80mmhg
Fc: 84x'
FR: 18×'
SPO2: 97%
T: 36.5°C

Recibe Aux- Adriana Beltrán
Entrega Aux- lizeth Hernandez

06/03/2026 07:20 Se realiza higiene bucal con cepillo electrico y crema colgate y agua.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

06/03/2026 08:00 Se administra tableta losartan 50mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

06/03/2026 08:10 Se administra tableta Esomeprazol 20mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

06/03/2026 08:20 Se administra capsula Amantadina 100mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

06/03/2026 08:30 Se administra tableta Citicolina 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

06/03/2026 09:15 Se asiste a la hora del desayuno, proporcionándole una dieta sólida, se le da tiempo suficiente para que mastique y trague cada bocado, antes de ofrecerle el siguiente, tolera por via oral sin complicacion, paciente colaborador, apetito conservado.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

06/03/2026 10:35 Se realiza traslado del paciente con ayuda de grúa hacia la silla poceta. Se lleva a cabo baño general, aplicando shampoo en cuero cabelludo y retirando con enjuague; posteriormente se aplica jabón líquido corporal, se enjuaga y se procede al secado completo de la piel. Finalizado el aseo, se traslada a la cama hospitalaria con apoyo de grúa. Se realiza secado cuidadoso de la región genital y glútea, aplicando crema con nistatina y crema Almipro. Se coloca pañal limpio y se viste con ropa limpia y adecuada. Durante el procedimiento, el paciente presentó episodios de nerviosismo.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

06/03/2026 11:30	Se administra tableta Ácido acetilsalicílico 100mg vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
06/03/2026 13:00	Se administra Acido valproico 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
06/03/2026 13:20	Se asiste a la hora del almuerzo, proporcionándole una dieta sólida, se le da tiempo suficiente para que mastique y trague cada bocado, antes de ofrecerle el siguiente, tolera por via oral sin complicacion, paciente colaborador, apetito conservado.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
06/03/2026 13:45	Después del almuerzo se administra jarabe Escitalopram en solución oral, 20 cc, según indicación médica(psiquiatra) Tolera la administración por vía oral sin complicaciones, sin presencia de náuseas ni vómito, Paciente tranquila.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
06/03/2026 14:45	Se realiza higiene bucal con cepillo electrico y crema colgate y agua. Se realiza cambio de posición lateral izquierdo paciente estable y tranquila.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
06/03/2026 16:25	Se asiste a la hora de la media tarde dieta blanda , proporcionándole una dieta sólida, se le da tiempo suficiente para que mastique y trague cada bocado, antes de ofrecerle el siguiente, tolera por via oral sin complicacion, paciente colaborador, apetito conservado.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
06/03/2026 16:44	Se realiza aseo y organización de la unidad del paciente en domicilio, incluyendo limpieza de cama, colchón, barandas y superficie del entorno inmediato.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
06/03/2026 17:30	Se realiza cambio de pañal empleando los elementos necesarios (pañal limpio, toallitas húmedas, crema antipañalitis, guantes de látex). Se asegura la cama hospitalaria contra la pared para aportar mayor seguridad al paciente durante el procedimiento. Se traslada paciente en grúa a la silla de ruedas y se traslada a la sala.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
06/03/2026 18:10	Ingresa al domicilio el fonoaudiólogo particular Jhonathan Ibáñez, quien realiza terapia con electroestimulación y masajes en región cervical. Paciente se encuentra estable, tranquila y colaboradora durante el procedimiento.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
06/03/2026 19:00	Recibo paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO DX: Encefalopatia hipoxica,crisis epilépticas, cuadriplejia flácida y polineuropatia no especificada, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.	

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable tranquila presenta pequeños hematomas en miembros inferiores y superiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria, con barandas de seguridad elevadas en silla de ruedas.

Paciente estable desorientada en las 3 esferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

OBSERVACIONES
Dentro del domicilio Se observo hace tiempo fuga en el baño donde se baña la paciente, familiar niega que las auxiliares no avisaron.
• Dentro del domicilio Se observa hace tiempo material mecánicos, a fuera llenos de polvo y mugre.(a Jefe de ruta ordeno cerrar las ventan que va directo del paciente).
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)
• Pendiente terapias fisioterapeuta
• pendiente terapias ocupacional
•Pendiente terapias fonoaudiologo

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50pm, se administra una dosis adicional según orden médica.
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral (Desayuno,almuerzo)
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal,(Se Realizo limpieza bucal, baño en silla poceta)

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

SIGNOS VITALES:
TA:110/70 mmhg
Fc: 84 x'
FR:17 ×'
SPO2: 96%
T:36.8°C

Entrega Aux- Adriana Beltrán
Recibe Aux- Lizeth Hernández

06/03/2026 19:00

Entrego paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: Encefalopatia hipoxica,crisis epilépticas, cuadriplejia flácida y polineuropatia no especificada, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable tranquila presenta pequeños hematomas en miembros inferiores y superiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria, con barandas de seguridad elevadas en silla de ruedas.

Paciente estable desorientada en las 3 esferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO:
Paciente tolero por via oral medicamentos, Ingreso al domicilio fonoaudiologo particular Jhonathan Ibañez.

OBSERVACIONES
Dentro del domicilio Se observo hace tiempo fuga en el baño donde se baña la paciente, familiar niega que las auxiliares no avisaron.
• Dentro del domicilio Se observa hace tiempo material mecánicos, a fuera llenos de polvo y mugre.(a Jefe de ruta ordeno cerrar las ventan que va directo del paciente).
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)
• Pendiente terapias fisioterapeuta
• pendiente terapias ocupacional
•Pendiente terapias fonoaudiologo

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50pm, se administra una dosis adicional según orden médica.
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (++)
Deposición (-)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral (Desayuno,almuerzo)
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal,(Se Realizo limpieza bucal, baño en silla poceta).
Entrega Aux- Adriana Beltrán
Recibe Aux- lizeth Hernandez

06/03/2026 20:00 Se administra tableta losartan 50mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

06/03/2026 20:08 Paciente recibe y tolera dieta corriente sin complicaciones se asiste en la alimentación se observa paciente sin cambios en su estado general

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

06/03/2026 20:20 Se administra capsula Amantadina 100mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

06/03/2026 20:30 Se administra tableta Citicolina 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

06/03/2026 20:50 Se administra dos cápsulas de Ácido valproico 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

06/03/2026 21:00 Se administra Quetiapina 200mg, mas dos tabletas Quetiapina 25mg un total administrados 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

06/03/2026 21:00 Se administra Quetiapina 200mg, mas dos tabletas Quetiapina 25mg un total administrados 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

06/03/2026 22:30

Se realiza cambio de posición a la paciente se lubrica la piel con crema se realiza masaje y ejercicio de flexión y estiramiento sin complicaciones se observa a la paciente tranquila con buen patrón respiratorio sin cambios en su estado general

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

06/03/2026 22:30

Se realiza cambio de posición a la paciente se lubrica la piel con crema se realiza masaje y ejercicio de flexión y estiramiento sin complicaciones se observa a la paciente tranquila con buen patrón respiratorio sin cambios en su estado general

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

06/03/2026 23:25

Se realiza a la paciente comodidad y confort se realiza cambio de pañal y se realiza aseo genital aplicando cremas antidermatitis y antiulceras sin complicaciones se deja pañal limpio se observa paciente con buen patrón respiratorio sin cambios en su estado general

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

07/03/2026 01:09

se observa a la paciente dormida tranquila afebril con buen patrón respiratorio sin cambios en su estado general

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

07/03/2026 02:44

se observa a la paciente dormida tranquila afebril con buen patrón respiratorio sin cambios en su estado general

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

07/03/2026 05:01

Se administra Acido valproico 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

07/03/2026 06:15

Se realiza cambio de posición a la paciente se lubrica la piel con crema se realiza masaje y ejercicio de flexión y estiramiento sin complicaciones se observa a la paciente tranquila con buen patrón respiratorio sin cambios en su estado general

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

07/03/2026 06:45

Se realiza a la paciente comodidad y confort se realiza cambio de pañal y se realiza aseo genital aplicando cremas antidermatitis y antiulceras sin complicaciones se deja pañal limpio se observa paciente con buen patrón respiratorio sin cambios en su estado general

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

07/03/2026 07:00

Entrego paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: Encefalopatia hipoxica,crisis epilépticas, cuadriplejia flácida y polineuropatia no especificada, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable tranquila presenta pequeños hematomas en miembros inferiores y superiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria, con barandas de seguridad elevadas en silla de ruedas.

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

Paciente estable desorientada en las 3 esferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO:
Paciente tolero por via oral tolero medicamentos, durmió tranquila paso buen noche.

OBSERVACIONES
Dentro del domicilio Se observo hace tiempo fuga en el baño donde se baña la paciente, familiar niega que las auxiliares no avisaron.
• Dentro del domicilio Se observa hace tiempo material mecánicos, a fuera llenos de polvo y mugre.(a Jefe de ruta ordeno cerrar las ventan que va directo del paciente).
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)
• Pendiente terapias fisioterapeuta
• pendiente terapias ocupacional
•Pendiente terapias fonoaudiologo

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50pm, se administra una dosis adicional según orden médica.
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (++)
Deposición (-)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral (Cena)
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal.

SIGNOS VITALES:
TA:110/70 mmhg

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

Fc: 82 x'
FR:17 x'
SPO2: 98%
T:36.7°C

Entrega Aux- Lizeth Hernández
Recibe Aux- Adriana Beltrán

07/03/2026 07:00

Recibo paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: Encefalopatia hipoxica,crisis epilépticas, cuadriplejia flácida y polineuropatia no especificada, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable tranquila presenta pequeños hematomas en miembros inferiores y superiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria, con barandas de seguridad elevadas en posición semiflower

Paciente estable desorientada en las 3 esferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO:
Paciente tolero por via oral tolero medicamentos, durmió tranquila paso buen noche.

OBSERVACIONES
Dentro del domicilio Se observo hace tiempo fuga en el baño donde se baña la paciente, familiar niega que las auxiliares no avisaron.
• Dentro del domicilio Se observa hace tiempo material mecánicos, a fuera llenos de polvo y mugre.(a Jefe de ruta ordeno cerrar las ventan que va directo del paciente).
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)
• Pendiente terapias fisioterapeuta
• pendiente terapias ocupacional
•Pendiente terapias fonoaudiologo

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50pm, se administra una dosis adicional según orden médica.
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (++)
Deposición (-)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral (Cena)
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal.
Recibe Aux- Adriana Beltrán
Entrega Aux- lizeth Hernandez

07/03/2026 07:22 Se retiran bata y se realiza lubricación de la piel con crema corporal. Posteriormente, se coloca ropa limpia y seca, paciente estable con ropa limpia piel hidratada, permanece en cama hospitalaria bajo vigilancia y acompañamiento. Se realiza higiene bucal con cepillo electrico y crema colgate y agua, realizo limpieza facial.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

07/03/2026 08:00 Se administra tableta losartan 50mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

07/03/2026 08:10 Se administra tableta Esomeprazol 20mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

07/03/2026 08:20 Se administra capsula Amantadina 100mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

07/03/2026 08:25 Se asiste a la hora del desayuno, proporcionándole una dieta sólida, se le da tiempo suficiente para que mastique y trague cada bocado, antes de ofrecerle el siguiente, tolera por via oral sin complicacion, paciente colaborador, apetito conservado.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

07/03/2026 08:35 Se administra tableta Citicolina 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

07/03/2026 08:55 Se hace acompañamiento y supervisa el desarrollo de las terapia realizada por el Fisioterapeuta partículas (Andrés Rodríguez).Realiza terapias de estiramiento en cama y postura en posición sentado, se utilizo grúa, paciente permanece nerviosa signos de dificultad irritabilidad, inquietud, llanto, paciente tolera las terapias.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

07/03/2026 09:00 Se administra Quetiapina 200mg, mas dos tabletas Quetiapina 25mg un total administrados 250mg por vía oral,

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

	paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	HERNANDEZ DELGADO LIZETH
07/03/2026 09:59	Se realiza cambio de sábanas garantizando limpieza y comodidad del paciente, dejando la superficie libre de arrugas, se procede a realiza cambio de pañal empleando los elementos necesarios (pañal limpio, toallitas húmedas, crema antipañalitis, guantes de látex). Se asegura la cama hospitalaria contra la pared para aportar mayor seguridad al paciente.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
07/03/2026 10:05	Se realiza cambio de posición lateral izquierdo se coloca de soporte almohadas, paciente estable y tranquila.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
07/03/2026 11:30	Se administra tableta Ácido acetilsalicílico 100mg vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
07/03/2026 13:00	Se administra Acido valproico 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
07/03/2026 14:48	Se asiste a la hora del almuerzo, proporcionándole una dieta sólida, se le da tiempo suficiente para que mastique y trague cada bocado, antes de ofrecerle el siguiente, tolera por via oral sin complicacion, paciente colaborador, apetito conservado.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
07/03/2026 14:49	Después del almuerzo se administra jarabe Escitalopram en solución oral, 20 cc, según indicación médica(psiquiatra) Tolera la administración por vía oral sin complicaciones, sin presencia de náuseas ni vómito, Paciente tranquila.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
07/03/2026 14:54	Se realiza higiene bucal con cepillo electrico y crema colgate y agua.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
07/03/2026 16:00	Se realiza traslado del paciente con ayuda de grúa hacia la silla poceta. Se lleva a cabo baño general, aplicando shampoo en cuero cabelludo y retirando con enjuague; posteriormente se aplica jabón líquido corporal, se enjuaga y se procede al secado completo de la piel. Finalizado el aseo, se traslada a la cama hospitalaria con apoyo de grúa. Se realiza secado cuidadoso de la región genital y glútea, aplicando crema con nistatina y crema Almipro. Se coloca pañal limpio y se viste pijama limpia. Durante el procedimiento, el paciente presentó episodios de nerviosismo.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
07/03/2026 16:42	Se aplica crema después del baño (Betametafona +Clotrimazol+ Neomocina) Parte de la espalda y hombros.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

07/03/2026 18:45

Se realiza aseo y organización de la unidad del paciente en domicilio, incluyendo limpieza de cama, colchón, barandas y superficie del entorno inmediato.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

07/03/2026 19:00

Entrego paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: Encefalopatia hipoxica,crisis epilépticas, cuadriplejia flácida y polineuropatia no especificada, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable tranquila presenta pequeños hematomas en miembros inferiores y superiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria, con barandas de seguridad elevadas en posición semiflower

Paciente estable desorientada en las 3 esferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO:
Paciente tolero por via oral medicamentos y alimentos, Ingreso al domicilio fisioterapeuta particular Andrés Rodríguez.

OBSERVACIONES
Dentro del domicilio Se observo hace tiempo fuga en el baño donde se baña la paciente, familiar niega que las auxiliares no avisaron.
• Dentro del domicilio Se observa hace tiempo material mecánicos, a fuera llenos de polvo y mugre.(a Jefe de ruta ordeno cerrar las ventan que va directo del paciente).
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)
• Pendiente terapias fisioterapeuta
• pendiente terapias ocupacional
•Pendiente terapias fonoaudiologo

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50pm, se administra una dosis adicional según orden médica.
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (++)
Deposición (-)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral (Desayuno,almuerzo)
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal.

Entrega Aux- Adriana Beltrán
Recibe Aux- lizeth Hernandez

07/03/2026 19:00

Recibo paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: Encefalopatia hipoxica,crisis epilépticas, cuadriplejia flácida y polineuropatia no especificada, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable tranquila presenta pequeños hematomas en miembros inferiores y superiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria, con barandas de seguridad elevadas en silla de ruedas.

Paciente estable desorientada en las 3 esferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

OBSERVACIONES
Dentro del domicilio Se observo hace tiempo fuga en el baño donde se baña la paciente, familiar niega que las auxiliares no avisaron.
• Dentro del domicilio Se observa hace tiempo material mecánicos, a fuera llenos de polvo y mugre.(a Jefe de ruta ordeno cerrar las ventan que va directo del paciente).
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)
• Pendiente terapias fisioterapeuta

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

• pendiente terapias ocupacional
•Pendiente terapias fonoaudiologo

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50pm, se administra una dosis adicional según orden médica.
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

SIGNOS VITALES:
TA:120/80 mmhg
Fc: 80 x'
FR:18 ×'
SPO2: 97 %
T:36.5 °C

Entrega Aux- Adriana Beltrán
Recibe Aux- Lizeth Hernández

07/03/2026 19:45 Paciente recibe y tolera dieta corriente sin complicaciones se asiste en la alimentación se observa paciente sin cambios en su estado general

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

07/03/2026 20:00 Se administra tableta losartan 50mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

07/03/2026 20:20 Se administra capsula Amantadina 100mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

07/03/2026 20:20 Se administra capsula Amantadina 100mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

07/03/2026 20:30 Se administra tableta Citicolina 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

07/03/2026 20:50 Se administra dos cápsulas de Ácido valproico 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

07/03/2026 21:00 Se administra Quetiapina 200mg, mas dos tabletas Quetiapina 25mg un total administrados 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

07/03/2026 22:20 Se realiza a la paciente comodidad y confort se realiza cambio de pañal y se realiza aseo genital aplicando cremas antidermatitis y antiulceras sin complicaciones se deja pañal limpio se observa paciente con buen patrón respiratorio sin cambios en su estado general

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

07/03/2026 23:40 Se realiza cambio de posición a la paciente se lubrica la piel con crema se realiza masaje y ejercicio de flexión y estiramiento sin complicaciones se observa a la paciente tranquila con buen patrón respiratorio sin cambios en su estado general

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

08/03/2026 02:10 se observa a la paciente dormida tranquila afebril con buen patrón respiratorio sin cambios en su estado general

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

08/03/2026 03:20 Se realiza cambio de posición a la paciente se lubrica la piel con crema se realiza masaje y ejercicio de flexión y estiramiento sin complicaciones se observa a la paciente tranquila con buen patrón respiratorio sin cambios en su estado general

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

08/03/2026 05:00 Se administra Acido valproico 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

08/03/2026 06:10 Se realiza cambio de posición a la paciente se lubrica la piel con crema se realiza masaje y ejercicio de flexión y estiramiento sin complicaciones se observa a la paciente tranquila con buen patrón respiratorio sin cambios en su estado general.
Se realiza a la paciente comodidad y confort se realiza cambio de pañal y se realiza aseo genital aplicando cremas antidermatitis y antiulceras sin complicaciones se deja pañal limpio se observa paciente con buen patrón respiratorio sin cambios en su estado general

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

08/03/2026 07:00 Recibo paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: Encefalopatia hipoxica,crisis epilépticas, cuadriplejia flácida y polineuropatia no especificada, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable tranquila presenta pequeños hematomas en miembros inferiores y superiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria, con barandas de seguridad elevadas en silla de ruedas.

Paciente estable desorientada en las 3 esferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO:
Paciente tolero por via oral tolero medicamentos, durmió tranquila paso buen noche.

OBSERVACIONES
Dentro del domicilio Se observo hace tiempo fuga en el baño donde se baña la paciente, familiar niega que las auxiliares no avisaron.
• Dentro del domicilio Se observa hace tiempo material mecánicos, a fuera llenos de polvo y mugre.(a Jefe de ruta ordeno cerrar las ventan que va directo del paciente).
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)
• Pendiente terapias fisioterapeuta
• pendiente terapias ocupacional
•Pendiente terapias fonoaudiologo

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50pm, se administra una dosis adicional según orden médica.
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (++)
Deposición (-)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral (Cena)
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal.
Entrega Aux- Lizeth Hernández
Recibe Aux- Adriana Beltrán

08/03/2026 07:27 se observa a la paciente dormida tranquila afebril con buen patrón respiratorio sin cambios en su estado general.

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

08/03/2026 08:00	Se administra tableta losartan 50mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
08/03/2026 08:10	Se administra tableta Esomeprazol 20mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
08/03/2026 08:20	Se administra capsula Amantadina 100mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
08/03/2026 09:15	Se asiste a la hora del desayuno, proporcionándole una dieta sólida, se le da tiempo suficiente para que mastique y trague cada bocado, antes de ofrecerle el siguiente, tolera por via oral sin complicacion, paciente colaborador, apetito conservado.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
08/03/2026 09:30	Se administra tableta Citicolina 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
08/03/2026 10:15	Se realiza traslado del paciente con ayuda de grúa hacia la silla poceta. Se lleva a cabo baño general, aplicando shampoo en cuero cabelludo y retirando con enjuague; posteriormente se aplica jabón líquido corporal, se enjuaga y se procede al secado completo de la piel. Finalizado el aseo, se traslada a la cama hospitalaria con apoyo de grúa. Se realiza secado cuidadoso de la región genital y glútea, aplicando crema con nistatina y crema Almipro. Se coloca pañal limpio y se viste con ropa limpia y adecuada. Durante el procedimiento, el paciente presentó episodios de nerviosismo.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
08/03/2026 11:30	Se administra tableta Ácido acetilsalicílico 100mg vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
08/03/2026 13:00	Se administra Acido valproico 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
08/03/2026 13:00	Se administra Acido valproico 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
08/03/2026 13:00	Se administra Acido valproico 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

08/03/2026 14:05	Se asiste a la hora del almuerzo, proporcionándole una dieta sólida, se le da tiempo suficiente para que mastique y trague cada bocado, antes de ofrecerle el siguiente, tolera por via oral sin complicacion, paciente colaborador, apetito conservado.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
08/03/2026 14:31	Después del almuerzo se administra jarabe Escitalopram en solución oral, 20 cc, según indicación médica(psiquiatra) Tolera la administración por vía oral sin complicaciones, sin presencia de náuseas ni vómito, Paciente tranquila.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
08/03/2026 15:35	Se realiza higiene bucal con cepillo electrico y crema colgate y agua. Se realiza cambio de posición lateral derecho paciente estable y tranquila.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
08/03/2026 16:40	Se realiza aseo y organización de la unidad del paciente en domicilio, incluyendo limpieza de cama, colchón, barandas y superficie del entorno inmediato. Se realiza cambio de ropa de cama, dejando sábanas limpias, secas y bien ajustadas, garantizando condiciones adecuadas de higiene, orden y confort. Unidad del paciente queda limpia y organizada, sin novedades.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
08/03/2026 17:00	se realiza aseo en la unidad del paciente	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
08/03/2026 17:25	Se administra Acetaminofén 500mg por via oral, paciente tolera sin complicacion.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
08/03/2026 18:45	Se realiza cambio de pañal empleando los elementos necesarios (pañal limpio, toallitas húmedas, crema antipañalitis, guantes de látex). Se asegura la cama hospitalaria contra la pared para aportar mayor seguridad al paciente durante el procedimiento.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
08/03/2026 18:45	Se realiza cambio de pañal empleando los elementos necesarios (pañal limpio, toallitas húmedas, crema antipañalitis, guantes de látex). Se asegura la cama hospitalaria contra la pared para aportar mayor seguridad al paciente durante el procedimiento.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
08/03/2026 19:00	RECIBO paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO DX: Encefalopatia hipoxica,crisis epilépticas, cuadriplejia flácida y polineuropatia no especificada, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida. Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable tranquila presenta pequeños hematomas en miembros inferiores y superiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes. Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH HERNANDEZ DELGADO LIZETH

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

atención domiciliaria, con barandas de seguridad elevadas en silla de ruedas.

Paciente estable desorientada en las 3 esferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO:
Paciente tolero por via oral tolero medicamentos, durmió tranquila paso buen noche.

OBSERVACIONES
Dentro del domicilio Se observo hace tiempo fuga en el baño donde se baña la paciente, familiar niega que las auxiliares no avisaron.
• Dentro del domicilio Se observa hace tiempo material mecánicos, a fuera llenos de polvo y mugre.(a Jefe de ruta ordeno cerrar las ventan que va directo del paciente).
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)
• Pendiente terapias fisioterapeuta
• pendiente terapias ocupacional
•Pendiente terapias fonoaudiologo

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50pm, se administra una dosis adicional según orden médica.
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (++)
Deposición (-)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral (Cena)
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal.

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

SIGNOS VITALES:
TA:130/60 mmhg
Fc: 84 x'
FR:17 ×'
SPO2: 96 %
T:36.7°C

Entrega Aux- Lizeth Hernández
Recibe Aux- Adriana Beltrán

08/03/2026 19:00

Entrego paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: Encefalopatia hipoxica,crisis epilépticas, cuadriplejia flácida y polineuropatia no especificada, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable tranquila presenta pequeños hematomas en miembros inferiores y superiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria, con barandas elevadas en posición decúbito supino.

Paciente estable desorientada en las 3 esferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO:
Paciente tolero por via oral tolero medicamentos, alimentación.

OBSERVACIONES
Dentro del domicilio Se observo hace tiempo fuga en el baño donde se baña la paciente, familiar niega que las auxiliares no avisaron.
• Dentro del domicilio Se observa hace tiempo material mecánicos, a fuera llenos de polvo y mugre.(a Jefe de ruta ordeno cerrar las ventan que va directo del paciente).
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)
• Pendiente terapias fisioterapeuta
• pendiente terapias ocupacional
•Pendiente terapias fonoaudiologo

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50pm, se administra una dosis adicional según orden médica.
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (++)
Deposición (-)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral (desayuno, almuerzo)
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal.
Entrega Aux- Adriana Beltrán
Recibe Aux- Adriana Beltrán

08/03/2026 19:00

Entrego paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: Encefalopatia hipoxica,crisis epilépticas, cuadriplejia flácida y polineuropatia no especificada, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable tranquila presenta pequeños hematomas en miembros inferiores y superiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria, con barandas elevadas en posición decúbito supino.

Paciente estable desorientada en las 3 esferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO:
Paciente tolero por via oral tolero medicamentos, alimentación.

OBSERVACIONES
Dentro del domicilio Se observo hace tiempo fuga en el baño donde se baña la paciente, familiar niega que las auxiliares no avisaron.
• Dentro del domicilio Se observa hace tiempo material mecánicos, a fuera llenos de polvo y mugre.(a Jefe de ruta ordeno cerrar las ventan que va directo del paciente).
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

• Pendiente cita psicóloga (Mayo)
• Pendiente terapias fisioterapeuta
• pendiente terapias ocupacional
•Pendiente terapias fonoaudiologo

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50pm, se administra una dosis adicional según orden médica.
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (++)
Deposición (-)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral (desayuno, almuerzo)
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal.
Entrega Aux- Adriana Beltrán
Recibe Aux- Adriana Beltrán

08/03/2026 19:00

Recibo paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: Encefalopatia hipoxica,crisis epilépticas, cuadriplejia flácida y polineuropatia no especificada, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable tranquila presenta pequeños hematomas en miembros inferiores y superiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria, con barandas de seguridad elevadas en silla de ruedas.

Paciente estable desorientada en las 3 esferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

OBSERVACIONES
Dentro del domicilio Se observo hace tiempo fuga en el baño donde se baña la paciente, familiar niega que las auxiliares no avisaron.
• Dentro del domicilio Se observa hace tiempo material mecánicos, a fuera llenos de polvo y mugre.(a Jefe de ruta ordeno cerrar las ventan que va directo del paciente).
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)
• Pendiente terapias fisioterapeuta
• pendiente terapias ocupacional
•Pendiente terapias fonoaudiologo

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50pm, se administra una dosis adicional según orden médica.
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

SIGNOS VITALES:
TA:120/80 mmhg
Fc: 80 x'
FR:18 ×'
SPO2: 97 %
T:36.5°C

Entrega Aux- Adriana Beltrán
Recibe Aux- Lizeth Hernández

08/03/2026 20:00 Se administra tableta losartan 50mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

08/03/2026 20:20 Se administra capsula Amantadina 100mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

08/03/2026 20:30 Se administra tableta Citicolina 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

08/03/2026 20:50 Se administra dos cápsulas de Ácido valproico 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

08/03/2026 21:00 Se administra Quetiapina 200mg, mas dos tabletas Quetiapina 25mg un total administrados 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

08/03/2026 21:27 Paciente recibe y tolera dieta corriente sin complicaciones se asiste en la alimentación se observa paciente sin cambios en su estado general

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

08/03/2026 22:15 Se realiza a la paciente comodidad y confort se realiza cambio de pañal y se realiza aseo genital aplicando cremas antidermatitis y antiulceras sin complicaciones se deja pañal limpio se observa paciente con buen patrón respiratorio sin cambios en su estado general

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

08/03/2026 23:29 Se realiza cambio de posición a la paciente se lubrica la piel con crema se realiza masaje y ejercicio de flexión y estiramiento sin complicaciones se observa a la paciente tranquila con buen patrón respiratorio sin cambios en su estado general

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

09/03/2026 02:20 se observa a la paciente dormida tranquila afebril con buen patrón respiratorio sin cambios en su estado general

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

09/03/2026 04:15 Se realiza cambio de posición a la paciente se lubrica la piel con crema se realiza masaje y ejercicio de flexión y estiramiento sin complicaciones se observa a la paciente tranquila con buen patrón respiratorio sin cambios en su estado general

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

09/03/2026 05:00 Se administra Acido valproico 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

09/03/2026 06:30 Se realiza a la paciente comodidad y confort se realiza cambio de pañal y se realiza aseo genital aplicando cremas antidermatitis y antiulceras sin complicaciones se deja pañal limpio se observa paciente con buen patrón respiratorio sin cambios en su estado general

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

09/03/2026 07:00 Entrego paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: Encefalopatia hipoxica,crisis epilépticas, cuadriplejia flácida y polineuropatia no especificada, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable tranquila presenta pequeños hematomas en miembros inferiores y superiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria, con barandas de seguridad elevadas en silla de ruedas.

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

Paciente estable desorientada en las 3 esferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO:
Paciente tolero por via oral tolero medicamentos, durmió tranquila paso buen noche.

OBSERVACIONES
Dentro del domicilio Se observo hace tiempo fuga en el baño donde se baña la paciente, familiar niega que las auxiliares no avisaron.
• Dentro del domicilio Se observa hace tiempo material mecánicos, a fuera llenos de polvo y mugre.(a Jefe de ruta ordeno cerrar las ventan que va directo del paciente).
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)
• Pendiente terapias fisioterapeuta
• pendiente terapias ocupacional
•Pendiente terapias fonoaudiologo

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50pm, se administra una dosis adicional según orden médica.
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (++)
Deposición (-)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral (Cena)
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal.

SIGNOS VITALES:
TA:130/60 mmhg

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

Fc: 84 x'
FR:17 x'
SPO2: 96 %
T:36.7°C

Entrega Aux- Lizeth Hernández
Recibe Aux- Adriana Beltrán

09/03/2026 07:00

Entrego paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: Encefalopatia hipoxica,crisis epilépticas, cuadriplejia flácida y polineuropatia no especificada, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable tranquila presenta pequeños hematomas en miembros inferiores y superiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria, con barandas de seguridad elevadas en silla de ruedas.

Paciente estable desorientada en las 3 esferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO:
Paciente tolero por via oral tolero medicamentos, durmió tranquila paso buen noche.

OBSERVACIONES
Dentro del domicilio Se observo hace tiempo fuga en el baño donde se baña la paciente, familiar niega que las auxiliares no avisaron.
• Dentro del domicilio Se observa hace tiempo material mecánicos, a fuera llenos de polvo y mugre.(a Jefe de ruta ordeno cerrar las ventan que va directo del paciente).
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)
• Pendiente terapias fisioterapeuta
• pendiente terapias ocupacional
•Pendiente terapias fonoaudiologo

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50pm, se administra una dosis adicional según orden médica.
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (++)
Deposición (-)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral (Cena)
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal.

SIGNOS VITALES:
TA:135/80 mmhg
Fc: 78 x'
FR:18 ×'
SPO2: 97%
T:36.5°C

Entrega Aux- Lizeth Hernández
Recibe Aux- Adriana Beltrán

09/03/2026 07:00

Recibo paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: Encefalopatia hipoxica,crisis epilépticas, cuadriplejia flácida y polineuropatia no especificada, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable tranquila presenta pequeños hematomas en miembros inferiores y superiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria, con barandas de seguridad elevadas en posición semifowler.

Paciente estable desorientada en las 3 esferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión,
extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO:
Paciente tolero por via oral tolero medicamentos, durmió tranquila concilio sueño temprano, en horas de la mañana presento verbalizacion incoherente.

OBSERVACIONES
Dentro del domicilio Se observo hace tiempo fuga en el baño donde se baña la paciente, familiar niega que las auxiliares no avisaron.
• Dentro del domicilio Se observa hace tiempo material mecánicos, a fuera llenos de polvo y mugre.(a Jefe de ruta ordeno cerrar las ventan que va directo del paciente).
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)
• Pendiente terapias fisioterapeuta
• pendiente terapias ocupacional
•Pendiente terapias fonoaudiologo

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50pm, se administra una dosis adicional según orden médica.
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (++)
Deposición (-)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral (Cena)
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal.
Recibe Aux- Adriana Beltrán
Entrega Aux- Lizeth Hernández

09/03/2026 08:00 Se administra tableta losartan 50mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

09/03/2026 08:10 Se administra tableta Esomeprazol 20mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

09/03/2026 08:20 Se administra capsula Amantadina 100mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

09/03/2026 08:30 Se administra tableta Citicolina 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

09/03/2026 08:45 Se asiste a la hora del desayuno, proporcionándole una dieta sólida, se le da tiempo suficiente para que mastique y trague cada bocado, antes de ofrecerle el siguiente, tolera por via oral sin complicacion, paciente colaborador, apetito

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

conservado.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

09/03/2026 09:36 Se Disuelve laxante Polietilenglicol un sobre, se administra por via oral, paciente tolera por vía oral sin complicación.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

09/03/2026 11:30 Se administra tableta Ácido acetilsalicílico 100mg vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

09/03/2026 11:40 Se realiza traslado del paciente con ayuda de grúa hacia la silla poceta. Se lleva a cabo baño general, aplicando shampoo en cuero cabelludo y retirando con enjuague; posteriormente se aplica jabón líquido corporal, se enjuaga y se procede al secado completo de la piel. Finalizado el aseo, se traslada a la cama hospitalaria con apoyo de grúa. Se realiza secado cuidadoso de la región genital y glútea, aplicando crema con nistatina y crema Almipro. Se coloca pañal limpio y se viste con ropa limpia y adecuada. Durante el procedimiento, el paciente presentó episodios de nerviosismo.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

09/03/2026 12:25 Se aplica crema después del baño (Betametafona +Clotrimazol+ Neomocina) Parte de la espalda y hombros.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

09/03/2026 13:00 Se administra Acido valproico 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

09/03/2026 13:23 Se asiste a la hora del almuerzo, proporcionándole una dieta sólida, se le da tiempo suficiente para que mastique y trague cada bocado, antes de ofrecerle el siguiente, tolera por via oral sin complicacion, paciente colaborador, apetito conservado.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

09/03/2026 13:45 Después del almuerzo se administra jarabe Escitalopram en solución oral, 20 cc, según indicación médica(psiquiatra) Tolera la administración por vía oral sin complicaciones, sin presencia de náuseas ni vómito, Paciente tranquila.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

09/03/2026 13:46 Se realiza higiene bucal con cepillo electrico y crema colgate y agua, se realiza cambio de posición semiFowler.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

09/03/2026 14:45 se realiza estiramiento de sabanas para comodidad de paciente, se deja libre de arrugas, se coloca almohadas para mayor soporte y entrepiernas, realizo cambio de posición lateral izquierdo, paciente estable tranquila

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

09/03/2026 15:30

Se realiza cambio de sábanas garantizando limpieza y comodidad del paciente, dejando la superficie libre de arrugas, se procede a realiza cambio de pañal empleando los elementos necesarios (pañal limpio, toallitas húmedas, crema antipañalitis, guantes de látex). Se asegura la cama hospitalaria contra la pared para aportar mayor seguridad al paciente.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

09/03/2026 17:15

Se traslada paciente en grúa a la silla de ruedas.Se asiste a la hora de la cena , proporcionándole una dieta sólida, se le da tiempo suficiente para que mastique y trague cada bocado, antes de ofrecerle el siguiente, tolera por via oral sin complicacion, paciente colaborador, apetito conservado.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

09/03/2026 18:35

Se traslada paciente en grúa a la cama hospitalaria paciente presentó nerviosismo.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

09/03/2026 19:00

Entrego paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: Encefalopatia hipoxica,crisis epilépticas, cuadriplejia flácida y polineuropatia no especificada, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable tranquila presenta pequeños hematomas en miembros inferiores y superiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria, con barandas de seguridad elevadas en posición semifowler.

Paciente estable desorientada en las 3 esferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO:
Paciente tolero por via oral tolero medicamentos y alimentación, se realizó cambio de posiciónes.

OBSERVACIONES
Dentro del domicilio Se observo hace tiempo fuga en el baño donde se baña la paciente, familiar niega que las auxiliares no avisaron.
• Dentro del domicilio Se observa hace tiempo material mecánicos, a fuera llenos de polvo y mugre.(a Jefe de ruta ordeno cerrar las ventan que va directo del paciente).
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)
• Pendiente terapias fisioterapeuta
• pendiente terapias ocupacional
•Pendiente terapias fonoaudiologo

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50pm, se administra una dosis adicional según orden médica.
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (++)
Deposición (-)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral (Desayuno, almuerzo, cena)
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal.
Entrega Aux- Adriana Beltrán
Recibe Aux- Lizeth Hernandez

09/03/2026 19:00

Recibo paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: Encefalopatia hipoxica,crisis epilépticas, cuadriplejia flácida y polineuropatia no especificada, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable tranquila presenta pequeños hematomas en miembros inferiores y superiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria, con barandas de seguridad elevadas en silla de ruedas.

Paciente estable desorientada en las 3 esferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

OBSERVACIONES
Dentro del domicilio Se observo hace tiempo fuga en el baño donde se baña la paciente, familiar niega que las auxiliares no avisaron.
• Dentro del domicilio Se observa hace tiempo material mecánicos, a fuera llenos de polvo y mugre.(a Jefe de ruta ordeno cerrar las ventan que va directo del paciente).

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)
• Pendiente terapias fisioterapeuta
• pendiente terapias ocupacional
•Pendiente terapias fonoaudiologo

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50pm, se administra una dosis adicional según orden médica.
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

SIGNOS VITALES:
TA:110/60 mmhg
Fc: 77 x'
FR:17 ×'
SPO2: 98 %
T:36.5°C

Entrega Aux- Adriana Beltrán
Recibe Aux- Lizeth Hernández

09/03/2026 20:00 Se administra tableta losartan 50mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

09/03/2026 20:20 Se administra capsula Amantadina 100mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

09/03/2026 20:30 Se administra tableta Citicolina 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

09/03/2026 20:30 Se administra tableta Citicolina 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

09/03/2026 20:50	Se administra dos cápsulas de Ácido valproico 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	HERNANDEZ DELGADO LIZETH
09/03/2026 21:00	Se administra Quetiapina 200mg, mas dos tabletas Quetiapina 25mg un total administrados 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	HERNANDEZ DELGADO LIZETH
09/03/2026 22:35	Se realiza a la paciente comodidad y confort se realiza cambio de pañal y se realiza aseo genital aplicando cremas antidermatitis y antiulceras sin complicaciones se deja pañal limpio se observa paciente con buen patrón respiratorio sin cambios en su estado general	HERNANDEZ DELGADO LIZETH
09/03/2026 23:37	Se realiza cambio de posición a la paciente se lubrica la piel con crema se realiza masaje y ejercicio de flexión y estiramiento sin complicaciones se observa a la paciente tranquila con buen patrón respiratorio sin cambios en su estado general	HERNANDEZ DELGADO LIZETH
10/03/2026 02:09	se observa a la paciente dormida tranquila afebril con buen patrón respiratorio sin cambios en su estado general	HERNANDEZ DELGADO LIZETH
10/03/2026 04:30	Se realiza cambio de posición a la paciente se lubrica la piel con crema se realiza masaje y ejercicio de flexión y estiramiento sin complicaciones se observa a la paciente tranquila con buen patrón respiratorio sin cambios en su estado general	HERNANDEZ DELGADO LIZETH
10/03/2026 05:00	Se administra Acido valproico 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	HERNANDEZ DELGADO LIZETH
10/03/2026 06:20	Se realiza a la paciente comodidad y confort se realiza cambio de pañal y se realiza aseo genital aplicando cremas antidermatitis y antiulceras sin complicaciones se deja pañal limpio se observa paciente con buen patrón respiratorio sin cambios en su estado general	HERNANDEZ DELGADO LIZETH
10/03/2026 06:58	Se realiza a la paciente comodidad y confort se realiza cambio de pañal y se realiza aseo genital aplicando cremas antidermatitis y antiulceras sin complicaciones se deja pañal limpio se observa paciente con buen patrón respiratorio sin cambios en su estado general	HERNANDEZ DELGADO LIZETH
10/03/2026 07:00	Entrego paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO DX: Encefalopatia hipoxica,crisis epilépticas, cuadriplejia flácida y polineuropatia no especificada, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.	

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable tranquila presenta pequeños hematomas en miembros inferiores y superiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria, con barandas de seguridad elevadas en silla de ruedas.

Paciente estable desorientada en las 3 esferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO:
Paciente tolero por via oral tolero medicamentos, durmió tranquila paso buen noche.

OBSERVACIONES
Dentro del domicilio Se observo hace tiempo fuga en el baño donde se baña la paciente, familiar niega que las auxiliares no avisaron.
• Dentro del domicilio Se observa hace tiempo material mecánicos, a fuera llenos de polvo y mugre.(a Jefe de ruta ordeno cerrar las ventan que va directo del paciente).
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)
• Pendiente terapias fisioterapeuta
• pendiente terapias ocupacional
•Pendiente terapias fonoaudiologo

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50pm, se administra una dosis adicional según orden médica.
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (++)
Deposición (-)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

•Asistir a la hora del alimento del paciente oral (Cena)
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal.

SIGNOS VITALES:
TA:130/80 mmhg
Fc: 74 x'
FR: 18 ×'
SPO2: 97 %
T: 36.5°C

Entrega Aux- Lizeth Hernández
Recibe Aux- Adriana Beltrán

10/03/2026 07:00

Recibo paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: Encefalopatia hipoxica,crisis epilépticas, cuadriplejia flácida y polineuropatia no especificada, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable tranquila presenta pequeños hematomas en miembros inferiores y superiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria, con barandas de seguridad elevadas en posición semiflower.

Paciente estable desorientada en las 3 esferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO:
Paciente tolero por via oral tolero medicamentos, durmió tranquila paso buen noche.

OBSERVACIONES
Dentro del domicilio Se observo hace tiempo fuga en el baño donde se baña la paciente, familiar niega que las auxiliares no avisaron.
• Dentro del domicilio Se observa hace tiempo material mecánicos, a fuera llenos de polvo y mugre.(a Jefe de ruta ordeno cerrar las ventan que va directo del paciente).
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)
• Pendiente terapias fisioterapeuta
• pendiente terapias ocupacional
•Pendiente terapias fonoaudiologo

ALERGICOS: DIPIRONA

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50pm, se administra una dosis adicional según orden médica.
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (++)
Deposición (-)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral (Cena)
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal.
Recibe Aux- Adriana Beltrán
Entrega Aux- Lizeth Hernández

10/03/2026 07:15 Se realiza traslado del paciente con ayuda de grúa hacia la silla poceta. Se realiza cambio de sábanas y pongo sábanas limpias. Se lleva a cabo baño general, aplicando shampoo en cuero cabelludo y retirando con enjuague; posteriormente se aplica jabón líquido corporal, se enjuaga y se procede al secado completo de la piel. Finalizado el aseo, se traslada a la cama hospitalaria con apoyo de grúa. Se realiza secado cuidadoso de la región genital y glútea, aplicando crema con nistatina y crema Almipro. Se coloca pañal limpio y se viste con ropa limpia y adecuada. Durante el procedimiento, el paciente presentó episodios de nerviosismo.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

10/03/2026 07:33 se retira bata y pongo ropa limpia, se lubrica crema corporal en miembros superiores y inferiores.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

10/03/2026 08:00 Se administra tableta losartan 50mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

10/03/2026 08:10 Se administra tableta Esomeprazol 20mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

10/03/2026 08:20 Se administra capsula Amantadina 100mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

10/03/2026 08:30 Se administra tableta Citicolina 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

10/03/2026 08:37	Se hace acompañamiento y supervisa el desarrollo de las terapia realizada por el Fisioterapeuta partículas (Andrés Rodríguez).Realiza terapias de estiramiento en cama y postura en posición sentado, paciente permanece nerviosa signos de dificultad irritabilidad, inquietud, llanto, paciente tolera las terapias.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
10/03/2026 09:47	Se asiste a la hora del desayuno, proporcionándole una dieta sólida, se le da tiempo suficiente para que mastique y trague cada bocado, antes de ofrecerle el siguiente, tolera por via oral sin complicacion, paciente colaborador, apetito conservado.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
10/03/2026 10:23	Se administra laxante Polietilenglicol diluido en agua, tolera por via oral sin complicacion.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
10/03/2026 10:29	Se aplica crema (Betametafona +Clotrimazol+ Neomocina) Parte de la espalda y hombros.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
10/03/2026 11:30	Se administra tableta Ácido acetilsalicílico 100mg vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
10/03/2026 13:00	Se administra Acido valproico 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
10/03/2026 14:00	Se asiste a la hora del almuerzo, proporcionándole una dieta sólida, se le da tiempo suficiente para que mastique y trague cada bocado, antes de ofrecerle el siguiente, tolera por via oral sin complicacion, paciente colaborador, apetito conservado.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
10/03/2026 14:45	Después del almuerzo se administra jarabe Escitalopram en solución oral, 20 cc, según indicación médica(psiquiatra) Tolera la administración por vía oral sin complicaciones, sin presencia de náuseas ni vómito, Paciente tranquila.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
10/03/2026 14:46	Se realiza higiene bucal con cepillo electrico y crema colgate y agua.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
10/03/2026 15:40	Se realiza cambio de pañal empleando los elementos necesarios (pañal limpio, toallitas húmedas y crema almipro), pongo pañal limpio apto para su uso, se realiza estiramiento de sabanas para comodidad de paciente, se deja libre de arrugas, se coloca almohadas para mayor soporte y entrepiernas, realizo cambio de posición lateral izquierdo, paciente estable tranquila	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

10/03/2026 17:20

Se realiza aseo y organización de la unidad del paciente en domicilio, incluyendo limpieza de cama, colchón, barandas y superficie del entorno inmediato.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

10/03/2026 18:40

Se realiza cambio de pañal empleando los elementos necesarios (pañal limpio, toallitas húmedas, crema antipañalitis, guantes de látex). Se asegura la cama hospitalaria contra la pared.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

10/03/2026 19:00

Entrego paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: Encefalopatia hipoxica,crisis epilépticas, cuadriplejia flácida y polineuropatia no especificada, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable tranquila presenta pequeños hematomas en miembros inferiores y superiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria, con barandas de seguridad elevadas en posición Fowler.

Paciente estable desorientada en las 3 esferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO:
Paciente tolero por via oral tolero medicamentos y alimentos, ingreso al domicilio fisioterapeuta particular Andrés Rodríguez.

OBSERVACIONES
Dentro del domicilio Se observo hace tiempo fuga en el baño donde se baña la paciente, familiar niega que las auxiliares no avisaron.
• Dentro del domicilio Se observa hace tiempo material mecánicos, a fuera llenos de polvo y mugre.(a Jefe de ruta ordeno cerrar las ventan que va directo del paciente).
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)
• Pendiente terapias fisioterapeuta
• pendiente terapias ocupacional
•Pendiente terapias fonoaudiologo

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50pm, se administra una dosis adicional según orden médica.
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (++)
Deposición (-)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral (Desayuno, almuerzo)
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal.
Aux- Adriana Beltrán

10/03/2026 19:00

Recibo paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: Encefalopatia hipoxica,crisis epilépticas, cuadriplejia flácida y polineuropatia no especificada, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable tranquila presenta pequeños hematomas en miembros inferiores y superiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria, con barandas de seguridad elevadas en posición Fowler.

Paciente estable desorientada en las 3 esferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO:
Paciente tolero por via oral tolero medicamentos y alimentos, ingreso al domicilio fisioterapeuta particular Andrés Rodríguez.

OBSERVACIONES
Dentro del domicilio Se observo hace tiempo fuga en el baño donde se baña la paciente, familiar niega que las auxiliares no avisaron.
• Dentro del domicilio Se observa hace tiempo material mecánicos, a fuera llenos de polvo y mugre.(a Jefe de ruta ordeno cerrar las ventan que va directo del paciente).
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)
• Pendiente terapias fisioterapeuta
• pendiente terapias ocupacional
•Pendiente terapias fonoaudiologo

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50pm, se administra una dosis adicional según orden médica.
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (++)
Deposición (-)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral (Desayuno, almuerzo)
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal.

Aux- Adriana Beltrán

10/03/2026 20:00 Se administra tableta losartan 50mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

10/03/2026 20:16 Se asiste a la hora de la cena , proporcionándole una dieta sólida, se le da tiempo suficiente para que mastique y trague cada bocado, antes de ofrecerle el siguiente, tolera por via oral sin complicacion, paciente colaborador, apetito conservado.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

10/03/2026 20:20 Se administra capsula Amantadina 100mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

10/03/2026 20:30 Se administra tableta Citicolina 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

10/03/2026 20:50	Se administra dos cápsulas de Ácido valproico 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
10/03/2026 21:00	Se administra Quetiapina 200mg, más dos tabletas Quetiapina 25mg un total administrados 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
10/03/2026 22:03	Se retiran prendas de vestir, se lubrica piel con crema corporal, se coloca pijama limpia y seca, paciente presentó nervios y alucinaciones al momento de movilizarla hacia los lados en la cama hospitalaria.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
10/03/2026 22:37	Se realiza cambio de pañal empleando los elementos necesarios (pañal limpio, toallitas húmedas, crema antipañalitis, guantes de látex). Se asegura la cama hospitalaria contra la pared para aportar mayor seguridad al paciente durante el procedimiento.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
10/03/2026 22:37	Se realiza tendido de cama garantizando limpieza y comodidad del paciente, dejando la superficie libre de arrugas. Posteriormente se efectúa cambio de posición decúbito lateral izquierdo,(se coloca de soporte entre piernas almohadas) observándose paciente con episodios de nerviosismos.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
11/03/2026 00:21	Se realiza cambio de posición lateral derecho paciente estable dormida con buen patrón respiratorio.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
11/03/2026 03:23	Se realiza cambio de posición lateral izquierdo,paciente estable despierta.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
11/03/2026 04:00	Se observa paciente dormida con buen patrón respiratorio, se hace cambio de posición decúbito supino.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
11/03/2026 05:00	Se administra Acido valproico 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
11/03/2026 06:13	Se realiza cambio de pañal empleando los elementos necesarios (pañal limpio, toallitas húmedas, crema antipañalitis, guantes de látex). Se asegura la cama hospitalaria contra la pared.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

11/03/2026 06:13

Se realiza cambio de pañal empleando los elementos necesarios (pañal limpio, toallitas húmedas, crema antipañalitis, guantes de látex). Se asegura la cama hospitalaria contra la pared.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

11/03/2026 07:00

Entrego paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: Encefalopatia hipoxica,crisis epilépticas, cuadriplejia flácida y polineuropatia no especificada, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable tranquila presenta pequeños hematomas en miembros inferiores y superiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria, con barandas de seguridad elevadas en posición Fowler.

Paciente estable desorientada en las 3 esferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO:
Paciente se mantiene hemodinámicamente estable y tranquila. Tolera adecuadamente la vía oral para la administración de medicamentos y la ingesta de alimentos. Concilio sueño temprano.

OBSERVACIONES
Dentro del domicilio Se observo hace tiempo fuga en el baño donde se baña la paciente, familiar niega que las auxiliares no avisaron.
• Dentro del domicilio Se observa hace tiempo material mecánicos, a fuera llenos de polvo y mugre.(a Jefe de ruta ordeno cerrar las ventan que va directo del paciente).
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)
• Pendiente terapias fisioterapeuta
• pendiente terapias ocupacional
•Pendiente terapias fonoaudiologo

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50pm, se administra una dosis adicional según orden médica.
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (++)
Deposición (-)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral (Desayuno, almuerzo, cena)
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal.
Entrega Aux- Adriana Beltrán
Recibe Aux- Lizeth Hernández

11/03/2026 07:00

Recibo paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: Encefalopatia hipoxica,crisis epilépticas, cuadriplejia flácida y polineuropatia no especificada, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable tranquila presenta pequeños hematomas en miembros inferiores y superiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria, con barandas de seguridad elevadas en silla de ruedas.

Paciente estable desorientada en las 3 esferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión,
extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

OBSERVACIONES
Dentro del domicilio Se observo hace tiempo fuga en el baño donde se baña la paciente, familiar niega que las auxiliares no avisaron.
• Dentro del domicilio Se observa hace tiempo material mecánicos, a fuera llenos de polvo y mugre.(a Jefe de ruta ordeno cerrar las ventan que va directo del paciente).
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

• Pendiente terapias fisioterapeuta
• pendiente terapias ocupacional
•Pendiente terapias fonoaudiologo

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50pm, se administra una dosis adicional según orden médica.
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

SIGNOS VITALES:
TA:120/80 mmhg
Fc: 82 x'
FR:18 ×'
SPO2: 98%
T:36.5 °C

Entrega Aux- Adriana Beltrán
Recibe Aux- Lizeth Hernández

11/03/2026 08:00 Se administra tableta losartan 50mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

11/03/2026 08:10 Se administra tableta Esomeprazol 20mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

11/03/2026 08:20 Se administra capsula Amantadina 100mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

11/03/2026 08:30 Se administra tableta Citicolina 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

11/03/2026 09:35 paciente recibe y tolera dieta corriente sin complicaciones se observa paciente con buen patrón respiratorio sin cambios en su estado general

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

11/03/2026 10:30 Se realiza cambio de posición a la paciente se lubrica la piel con crema se realiza masaje y ejercicio de flexión y estiramiento sin complicaciones se observa a la paciente tranquila con buen patrón respiratorio sin cambios en su estado general

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

11/03/2026 11:30	Se administra tableta Ácido acetilsalicílico 100mg vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	HERNANDEZ DELGADO LIZETH
11/03/2026 11:40	Se realiza a la paciente comodidad y confort se realiza cambio de pañal y se realiza aseo genital aplicando cremas antidermatitis y antiulceras sin complicaciones se deja pañal limpio se observa paciente con buen patrón respiratorio sin cambios en su estado general	HERNANDEZ DELGADO LIZETH
11/03/2026 12:30	Se realiza traslado del paciente con ayuda de grúa hacia la silla poceta. Se lleva a cabo baño general, aplicando shampoo en cuero cabelludo y retirando con enjuague; posteriormente se aplica jabón líquido corporal, se enjuaga y se procede al secado completo de la piel. Finalizado el aseo, se traslada a la cama hospitalaria con apoyo de grúa. Se realiza secado cuidadoso de la región genital y glútea, aplicando crema con nistatina y crema Almipro. Se coloca pañal limpio y se viste con ropa limpia y adecuada. Durante el procedimiento, el paciente presentó episodios de nerviosismo.	HERNANDEZ DELGADO LIZETH
11/03/2026 13:00	Se administra Acido valproico 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	HERNANDEZ DELGADO LIZETH
11/03/2026 13:30	Paciente recibe y tolera dieta corriente almuerzo sin complicaciones se asiste en la alimentación se observa paciente sin cambios en su estado general	HERNANDEZ DELGADO LIZETH
11/03/2026 14:10	Después del almuerzo se administra jarabe Escitalopram en solución oral, 20 cc, según indicación médica(psiquiatra) Tolera la administración por vía oral sin complicaciones, sin presencia de náuseas ni vómito, Paciente tranquila.	HERNANDEZ DELGADO LIZETH
11/03/2026 16:00	Se realiza cambio de posición a la paciente se lubrica la piel con crema se realiza masaje y ejercicio de flexión y estiramiento sin complicaciones se observa a la paciente tranquila con buen patrón respiratorio sin cambios en su estado general	HERNANDEZ DELGADO LIZETH
11/03/2026 16:00	Se realiza cambio de posición a la paciente se lubrica la piel con crema se realiza masaje y ejercicio de flexión y estiramiento sin complicaciones se observa a la paciente tranquila con buen patrón respiratorio sin cambios en su estado general	HERNANDEZ DELGADO LIZETH
11/03/2026 17:20	Se realiza a la paciente comodidad y confort se realiza cambio de pañal y se realiza aseo genital aplicando cremas antidermatitis y antiulceras sin complicaciones se deja pañal limpio se observa paciente con buen patrón respiratorio sin cambios en su estado general	HERNANDEZ DELGADO LIZETH
11/03/2026 18:05	paciente recibe terapia de fonoaudiólogia por el profesional Jonathan Ibáñez se utiliza la grua para movilizar a la paciente se traslada a silla de ruedas sin complicaciones se arregla la unidad cama y tendidos se observa paciente en buen estado general sin cambios	HERNANDEZ DELGADO LIZETH

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

11/03/2026 18:45 se traslada a la paciente en grua y se deja en la cama en posición de cubito lateral izquierdo sin complicaciones se observa con buen patrón respiratorio sin cambios en su estado general

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

11/03/2026 19:00 Entrego paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: Encefalopatia hipoxica,crisis epilépticas, cuadriplejia flácida y polineuropatia no especificada, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable tranquila presenta pequeños hematomas en miembros inferiores y superiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria, con barandas de seguridad elevadas en posición Fowler.

Paciente estable desorientada en las 3 esferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO:
Paciente se mantiene hemodinámicamente estable y tranquila. Tolera adecuadamente la vía oral para la administración de medicamentos y la ingesta de alimentos, se le realizó terapia de fonoaudiólogia sin complicaciones

OBSERVACIONES
Dentro del domicilio Se observo hace tiempo fuga en el baño donde se baña la paciente, familiar niega que las auxiliares no avisaron.
• Dentro del domicilio Se observa hace tiempo material mecánicos, a fuera llenos de polvo y mugre.(a Jefe de ruta ordeno cerrar las ventan que va directo del paciente).
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)
• Pendiente terapias fisioterapeuta
• pendiente terapias ocupacional
•Pendiente terapias fonoaudiologo

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50pm, se administra una dosis adicional según orden médica.
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (++)
Deposición (-)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral (Desayuno, almuerzo,)
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal.

Control de signos vitales
TA: 130/90mmHg
FC: 82 x'
Fr: 17 x'
SPO2: 97%
T: 36.5 C
Entrega Aux- Lizeth Hernández
Recibe Aux- Adriana Beltrán

11/03/2026 19:00

Recibo paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: Encefalopatia hipoxica,crisis epilépticas, cuadriplejia flácida y polineuropatia no especificada, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable tranquila presenta pequeños hematomas en miembros inferiores y superiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria, con barandas de seguridad elevadas en posición semiflower.

Paciente estable desorientada en las 3 esferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión,
extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO:
Paciente se mantiene hemodinámicamente estable y tranquila. Tolera adecuadamente la vía oral para la administración de medicamentos y la ingesta de alimentos, se le realizó terapia de fonoaudiólogia sin complicaciones

OBSERVACIONES
Dentro del domicilio Se observo hace tiempo fuga en el baño donde se baña la paciente, familiar niega que las auxiliares no avisaron.
• Dentro del domicilio Se observa hace tiempo material mecánicos, a fuera llenos de polvo y mugre.(a Jefe de ruta ordeno cerrar las ventan que va directo del paciente).
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)
• Pendiente terapias fisioterapeuta
• pendiente terapias ocupacional
•Pendiente terapias fonoaudiologo

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50pm, se administra una dosis adicional según orden médica.
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (++)
Deposición (-)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral (Desayuno, almuerzo,)
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal.

Control de signos vitales

Recibe Aux- Adriana Beltrán
Entrega Aux- Lizeth Hernández

11/03/2026 19:25 Se asiste a la hora de la cena , proporcionándole una dieta sólida, se le da tiempo suficiente para que mastique y trague cada bocado, antes de ofrecerle el siguiente, tolera por via oral sin complicacion, paciente colaborador, apetito conservado.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

11/03/2026 19:45 se aplica crema corporal se realiza masajes.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

11/03/2026 20:00 Se administra tableta losartan 50mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

11/03/2026 20:10 Se administra tableta Amlodipino 5mg vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

11/03/2026 20:20	Se administra capsula Amantadina 100mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
11/03/2026 20:30	Se administra tableta Citicolina 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
11/03/2026 20:50	Se administra dos cápsulas de Ácido valproico 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
11/03/2026 21:00	Se administra Quetiapina 200mg, mas dos tabletas Quetiapina 25mg un total administrados 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
11/03/2026 22:00	Se retiran prendas de vestir y se realiza lubricación de la piel con crema corporal. Posteriormente, se coloca bata limpia y seca, paciente estable con bata limpia piel hidratada, permanece en cama hospitalaria bajo vigilancia y acompañamiento.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
11/03/2026 22:23	Se realiza cambio de pañal empleando los elementos necesarios (pañal limpio, toallitas húmedas, crema antipañalitis, guantes de látex). Se asegura la cama hospitalaria contra la pared.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
11/03/2026 23:10	se realiza estiramiento de sábanas para comodidad de paciente, se deja libre de arrugas, se coloca almohadas para mayor soporte y entrepiernas, realizo cambio de posición lateral izquierdo, paciente estable presento molestias y nerviosismo.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
11/03/2026 23:45	Se observa paciente dormida con buen patrón respiratorio.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
12/03/2026 00:02	Se observa paciente dormida con buen patrón respiratorio.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
12/03/2026 03:11	se realiza estiramiento de sabanas para comodidad de paciente, se deja libre de arrugas, se coloca almohadas para mayor soporte y entrepiernas, realizo cambio de posición derecho izquierdo, paciente estable dormida con buen patrón respiratorio	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

12/03/2026 04:30 Se observa paciente estable dormida con buen patrón respiratorio

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

12/03/2026 05:00 Se administra Acido valproico 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

12/03/2026 05:30 se observa a la paciente dormida tranquila afebril con buen patrón respiratorio sin cambios en su estado general

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

12/03/2026 06:06 Se retiran bata y se realiza lubricación de la piel con crema corporal. Posteriormente, se coloca ropa limpia y seca, paciente estable con pijama limpia piel hidratada, permanece en cama hospitalaria bajo vigilancia y acompañamiento.
Se realiza cambio de pañal empleando los elementos necesarios (pañal limpio, toallitas húmedas, crema antipañalitis, guantes de látex). Se asegura la cama hospitalaria contra la pared.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

12/03/2026 06:06 Se realiza cambio de pañal empleando los elementos necesarios (pañal limpio, toallitas húmedas, crema antipañalitis, guantes de látex). Se asegura la cama hospitalaria contra la pared.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

12/03/2026 06:54 Se realiza tendido de cama hospitalaria con cambio de sábanas, garantizando condiciones óptimas de higiene y confort para el paciente, dejando la superficie lisa y libre de arrugas.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

12/03/2026 07:00 Recibo paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: Encefalopatia hipoxica,crisis epilépticas, cuadriplejia flácida y polineuropatia no especificada, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable tranquila presenta pequeños hematomas en miembros inferiores y superiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria, con barandas de seguridad elevadas en silla de ruedas.

Paciente estable desorientada en las 3 esferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

OBSERVACIONES
Dentro del domicilio Se observo hace tiempo fuga en el baño donde se baña la paciente, familiar niega que las auxiliares no avisaron.
• Dentro del domicilio Se observa hace tiempo material mecánicos, a fuera llenos de polvo y mugre.(a Jefe de ruta ordeno cerrar las ventan que va directo del paciente).
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)
• Pendiente terapias fisioterapeuta
• pendiente terapias ocupacional
•Pendiente terapias fonoaudiologo

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50pm, se administra una dosis adicional según orden médica.
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

SIGNOS VITALES:
TA:130/70 mmhg
Fc: 78 x'
FR:17 x'
SPO2: 97 %
T:36.7 °C

Entrega Aux- Adriana Beltrán
Recibe Aux- Lizeth Hernández

12/03/2026 07:00

Entrego paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: Encefalopatia hipoxica,crisis epilépticas, cuadriplejia flácida y polineuropatia no especificada, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable tranquila presenta pequeños hematomas en miembros inferiores y superiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria, con barandas de seguridad elevadas en posición Fowler.

Paciente estable desorientada en las 3 esferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado,

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO:
Paciente se mantiene hemodinámicamente estable y tranquila. Tolera adecuadamente la vía oral para la administración de medicamentos y la ingesta de alimentos, se le realizó terapia de fonoaudiólogia sin complicaciones

OBSERVACIONES
Dentro del domicilio Se observo hace tiempo fuga en el baño donde se baña la paciente, familiar niega que las auxiliares no avisaron.
• Dentro del domicilio Se observa hace tiempo material mecánicos, a fuera llenos de polvo y mugre.(a Jefe de ruta ordeno cerrar las ventan que va directo del paciente).
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)
• Pendiente terapias fisioterapeuta
• pendiente terapias ocupacional
•Pendiente terapias fonoaudiologo

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50pm, se administra una dosis adicional según orden médica.
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (++)
Deposición (-)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral (Desayuno, almuerzo,)
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal.

Control de signos vitales
TA: 130/90mmHg

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

FC: 82 x'
Fr: 17 x'
SPO2: 97%
T: 36.5 C

12/03/2026 08:00	Se administra tableta losartan 50mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	HERNANDEZ DELGADO LIZETH
12/03/2026 08:10	Se administra tableta Esomeprazol 20mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	HERNANDEZ DELGADO LIZETH
12/03/2026 08:20	Se administra capsula Amantadina 100mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	HERNANDEZ DELGADO LIZETH
12/03/2026 08:30	Se administra tableta Citicolina 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	HERNANDEZ DELGADO LIZETH
12/03/2026 09:10	Paciente recibe y tolera dieta corriente sin complicaciones se asiste en la alimentación se observa paciente sin cambios en su estado general	HERNANDEZ DELGADO LIZETH
12/03/2026 09:30	Fisioterapeuta Andrés Rodríguez realiza terapia física a la paciente en la unidad sin complicaciones se observa paciente cooperativa con buen patrón respiratorio sin cambios en su estado general	HERNANDEZ DELGADO LIZETH
12/03/2026 10:00	Se realiza cambio de posición a la paciente se lubrica la piel con crema se realiza masaje y ejercicio de flexión y estiramiento sin complicaciones se observa a la paciente tranquila con buen patrón respiratorio sin cambios en su estado general	HERNANDEZ DELGADO LIZETH
12/03/2026 11:30	Se administra tableta Ácido acetilsalicílico 100mg vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	HERNANDEZ DELGADO LIZETH
12/03/2026 12:00	Se realiza traslado del paciente con ayuda de grúa hacia la silla poceta. Se lleva a cabo baño general, aplicando shampoo en cuero cabelludo y retirando con enjuague; posteriormente se aplica jabón líquido corporal, se enjuaga y se procede al secado completo de la piel. Finalizado el aseo, se traslada a la cama hospitalaria con apoyo de grúa. Se realiza secado cuidadoso de la región genital y glútea, aplicando crema con nistatina y crema Almipro. Se coloca pañal limpio y se viste con ropa limpia y adecuada. Durante el procedimiento, el paciente presentó episodios de nerviosismo.	HERNANDEZ DELGADO LIZETH
12/03/2026 13:00	Se administra Acido valproico 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

12/03/2026 13:20 Paciente recibe y tolera dieta corriente almuerzo sin complicaciones se asiste en la alimentación se observa paciente sin cambios en su estado general

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

12/03/2026 13:45 Después del almuerzo se administra jarabe Escitalopram en solución oral, 20 cc, según indicación médica(psiquiatra) Tolera la administración por vía oral sin complicaciones, sin presencia de náuseas ni vómito, Paciente tranquila.

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

12/03/2026 14:30 se observa a la paciente dormida tranquila afebril con buen patrón respiratorio sin cambios en su estado general

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

12/03/2026 16:00 Se realiza cambio de posición a la paciente se lubrica la piel con crema se realiza masaje y ejercicio de flexión y estiramiento sin complicaciones se observa a la paciente tranquila con buen patrón respiratorio sin cambios en su estado general

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

12/03/2026 17:30 se observa a la paciente dormida tranquila afebril con buen patrón respiratorio sin cambios en su estado general

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

12/03/2026 18:40 Se realiza a la paciente comodidad y confort se realiza cambio de pañal y se realiza aseo genital aplicando cremas antidermatitis y antiulceras sin complicaciones se deja pañal limpio se observa paciente con buen patrón respiratorio sin cambios en su estado general

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

12/03/2026 19:00 Entrego paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: Encefalopatia hipoxica,crisis epilépticas, cuadriplejia flácida y polineuropatia no especificada, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable tranquila presenta pequeños hematomas en miembros inferiores y superiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria, con barandas de seguridad elevadas en posición Fowler.

Paciente estable desorientada en las 3 esferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO:
Paciente se mantiene hemodinámicamente estable y tranquila. Tolera adecuadamente la vía oral para la administración de medicamentos y la ingesta de alimentos, se le realizó terapia física sin complicaciones

OBSERVACIONES
Dentro del domicilio Se observo hace tiempo fuga en el baño donde se baña la paciente, familiar niega que las auxiliares no avisaron.
• Dentro del domicilio Se observa hace tiempo material mecánicos, a fuera llenos de polvo y mugre.(a Jefe de ruta ordeno cerrar las ventan que va directo del paciente).
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)
• Pendiente terapias fisioterapeuta
• pendiente terapias ocupacional
•Pendiente terapias fonoaudiologo

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50pm, se administra una dosis adicional según orden médica.
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (++)
Deposición (+)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral (Desayuno, almuerzo,)
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal.

Control de signos vitales
TA: 120/80mmHg
FC: 78 x'
Fr: 18x'
SPO2: 98%
T: 36.7 C
Entrega Aux- Lizeth Hernández
Recibe Aux- Adriana Beltrán

12/03/2026 19:00 Recibo paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

DX: Encefalopatia hipoxica,crisis epilépticas, cuadriplejia flácida y polineuropatia no especificada, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable tranquila presenta pequeños hematomas en miembros inferiores y superiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria, con barandas de seguridad elevadas en posición Fowler.

Paciente estable desorientada en las 3 esferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO:
Paciente se mantiene hemodinámicamente estable y tranquila. Tolera adecuadamente la vía oral para la administración de medicamentos y la ingesta de alimentos, se le realizó terapia física sin complicaciones

OBSERVACIONES
Dentro del domicilio Se observo hace tiempo fuga en el baño donde se baña la paciente, familiar niega que las auxiliares no avisaron.
• Dentro del domicilio Se observa hace tiempo material mecánicos, a fuera llenos de polvo y mugre.(a Jefe de ruta ordeno cerrar las ventan que va directo del paciente).
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)
• Pendiente terapias fisioterapeuta
• pendiente terapias ocupacional
•Pendiente terapias fonoaudiologo

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50pm, se administra una dosis adicional según orden médica.
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (++)
Deposición (+)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral (Desayuno, almuerzo,)
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal.
Recibe Aux-Adriana Beltrán
Recibe Aux- Lizeth Hernández

12/03/2026 20:00 Se administra tableta losartan 50mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

12/03/2026 20:20 Se administra capsula Amantadina 100mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

12/03/2026 20:25 Se asiste a la hora de la cena , proporcionándole una dieta blanda , se le da tiempo suficiente para que mastique y trague cada bocado, antes de ofrecerle el siguiente, tolera por via oral sin complicacion, paciente colaborador, apetito conservado.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

12/03/2026 20:30 Se administra tableta Citicolina 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

12/03/2026 20:30 Se administra tableta Citicolina 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

12/03/2026 20:50 Se administra dos cápsulas de Ácido valproico 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

12/03/2026 21:00 Se administra Quetiapina 200mg, mas dos tabletas Quetiapina 25mg un total administrados 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

12/03/2026 22:33 Se realiza cambio de pañal empleando los elementos necesarios (pañal limpio, toallitas húmedas, crema antipañalitis, guantes de látex). Se asegura la cama hospitalaria contra la pared.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

12/03/2026 22:33	Se realiza tendido de cama garantizando limpieza y comodidad del paciente, dejando la superficie libre de arrugas. Posteriormente se efectúa cambio de posición decúbito lateral izquierdo, observándose paciente estable dormida con buen patrón respiratorio.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
12/03/2026 23:43	Se observa paciente dormida con buen patrón respiratorio.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
13/03/2026 00:55	Se realiza cambio de posición lateral derecho, con mayor soporte se coloca almohadas entre piernas y espalda, paciente estable dormida con buen patrón respiratorio.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
13/03/2026 03:01	Se observa paciente dormida, presento tos seca.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
13/03/2026 04:26	Se observa paciente dormida con buen patrón respiratorio, se realiza cambio de posición decúbito supino.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
13/03/2026 05:00	Se administra Acido valproico 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
13/03/2026 06:27	Se realiza cambio de pañal empleando los elementos necesarios (pañal limpio, toallitas húmedas, crema antipañalitis, guantes de látex). Se asegura la cama hospitalaria contra la pared.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
13/03/2026 06:48	Se realiza tendido de cama hospitalaria con cambio de sábanas, garantizando condiciones óptimas de higiene y confort para el paciente, dejando la superficie lisa y libre de arrugas.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
13/03/2026 07:00	Entrego paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO DX: Encefalopatia hipoxica,crisis epilépticas, cuadriplejia flácida y polineuropatia no especificada, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida. Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable tranquila presenta pequeños hematomas en miembros inferiores y superiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes. Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria, con barandas de seguridad elevadas en posición decúbito supino .	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

Paciente estable desorientada en las 3 esferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO:
Paciente se mantiene hemodinámicamente estable y tranquila. Tolera adecuadamente la vía oral para la administración de medicamentos y la ingesta de alimentos, concilio sueño temprano.

OBSERVACIONES
•Dentro del domicilio Se observo hace tiempo fuga en el baño donde se baña la paciente, familiar niega que las auxiliares no avisaron.
• Dentro del domicilio Se observa hace tiempo material mecánicos, a fuera llenos de polvo y mugre.(a Jefe de ruta ordeno cerrar las ventan que va directo del paciente).
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)
• Pendiente terapias fisioterapeuta
• pendiente terapias ocupacional
•Pendiente terapias fonoaudiologo

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50pm, se administra una dosis adicional según orden médica.
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (++)
Deposición (-)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral (cena)
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal.6
Entrega Aux- Adriana Beltrán

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

13/03/2026 07:00

Recibe Aux- Lizeth Hernández

Recibo paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: Encefalopatia hipoxica,crisis epilépticas, cuadriplejia flácida y polineuropatia no especificada, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable tranquila presenta pequeños hematomas en miembros inferiores y superiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria, con barandas de seguridad elevadas en silla de ruedas.

Paciente estable desorientada en las 3 esferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

OBSERVACIONES
Dentro del domicilio Se observo hace tiempo fuga en el baño donde se baña la paciente, familiar niega que las auxiliares no avisaron.
• Dentro del domicilio Se observa hace tiempo material mecánicos, a fuera llenos de polvo y mugre.(a Jefe de ruta ordeno cerrar las ventan que va directo del paciente).
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)
• Pendiente terapias fisioterapeuta
• pendiente terapias ocupacional
•Pendiente terapias fonoaudiologo

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50pm, se administra una dosis adicional según orden médica.
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

SIGNOS VITALES:

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

TA:120/80 mmhg
Fc: 80 x'
FR:18 ×'
SPO2: 96 %
T:36.5 °C

Entrega Aux- Adriana Beltrán
Recibe Aux- Lizeth Hernández

13/03/2026 08:00	Se administra tableta losartan 50mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	HERNANDEZ DELGADO LIZETH
13/03/2026 08:10	Se administra tableta Esomeprazol 20mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	HERNANDEZ DELGADO LIZETH
13/03/2026 08:20	Se administra capsula Amantadina 100mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	HERNANDEZ DELGADO LIZETH
13/03/2026 08:30	Se administra tableta Citicolina 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	HERNANDEZ DELGADO LIZETH
13/03/2026 09:00	Paciente recibe y tolera dieta corriente sin complicaciones se asiste en la alimentación se observa paciente sin cambios en su estado general	HERNANDEZ DELGADO LIZETH
13/03/2026 10:15	Se realiza cambio de posición a la paciente se lubrica la piel con crema se realiza masaje y ejercicio de flexión y estiramiento sin complicaciones se observa a la paciente tranquila con buen patrón respiratorio sin cambios en su estado general	HERNANDEZ DELGADO LIZETH
13/03/2026 11:30	Se administra tableta Ácido acetilsalicílico 100mg vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	HERNANDEZ DELGADO LIZETH
13/03/2026 11:50	Se realiza traslado del paciente con ayuda de grúa hacia la silla poceta. Se lleva a cabo baño general, aplicando shampoo en cuero cabelludo y retirando con enjuague; posteriormente se aplica jabón líquido corporal, se enjuaga y se procede al secado completo de la piel. Finalizado el aseo, se traslada a la cama hospitalaria con apoyo de grúa. Se realiza secado cuidadoso de la región genital y glútea, aplicando crema con nistatina y crema Almipro. Se coloca pañal limpio y se viste con ropa limpia y adecuada. Durante el procedimiento, el paciente presentó episodios de nerviosismo.	HERNANDEZ DELGADO LIZETH
13/03/2026 12:20	se realiza aseo de la unidad se cambian sábanas y fundas de la cama se asea habitación y baño de la paciente sin complicaciones se observa paciente con buen patrón respiratorio sin cambios en su estado general	HERNANDEZ DELGADO LIZETH

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

13/03/2026 13:00 Se administra Acido valproico 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

13/03/2026 13:30 Paciente recibe y tolera dieta corriente almuerzo sin complicaciones se asiste en la alimentación se observa paciente sin cambios en su estado general

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

13/03/2026 14:25 Después del almuerzo se administra jarabe Escitalopram en solución oral, 20 cc, según indicación médica(psiquiatra) Tolera la administración por vía oral sin complicaciones, sin presencia de náuseas ni vómito, Paciente tranquila.

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

13/03/2026 15:15 se observa a la paciente dormida tranquila afebril con buen patrón respiratorio sin cambios en su estado general

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

13/03/2026 16:35 Se realiza a la paciente comodidad y confort se realiza cambio de pañal y se realiza aseo genital aplicando cremas antidermatitis y antiulceras sin complicaciones se deja pañal limpio se observa paciente con buen patrón respiratorio sin cambios en su estado general

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

13/03/2026 17:40 paciente recibe terapia de fonoaudiólogia por el profesional Jonathan Ibáñez se utiliza la grua para movilizar a la paciente se traslada a silla de ruedas sin complicaciones se arregla la unidad cama y tendidos se observa paciente en buen estado general sin cambios

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

13/03/2026 18:13 se observa paciente en silla de ruedas junto al fonoaudiólogo realizando terapias con buen patrón respiratorio sin cambios en su estado general

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

13/03/2026 19:00 Entrego paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: Encefalopatia hipoxica,crisis epilépticas, cuadriplejia flácida y polineuropatia no especificada, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable tranquila presenta pequeños hematomas en miembros inferiores y superiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria, con barandas de seguridad elevadas en posición Fowler.

Paciente estable desorientada en las 3 esferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO:
Paciente se mantiene hemodinámicamente estable y tranquila. Tolera adecuadamente la vía oral para la administración de medicamentos y la ingesta de alimentos, se le realizó terapia de fonoaudiólogia sin complicaciones

OBSERVACIONES
Dentro del domicilio Se observo hace tiempo fuga en el baño donde se baña la paciente, familiar niega que las auxiliares no avisaron.
• Dentro del domicilio Se observa hace tiempo material mecánicos, a fuera llenos de polvo y mugre.(a Jefe de ruta ordeno cerrar las ventan que va directo del paciente).
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)
• Pendiente terapias fisioterapeuta
• pendiente terapias ocupacional
•Pendiente terapias fonoaudiologo

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50pm, se administra una dosis adicional según orden médica.
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (++)
Deposición (++)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral (Desayuno, almuerzo,)
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal.

Control de signos vitales
TA: 130/90mmHg
FC: 87 x'
Fr: 18x'
SPO2: 97%
T: 36.5 C
Entrega Aux- Lizeth Hernández

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

13/03/2026 19:00

Recibe Aux- Adriana Beltrán

Entrego paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: Encefalopatia hipoxica,crisis epilépticas, cuadriplejia flácida y polineuropatia no especificada, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable tranquila presenta pequeños hematomas en miembros inferiores y superiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria, con barandas de seguridad elevadas en posición Fowler.

Paciente estable desorientada en las 3 esferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO:
Paciente se mantiene hemodinámicamente estable y tranquila. Tolera adecuadamente la vía oral para la administración de medicamentos y la ingesta de alimentos, se le realizó terapia de fonoaudiólogia sin complicaciones

OBSERVACIONES
Dentro del domicilio Se observo hace tiempo fuga en el baño donde se baña la paciente, familiar niega que las auxiliares no avisaron.
• Dentro del domicilio Se observa hace tiempo material mecánicos, a fuera llenos de polvo y mugre.(a Jefe de ruta ordeno cerrar las ventan que va directo del paciente).
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)
• Pendiente terapias fisioterapeuta
• pendiente terapias ocupacional
•Pendiente terapias fonoaudiologo

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50pm, se administra una dosis adicional según orden médica.
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (++)
Deposición (++)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral (Desayuno, almuerzo,)
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal.

Control de signos vitales
TA: 130/90mmHg
FC: 87 x'
Fr: 18x'
SPO2: 97%
T: 36.5 C
Entrega Aux- Lizeth Hernández
Recibe Aux- Adriana Beltrán

13/03/2026 19:00

Recibo paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: Encefalopatia hipoxica,crisis epilépticas, cuadriplejia flácida y polineuropatia no especificada, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable tranquila presenta pequeños hematomas en miembros inferiores y superiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria, en silla de ruedas.

Paciente estable desorientada en las 3 esferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO:
Paciente se mantiene hemodinámicamente estable y tranquila. Tolera adecuadamente la vía oral para la administración de medicamentos y la ingesta de alimentos, se le realizó terapia de fonoaudiólogia sin complicaciones

OBSERVACIONES
Dentro del domicilio Se observo hace tiempo fuga en el baño donde se baña la paciente, familiar niega que las auxiliares no avisaron.
• Dentro del domicilio Se observa hace tiempo material mecánicos, a fuera llenos de polvo y mugre.(a Jefe de ruta ordeno cerrar las ventan que va directo del paciente).
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)
• Pendiente terapias fisioterapeuta
• pendiente terapias ocupacional
•Pendiente terapias fonoaudiologo

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50pm, se administra una dosis adicional según orden médica.
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (++)
Deposición (++)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral (Desayuno, almuerzo)
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal.

Control de signos vitales
Recibe Aux- Adriana Beltrán
Entrega Aux- Lizeth Hernandez

13/03/2026 19:20 se retira ropa de vestir ropa y pongo ropa bata limpia.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

13/03/2026 20:00 Se administra tableta losartan 50mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

13/03/2026 20:17 Se asisto a la hora de la cena , proporcionándole una dieta sólida, se le da tiempo suficiente para que mastique y trague cada bocado, antes de ofrecerle el siguiente, tolera por via oral sin complicacion, paciente colaborador, apetito conservado.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

13/03/2026 20:20 Se administra capsula Amantadina 100mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

13/03/2026 20:30 Se administra tableta Citicolina 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

13/03/2026 20:30	Se administra tableta Citicolina 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
13/03/2026 20:50	Se administra dos cápsulas de Ácido valproico 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
13/03/2026 21:00	Se administra Quetiapina 200mg, mas dos tabletas Quetiapina 25mg un total administrados 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
13/03/2026 21:45	Se realiza higiene bucal con cepillo electrico y crema colgate y agua. Se traslada paciente en grúa a la cama hospitalaria, paciente presento nerviosismo.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
13/03/2026 22:18	Se retiran bata de vestir y se realiza lubricación de la piel con crema corporal. Posteriormente, se coloca bata limpia y seca, paciente estable con bata limpia piel hidratada, Se realiza cambio de pañal empleando los elementos necesarios (pañal limpio, toallitas húmedas, crema antipañalitis, guantes de látex). Se asegura la cama hospitalaria contra la pared.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
13/03/2026 22:22	se realiza estiramiento de sabanas para comodidad de paciente, se deja libre de arrugas, se coloca almohadas para mayor soporte y entrepiernas, realizo cambio de posición lateral izquierdo, paciente estable tranquila.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
14/03/2026 04:18	Se realiza cambio de posición semifowler, paciente estable con episodios de nerviosismo.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
14/03/2026 05:00	Se administra agua medio basado de agua, paciente tolera por via oral sin complicacion.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
14/03/2026 05:00	Se administra Acido valproico 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
14/03/2026 06:20	Se realiza cambio de pañal empleando los elementos necesarios (pañal limpio, toallitas húmedas, crema antipañalitis, guantes de látex). Se asegura la cama hospitalaria contra la pared. Se realiza cambio de sábanas y pongo sábanas limpias.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

14/03/2026 07:00

Entrego paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: Encefalopatia hipoxica,crisis epilépticas, cuadriplejia flácida y polineuropatia no especificada, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable tranquila presenta pequeños hematomas en miembros inferiores y superiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria, con barandas de seguridad elevadas en posición Fowler.

Paciente estable desorientada en las 3 esferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO:
Paciente se mantiene hemodinámicamente estable y tranquila. Tolera adecuadamente la vía oral para la administración de medicamentos y la ingesta de alimentos, se le realizó terapia física sin complicaciones, Ingreso al domicilio albañil arreglo la fuga de la llave del baño,(ducha quedo sin fuga, arreglada).

OBSERVACIONES
•observa hace tiempo material mecánicos, a fuera llenos de polvo y mugre.(a Jefe de ruta ordeno cerrar las ventan que va directo del paciente).
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
* Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
* Pendiente cita psicóloga (Mayo)
* Pendiente terapias fisioterapeuta
* pendiente terapias ocupacional
•Pendiente terapias fonoaudiologo

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50pm, se administra una dosis adicional según orden médica.
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (++)
Deposición (++)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral (Desayuno, almuerzo)
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal.

Control de signos vitales
TA: 111/65mmHg
FC: 80 x'
Fr: 19 x'
SPO2: 96 %
T: 36.7 C
Recibe Aux- Adriana Beltran
EntregaAux- Lizeth Hernández

14/03/2026 07:00

Recibo paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: Encefalopatia hipoxica,crisis epilépticas, cuadriplejia flácida y polineuropatia no especificada, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable tranquila presenta pequeños hematomas en miembros inferiores y superiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria, con barandas de seguridad elevadas en silla de ruedas.

Paciente estable desorientada en las 3 esferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

OBSERVACIONES
Dentro del domicilio Se observo hace tiempo fuga en el baño donde se baña la paciente, familiar niega que las auxiliares no avisaron.
• Dentro del domicilio Se observa hace tiempo material mecánicos, a fuera llenos de polvo y mugre.(a Jefe de ruta ordeno cerrar las ventan que va directo del paciente).
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)
• Pendiente terapias fisioterapeuta
• pendiente terapias ocupacional

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

•Pendiente terapias fonoaudiologo

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50pm, se administra una dosis adicional según orden médica.
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

SIGNOS VITALES:
TA:125/70 mmhg
Fc: 79 x'
FR:17x'
SPO2: 97 %
T:36.7 °C

Entrega Aux- Adriana Beltrán
Recibe Aux- Lizeth Hernández

14/03/2026 08:00 Se administra tableta losartan 50mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

14/03/2026 08:10 Se administra tableta Esomeprazol 20mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

14/03/2026 08:20 Se administra capsula Amantadina 100mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

14/03/2026 08:30 Se administra tableta Citicolina 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

14/03/2026 09:00 Fisioterapeuta Andrés Rodríguez realiza terapia física a la paciente en la unidad la levanta con ayuda de la grua y realiza ayuda del kafo para la deambulacion sin complicaciones se observa paciente cooperativa con buen patrón respiratorio sin cambios en su estado general

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

14/03/2026 10:30 Paciente recibe y tolera dieta corriente sin complicaciones se asiste en la alimentación se observa paciente sin cambios en su estado general

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

14/03/2026 11:30	Se administra tableta Ácido acetilsalicílico 100mg vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	HERNANDEZ DELGADO LIZETH
14/03/2026 12:10	Se realiza traslado del paciente con ayuda de grúa hacia la silla poceta. Se lleva a cabo baño general, aplicando shampoo en cuero cabelludo y retirando con enjuague; posteriormente se aplica jabón líquido corporal, se enjuaga y se procede al secado completo de la piel. Finalizado el aseo, se traslada a la cama hospitalaria con apoyo de grúa. Se realiza secado cuidadoso de la región genital y glútea, aplicando crema con nistatina y crema Almipro. Se coloca pañal limpio y se viste con ropa limpia y adecuada. Durante el procedimiento, el paciente presentó episodios de nerviosismo.	HERNANDEZ DELGADO LIZETH
14/03/2026 13:00	Se administra Acido valproico 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	HERNANDEZ DELGADO LIZETH
14/03/2026 14:00	Paciente recibe y tolera dieta corriente almuerzo sin complicaciones se asiste en la alimentación se observa paciente sin cambios en su estado general	HERNANDEZ DELGADO LIZETH
14/03/2026 14:30	Después del almuerzo se administra jarabe Escitalopram en solución oral, 20 cc, según indicación médica(psiquiatra) Tolera la administración por vía oral sin complicaciones, sin presencia de náuseas ni vómito, Paciente tranquila.	HERNANDEZ DELGADO LIZETH
14/03/2026 15:25	Se realiza cambio de posición a la paciente se lubrica la piel con crema se realiza masaje y ejercicio de flexión y estiramiento sin complicaciones se observa a la paciente tranquila con buen patrón respiratorio sin cambios en su estado general	HERNANDEZ DELGADO LIZETH
14/03/2026 17:00	se observa a la paciente dormida tranquila afebril con buen patrón respiratorio sin cambios en su estado general	HERNANDEZ DELGADO LIZETH
14/03/2026 18:15	Se realiza a la paciente comodidad y confort se realiza cambio de pañal y se realiza aseo genital aplicando cremas antidermatitis y antiulceras sin complicaciones se deja pañal limpio se observa paciente con buen patrón respiratorio sin cambios en su estado general	HERNANDEZ DELGADO LIZETH
14/03/2026 19:00	Recibo paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO DX: Encefalopatia hipoxica,crisis epilépticas, cuadriplejia flácida y polineuropatia no especificada, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida. Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable tranquila presenta pequeños hematomas en miembros inferiores y superiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes. Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria con barandas de seguridad elevadas en posición decúbito supino.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

Paciente estable desorientada en las 3 esferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO:
Paciente se mantiene hemodinámicamente estable y tranquila. Tolera adecuadamente la vía oral para la administración de medicamentos concilio sueño temprano.

OBSERVACIONES
Dentro del domicilio Se observo hace tiempo fuga en el baño donde se baña la paciente, familiar niega que las auxiliares no avisaron.
• Dentro del domicilio Se observa hace tiempo material mecánicos, a fuera llenos de polvo y mugre.(a Jefe de ruta ordeno cerrar las ventan que va directo del paciente).
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)
• Pendiente terapias fisioterapeuta
• pendiente terapias ocupacional
•Pendiente terapias fonoaudiologo

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50pm, se administra una dosis adicional según orden médica.
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (++)
Deposición (++)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral (Cena)
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal.
Entrega Aux- Adriana Beltrán

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

14/03/2026 19:00

Recibe Aux- Lizeth Hernandez

Entrego paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: Encefalopatia hipoxica,crisis epilépticas, cuadriplejia flácida y polineuropatia no especificada, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable tranquila presenta pequeños hematomas en miembros inferiores y superiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria, con barandas de seguridad elevadas en posición Fowler.

Paciente estable desorientada en las 3 esferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO:
Paciente se mantiene hemodinámicamente estable y tranquila. Tolera adecuadamente la vía oral para la administración de medicamentos y la ingesta de alimentos, se le realizó terapia física sin complicaciones

OBSERVACIONES
Dentro del domicilio Se observo hace tiempo fuga en el baño donde se baña la paciente, familiar niega que las auxiliares no avisaron.
• Dentro del domicilio Se observa hace tiempo material mecánicos, a fuera llenos de polvo y mugre.(a Jefe de ruta ordeno cerrar las ventan que va directo del paciente).
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)
• Pendiente terapias fisioterapeuta
• pendiente terapias ocupacional
•Pendiente terapias fonoaudiologo

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50pm, se administra una dosis adicional según orden médica.
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (++)
Deposición (++)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral (Desayuno, almuerzo,)
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal.

Control de signos vitales
TA: 110/60mmHg
FC: 79 x'
Fr: 19 x'
SPO2: 96 %
T: 36.5 C
Entrega Aux- Lizeth Hernández
Recibe Aux- Adriana Beltrán

14/03/2026 20:00 Se administra tableta losartan 50mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

14/03/2026 20:20 Se administra capsula Amantadina 100mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

14/03/2026 20:30 Se administra tableta Citicolina 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

14/03/2026 20:50 Se administra dos cápsulas de Ácido valproico 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

14/03/2026 20:52 Se asiste a la hora de la cena , proporcionándole una dieta sólida, se le da tiempo suficiente para que mastique y trague cada bocado, antes de ofrecerle el siguiente, tolera por via oral sin complicacion, paciente colaborador, apetito conservado.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

14/03/2026 21:00 Se administra Quetiapina 200mg, mas dos tabletas Quetiapina 25mg un total administrados 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

14/03/2026 21:11 Se realiza higiene bucal con cepillo electrico y crema colgate y agua

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

14/03/2026 22:13 Se asegura la cama hospitalaria contra la pared. Se retiran ropa de vestir y se realiza lubricación de la piel con crema corporal. Posteriormente, se coloca pijama limpia y seca, paciente estable con ropa pijama piel hidratada

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

14/03/2026 22:43 Se realiza cambio de posición a decúbito lateral izquierdo, colocando almohadas de soporte en región dorsal y entre miembros inferiores para favorecer alineación corporal y confort del paciente. Durante el procedimiento, paciente presenta episodio de nerviosismo.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

14/03/2026 23:45 Se realiza cambio de posición a decúbito lateral derecho , colocando almohadas de soporte en región dorsal y entre miembros inferiores para favorecer alineación corporal y confort del paciente. Durante el procedimiento, paciente dormida con buen patrón respiratorio.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

15/03/2026 01:16 Se realiza cambio de posición a decúbito lateral izquierdo , colocando almohadas de soporte en región dorsal y entre miembros inferiores para favorecer alineación corporal y confort del paciente. Durante el procedimiento, paciente dormida con buen patrón respiratorio.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

15/03/2026 02:00 Se realiza de posición lateral derecho paciente estable dormida con buen patrón respiratorio.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

15/03/2026 03:17 se observa paciente dormida con buen patron respiratorio.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

15/03/2026 06:23 Se realiza cambio de pañal empleando los elementos necesarios (pañal limpio, toallitas húmedas, crema antipañalitis, guantes de látex). Se asegura la cama hospitalaria contra la pared. Se retiran bata de vestir y se realiza lubricación de la piel con crema corporal. Posteriormente, se coloca ropa limpia y seca, paciente estable con pijama limpia piel hidratada.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

15/03/2026 07:00 Entrego paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: Encefalopatia hipoxica,crisis epilépticas, cuadriplejia flácida y polineuropatia no especificada, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable tranquila presenta pequeños hematomas en miembros inferiores y superiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria con barandas de seguridad elevadas en posición decúbito supino.

Paciente estable desorientada en las 3 esferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO:
Paciente se mantiene hemodinámicamente estable y tranquila. Tolera adecuadamente la vía oral para la administración de medicamentos concilio sueño temprano.

15/03/2026 07:00

Recibo paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: Encefalopatia hipoxica,crisis epilépticas, cuadriplejia flácida y polineuropatia no especificada, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable tranquila presenta pequeños hematomas en miembros inferiores y superiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria, con barandas de seguridad elevadas en silla de ruedas.

Paciente estable desorientada en las 3 esferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

OBSERVACIONES
Dentro del domicilio Se observo hace tiempo fuga en el baño donde se baña la paciente, familiar niega que las auxiliares no avisaron.
• Dentro del domicilio Se observa hace tiempo material mecánicos, a fuera llenos de polvo y mugre.(a Jefe de ruta ordeno cerrar las ventan que va directo del paciente).
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)
• Pendiente terapias fisioterapeuta
• pendiente terapias ocupacional
•Pendiente terapias fonoaudiologo

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50pm, se administra una dosis adicional según orden médica.
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

SIGNOS VITALES:
TA:125/70 mmhg
Fc: 79 x'
FR:17x'
SPO2: 97 %
T:36.7 °C

Entrega Aux- Adriana Beltrán
Recibe Aux- Lizeth Hernández

15/03/2026 08:00	Se administra tableta losartan 50mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	HERNANDEZ DELGADO LIZETH
15/03/2026 08:10	Se administra tableta Esomeprazol 20mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	HERNANDEZ DELGADO LIZETH
15/03/2026 08:20	Se administra capsula Amantadina 100mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	HERNANDEZ DELGADO LIZETH
15/03/2026 08:30	Se administra tableta Citicolina 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	HERNANDEZ DELGADO LIZETH
15/03/2026 09:20	Paciente recibe y tolera dieta corriente sin complicaciones se asiste en la alimentación se observa paciente sin cambios en su estado general	HERNANDEZ DELGADO LIZETH
15/03/2026 10:40	Se realiza cambio de posición a la paciente se lubrica la piel con crema se realiza masaje y ejercicio de flexión y estiramiento sin complicaciones se observa a la paciente tranquila con buen patrón respiratorio sin cambios en su estado general	HERNANDEZ DELGADO LIZETH
15/03/2026 10:50	Se administra tableta Esomeprazol 20mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	HERNANDEZ DELGADO LIZETH

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

15/03/2026 11:30	Se administra tableta Ácido acetilsalicílico 100mg vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	HERNANDEZ DELGADO LIZETH
15/03/2026 12:10	Se realiza traslado del paciente con ayuda de grúa hacia la silla poceta. Se lleva a cabo baño general, aplicando shampoo en cuero cabelludo y retirando con enjuague; posteriormente se aplica jabón líquido corporal, se enjuaga y se procede al secado completo de la piel. Finalizado el aseo, se traslada a la cama hospitalaria con apoyo de grúa. Se realiza secado cuidadoso de la región genital y glútea, aplicando crema con nistatina y crema Almipro. Se coloca pañal limpio y se viste con ropa limpia y adecuada. Durante el procedimiento, el paciente presentó episodios de nerviosismo.	HERNANDEZ DELGADO LIZETH
15/03/2026 13:00	Se administra Acido valproico 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	HERNANDEZ DELGADO LIZETH
15/03/2026 13:15	Paciente recibe y tolera dieta corriente almuerzo sin complicaciones se asiste en la alimentación se observa paciente sin cambios en su estado general	HERNANDEZ DELGADO LIZETH
15/03/2026 14:00	Después del almuerzo se administra jarabe Escitalopram en solución oral, 20 cc, según indicación médica(psiquiatra) Tolera la administración por vía oral sin complicaciones, sin presencia de náuseas ni vómito, Paciente tranquila.	HERNANDEZ DELGADO LIZETH
15/03/2026 15:25	se observa a la paciente dormida tranquila afebril con buen patrón respiratorio sin cambios en su estado general	HERNANDEZ DELGADO LIZETH
15/03/2026 16:40	Se realiza a la paciente comodidad y confort se realiza cambio de pañal y se realiza aseo genital aplicando cremas antidermatitis y antiulceras sin complicaciones se deja pañal limpio se observa paciente con buen patrón respiratorio sin cambios en su estado general	HERNANDEZ DELGADO LIZETH
15/03/2026 17:15	se le coloca arnés a la paciente se baja de la cama en grua se coloca en silla de ruedas se le hace compañía para que vea televisión sin complicaciones se observa paciente con buen patrón respiratorio sin cambios en su estado general	HERNANDEZ DELGADO LIZETH
15/03/2026 18:10	Se realiza cambio de posición a la paciente se lubrica la piel con crema se realiza masaje y ejercicio de flexión y estiramiento sin complicaciones se observa a la paciente tranquila con buen patrón respiratorio sin cambios en su estado general	HERNANDEZ DELGADO LIZETH
15/03/2026 18:40	Se realiza a la paciente comodidad y confort se realiza cambio de pañal y se realiza aseo genital aplicando cremas antidermatitis y antiulceras sin complicaciones se deja pañal limpio se observa paciente con buen patrón respiratorio sin cambios en su estado general	

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

15/03/2026 19:00

Entrego paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: Encefalopatia hipoxica,crisis epilépticas, cuadriplejia flácida y polineuropatia no especificada, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable tranquila presenta pequeños hematomas en miembros inferiores y superiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria, con barandas de seguridad elevadas en posición Fowler.

Paciente estable desorientada en las 3 esferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO:
Paciente se mantiene hemodinámicamente estable y tranquila. Tolera adecuadamente la vía oral para la administración de medicamentos y la ingesta de alimentos, se sentó paciente en silla de ruedas estuvo estable durante el día.

OBSERVACIONES
Dentro del domicilio Se observo hace tiempo fuga en el baño donde se baña la paciente, familiar niega que las auxiliares no avisaron.
• Dentro del domicilio Se observa hace tiempo material mecánicos, a fuera llenos de polvo y mugre.(a Jefe de ruta ordeno cerrar las ventan que va directo del paciente).
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)
• Pendiente terapias fisioterapeuta
• pendiente terapias ocupacional
•Pendiente terapias fonoaudiologo

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50pm, se administra una dosis adicional según orden médica.
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (++)
Deposición (++)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral (Desayuno, almuerzo,)
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal.

Control de signos vitales
TA: 120/70 mmHg
FC: 84 x'
Fr: 17 x'
SPO2: 97 %
T: 36.7 C
Entrega Aux- Lizeth Hernández
Recibe Aux- Adriana Beltrán

15/03/2026 19:00

Recibo paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: Encefalopatia hipoxica,crisis epilépticas, cuadriplejia flácida y polineuropatia no especificada, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable tranquila presenta pequeños hematomas en miembros inferiores y superiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria con barandas de seguridad elevadas en posición decúbito supino.

Paciente estable desorientada en las 3 esferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO:
Paciente se mantiene hemodinámicamente estable y tranquila. Tolera adecuadamente la vía oral para la administración

OBSERVACIONES

• Dentro del domicilio Se observa hace tiempo material mecánicos, a fuera llenos de polvo y mugre.(a Jefe de ruta ordeno cerrar las ventan que va directo del paciente).
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

• Pendiente cita psicóloga (Mayo)
• Pendiente terapias fisioterapeuta
• pendiente terapias ocupacional
•Pendiente terapias fonoaudiologo

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50pm, se administra una dosis adicional según orden médica.
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (++)
Deposición (++)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral (Desayuno, almuerzo, media tarde)
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal.
Recibe Aux- Adriana Beltrán
Entrega Aux- Lizeth Hernandez

15/03/2026 19:11 Se retiran ropa de vestir y se realiza lubricación de la piel con crema corporal. Posteriormente, se coloca pijama limpia y seca, paciente estable con pijama limpia piel hidratada.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

15/03/2026 20:00 Se administra tableta losartan 50mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

15/03/2026 20:16 Se asiste a la hora de la cena , proporcionándole una dieta sólida, se le da tiempo suficiente para que mastique y trague cada bocado, antes de ofrecerle el siguiente, tolera por via oral sin complicacion, paciente colaborador, apetito conservado.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

15/03/2026 20:20 Se administra capsula Amantadina 100mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

15/03/2026 20:30 Se administra tableta Citicolina 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

15/03/2026 20:30 Se administra tableta Citicolina 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

15/03/2026 20:50	Se administra dos cápsulas de Ácido valproico 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
15/03/2026 21:00	Se administra Quetiapina 200mg, mas dos tabletas Quetiapina 25mg un total administrados 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
15/03/2026 21:45	Paciente presenta episodios de llanto y nerviosismo. Se aplican medidas de confort, realizando masaje con aceite esencial en cuello y espalda. Por indicación de familiar, se administran gotas esenciales "Calma". Se coloca humidificador con gotas naturales con el fin de favorecer la relajación de la paciente.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
15/03/2026 22:15	Se realiza higiene bucal a paciente utilizando los elementos necesarios (cepillo dental, crema dental, vaso con agua y toalla). Se limpia cavidad oral y se enjuaga adecuadamente. Paciente queda cómoda y sin novedades.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
15/03/2026 22:34	Se realiza higiene y cambio de pañal utilizando los elementos necesarios: pañal limpio, toallitas húmedas, crema antipañalitis y guantes de látex. Se deja a la paciente cómoda en cama hospitalaria. Se realiza cambio de posición a decúbito lateral izquierdo, colocando almohadas de soporte en región dorsal y entre miembros inferiores para favorecer alineación corporal y confort del paciente. Durante el procedimiento, paciente presenta episodio de nerviosismo.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
15/03/2026 23:18	Se observa paciente dormida con buen patrón respiratorio.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
15/03/2026 23:45	Se observa paciente dormida con buen patrón respiratorio.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
16/03/2026 03:00	Se observa paciente dormida con buen patrón respiratorio, se realiza cambio posición lateral derecho.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
16/03/2026 04:52	Se realiza cambio de posicion semifowler, se observa paciente dormida con buen patrón respiratorio.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

16/03/2026 05:00 Se administra Acido valproico 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

16/03/2026 06:12 Se realiza cambio de pañal empleando los elementos necesarios (pañal limpio, toallitas húmedas, crema antipañalitis, guantes de látex). Se asegura la cama hospitalaria contra la pared.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

16/03/2026 06:40 se realiza estiramiento de sábanas para comodidad de paciente, se deja libre de arrugas, realizo cambio de posición derecho decúbito supino.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

16/03/2026 07:00 Recibo paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: Encefalopatia hipoxica,crisis epilépticas, cuadriplejia flácida y polineuropatia no especificada, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable tranquila presenta pequeños hematomas en miembros inferiores y superiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en cama hospitlaria posición decubito supino colchón antiescaras ,paciente en el programa de atención domiciliaria con barandas de seguridad elevadas en posición decúbito supino.

Paciente estable desorientada en las 3 esferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara con olor fuerte , extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO:
Paciente se mantiene dormida. Durante el turno paciente Tolera adecuadamente la vía oral para la administración de medicamentos. Concilio sueño temprano.

OBSERVACIONES
* Dentro del domicilio Se observa hace tiempo material mecánicos, a fuera llenos de polvo y mugre.(a Jefe de ruta ordeno cerrar las ventan que va directo del paciente).
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.
•Se evidencia que la grúa de movilización presenta fallas en su funcionamiento, también se observa que el chaleco (arnés)
Utilizado para la movilización de la paciente se encuentra deteriorado.(presenta desgaste en sus sujeciones) Por lo tanto requiere mantenimiento, se decide suspender su uso apartir de la fecha

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
* Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
* Pendiente cita psicóloga (Mayo)
* Pendiente terapias fisioterapeuta
* pendiente terapias ocupacional
•Pendiente terapias fonoaudiologo

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50 pm un a dosis adicional por orden médica
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (++)
Deposición (+)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral(cena)
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal.
terapia con la pelota ejercicios en miembros superiores e inferiores.

16/03/2026 07:00

Entrego paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: Encefalopatia hipoxica,crisis epilépticas, cuadriplejia flácida y polineuropatia no especificada, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable tranquila presenta pequeños hematomas en miembros inferiores y superiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria con barandas de seguridad elevadas en posición decúbito supino.

Paciente estable desorientada en las 3 esferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión,
extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO:
Paciente se mantiene hemodinámicamente estable y tranquila. Tolera adecuadamente la vía oral para la administración, concilio sueño temprano.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

OBSERVACIONES

• Dentro del domicilio Se observa hace tiempo material mecánicos, a fuera llenos de polvo y mugre.(a Jefe de ruta ordeno cerrar las ventan que va directo del paciente).
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)
• Pendiente terapias fisioterapeuta
• pendiente terapias ocupacional
•Pendiente terapias fonoaudiologo

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50pm, se administra una dosis adicional según orden médica.
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (++)
Deposición (+)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente (cena)
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal.
Entrega Aux- Adriana Beltrán
Recibe Aux- Lizeth Hernandez

16/03/2026 08:00 Se administra tableta losartan 50mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

16/03/2026 08:10 Se administra tableta Esomeprazol 20mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

16/03/2026 08:10 Se administra tableta Amlodipino 5mg vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

16/03/2026 08:20 Se administra capsula Amantadina 100mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

16/03/2026 08:30 Se administra tableta Citicolina 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

16/03/2026 08:50 Se administra dos cápsulas de Ácido valproico 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

16/03/2026 09:00 Paciente recibe y tolera dieta corriente sin complicaciones se asiste en la alimentación se observa paciente sin cambios en su estado general

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

16/03/2026 10:30 Se realiza cambio de posición a la paciente se lubrica la piel con crema se realiza masaje y ejercicio de flexión y estiramiento sin complicaciones se observa a la paciente tranquila con buen patrón respiratorio sin cambios en su estado general

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

16/03/2026 11:30 Se administra tableta Ácido acetilsalicílico 100mg vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

16/03/2026 12:10 se realiza ejercicios a la paciente de estimulación con la pelota la paciente colabora se observa estable con buen patrón respiratorio sin cambios en su estado general

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

16/03/2026 13:00 Se realiza traslado del paciente con ayuda de grúa hacia la silla poceta. Se lleva a cabo baño general, aplicando shampoo en cuero cabelludo y retirando con enjuague; posteriormente se aplica jabón líquido corporal, se enjuaga y se procede al secado completo de la piel. Finalizado el aseo, se traslada a la cama hospitalaria con apoyo de grúa. Se realiza secado cuidadoso de la región genital y glútea, aplicando crema con nistatina y crema Almipro. Se coloca pañal limpio y se viste con ropa limpia y adecuada. Durante el procedimiento, el paciente presentó episodios de nerviosismo.

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

16/03/2026 13:15 Se administra Acido valproico 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

16/03/2026 14:00 Paciente recibe y tolera dieta corriente almuerzo sin complicaciones se asiste en la alimentación se observa paciente sin cambios en su estado general

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

16/03/2026 14:40

Después del almuerzo se administra jarabe Escitalopram en solución oral, 20 cc, según indicación médica(psiquiatra) Tolera la administración por vía oral sin complicaciones, sin presencia de náuseas ni vómito, Paciente tranquila.

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

16/03/2026 16:45

Se realiza a la paciente comodidad y confort se realiza cambio de pañal y se realiza aseo genital aplicando cremas antidermatitis y antiulceras sin complicaciones se deja pañal limpio se observa paciente con buen patrón respiratorio sin cambios en su estado general

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

16/03/2026 18:15

paciente recibe terapia de fonoaudiólogia por el profesional Jonathan Ibáñez se utiliza la grua para movilizar a la paciente se traslada a silla de ruedas sin complicaciones se arregla la unidad cama y tendidos se observa paciente en buen estado general sin cambios

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

16/03/2026 19:00

Entrego paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: Encefalopatia hipoxica,crisis epilépticas, cuadriplejia flácida y polineuropatia no especificada, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable tranquila presenta pequeños hematomas en miembros inferiores y superiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria con barandas de seguridad elevadas en posición decúbito supino.

Paciente estable desorientada en las 3 esferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

OBSERVACIONES

• Dentro del domicilio Se observa hace tiempo material mecánicos, a fuera llenos de polvo y mugre.(a Jefe de ruta ordeno cerrar las ventan que va directo del paciente).
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

• Pendiente terapias fisioterapeuta
• pendiente terapias ocupacional
•Pendiente terapias fonoaudiologo

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50pm, se administra una dosis adicional según orden médica.
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (++)
Deposición (+)

Control de signos vitales
TA:125/70mmHg
FC: 78x'
Fr: 18x
SPO2: 97%
T: 36.5°C

Entrega Aux- Adriana Beltrán
Recibe Aux- Lizeth Hernandez

16/03/2026 19:00

Entrego paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: Encefalopatia hipoxica,crisis epilépticas, cuadriplejia flácida y polineuropatia no especificada, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable tranquila presenta pequeños hematomas en miembros inferiores y superiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria, con barandas de seguridad elevadas en posición Fowler.

Paciente estable desorientada en las 3 esferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO:
Paciente se mantiene hemodinámicamente estable y tranquila. Tolera adecuadamente la vía oral para la administración de medicamentos y la ingesta de alimentos, se sentó paciente en silla de ruedas recibió terapia de fonoaudiología sin complicaciones estuvo estable durante el día.

OBSERVACIONES
Dentro del domicilio Se observo hace tiempo fuga en el baño donde se baña la paciente, familiar niega que las auxiliares no avisaron.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

• Dentro del domicilio Se observa hace tiempo material mecánicos, a fuera llenos de polvo y mugre.(a Jefe de ruta ordeno cerrar las ventan que va directo del paciente).
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)
• Pendiente terapias fisioterapeuta
• pendiente terapias ocupacional
•Pendiente terapias fonoaudiologo

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50pm, se administra una dosis adicional según orden médica.
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (++)
Deposición (++)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral (Desayuno, almuerzo,)
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal.

Control de signos vitales
TA: 135/80 mmHg
FC: 76 x'
Fr: 18 x'
SPO2: 98 %
T: 36.5 C
Entrega Aux- Lizeth Hernández
Recibe Aux- Adriana Beltrán

16/03/2026 19:00

Recibo paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: Encefalopatia hipoxica,crisis epilépticas, cuadriplejia flácida y polineuropatia no especificada, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable tranquila presenta pequeños hematomas en miembros inferiores y superiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria.
Paciente en silla de ruedas.

Paciente estable desorientada en las 3 esferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO:
Paciente se mantiene hemodinámicamente estable y tranquila. Tolera adecuadamente la vía oral para la administración de medicamentos y la ingesta de alimentos, se sentó paciente en silla de ruedas recibió terapia de fonoaudiología sin complicaciones estuvo estable durante el día.

OBSERVACIONES
Dentro del domicilio Se observo hace tiempo fuga en el baño donde se baña la paciente, familiar niega que las auxiliares no avisaron.
• Dentro del domicilio Se observa hace tiempo material mecánicos, a fuera llenos de polvo y mugre.(a Jefe de ruta ordeno cerrar las ventan que va directo del paciente).
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)
• Pendiente terapias fisioterapeuta
• pendiente terapias ocupacional
•Pendiente terapias fonoaudiologo

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50pm, se administra una dosis adicional según orden médica.
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (++)
Deposición (++)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral (Desayuno, almuerzo,)
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal.
Recibe Aux- Adriana Beltrán
Entrega Aux- Lizeth Hernández

16/03/2026 19:10 Se asiste a la hora de la cena , proporcionándole una dieta sólida, se le da tiempo suficiente para que mastique y trague cada bocado, antes de ofrecerle el siguiente, tolera por via oral sin complicacion, paciente colaborador, apetito

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

conservado.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

16/03/2026 20:00 Se administra tableta losartan 50mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

16/03/2026 20:20 Se administra capsula Amantadina 100mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

16/03/2026 20:30 Se administra tableta Citicolina 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

16/03/2026 20:50 Se administra dos cápsulas de Ácido valproico 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

16/03/2026 21:00 Se administra Quetiapina 200mg, mas dos tabletas Quetiapina 25mg un total administrados 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

16/03/2026 21:25 Se realiza higiene bucal con cepillo electrico y crema colgate y agua. Se traslada paciente en grúa a la cama hospitalaria.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

16/03/2026 21:39 Se retiran ropa de vestir y se realiza lubricación de la piel con crema corporal. Posteriormente, se coloca bata limpia y seca, paciente estable con bata limpia piel hidratada, permanece en cama hospitalaria bajo vigilancia y acompañamiento.
Se realiza cambio de pañal empleando los elementos necesarios (pañal limpio, toallitas húmedas, crema antipañalitis, guantes de látex). Se asegura la cama hospitalaria contra la pared.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

16/03/2026 21:39 Se realiza cambio de posición a decúbito lateral izquierdo, colocando almohadas de soporte en región dorsal y entre miembros inferiores para favorecer alineación corporal y confort del paciente. Durante el procedimiento, paciente presenta episodio de nerviosismo.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

16/03/2026 23:39 Se realiza cambio de posición a decúbito lateral derecho, colocando almohadas de soporte en región dorsal y entre miembros inferiores para favorecer alineación corporal y confort del paciente. Durante el procedimiento, paciente presenta episodio de nerviosismo.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

17/03/2026 03:15 se realiza ejercicios a la paciente de estimulación con la pelota y se sienta en la silla de ruedas con ayuda de la grua la paciente colabora se observa estable con buen patrón respiratorio sin cambios en su estado general

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

17/03/2026 03:20 Se observa paciente despierta, hablando sola, se hace cambio de posición decúbito supino.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

17/03/2026 04:36 Se observa paciente dormida con buen patrón respiratorio..

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

17/03/2026 05:00 Se administra Acido valproico 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

17/03/2026 06:18 Se retiran bata de vestir y se realiza lubricación de la piel con crema corporal. Posteriormente, se coloca bata limpia y seca, paciente estable con bata limpia piel hidratada,
Se realiza cambio de pañal empleando los elementos necesarios (pañal limpio, toallitas húmedas, crema antipañalitis, guantes de látex). Se asegura la cama hospitalaria contra la pared.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

17/03/2026 06:45 Se realiza higiene bucal con cepillo electrico y crema colgate y agua, se realiza limpieza facial con agua y toallitas húmedas. Se peina paciente.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

17/03/2026 06:48 Se realiza cambio de sábanas garantizando limpieza y comodidad del paciente, dejando la superficie libre de arrugas, realizo cambio de posición semifowler.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

17/03/2026 07:00 Recibo paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: Encefalopatia hipoxica,crisis epilépticas, cuadriplejia flácida y polineuropatia no especificada, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable tranquila presenta pequeños hematomas en miembros inferiores y superiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria con barandas de seguridad elevadas en posición decúbito supino.

Paciente estable desorientada en las 3 esferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

OBSERVACIONES

• Dentro del domicilio Se observa hace tiempo material mecánicos, a fuera llenos de polvo y mugre.(a Jefe de ruta ordeno cerrar las ventan que va directo del paciente).
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)
• Pendiente terapias fisioterapeuta
• pendiente terapias ocupacional
•Pendiente terapias fonoaudiologo

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50pm, se administra una dosis adicional según orden médica.
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (++)
Deposición (+)

Control de signos vitales
TA:130/80 mmHg
FC: 82 x'
Fr: 17 x
SPO2: 98 %
T: 36.5°C

Entrega Aux- Adriana Beltrán
Recibe Aux- Lizeth Hernandez

17/03/2026 07:00

Entrego paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: Encefalopatia hipoxica,crisis epilépticas, cuadriplejia flácida y polineuropatia no especificada, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable tranquila presenta pequeños hematomas en miembros inferiores y superiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Adriana

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria, barandas de seguridad en posición semifowler.

Paciente estable desorientada en las 3 esferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO:
Paciente se mantiene hemodinámicamente estable y tranquila. Tolera adecuadamente la vía oral para la administración de medicamentos y la ingesta de alimentos, Concilio sueño temprano en horas de la mañana presento verbalizacion.

OBSERVACIONES
Dentro del domicilio Se observo hace tiempo fuga en el baño donde se baña la paciente, familiar niega que las auxiliares no avisaron.
• Dentro del domicilio Se observa hace tiempo material mecánicos, a fuera llenos de polvo y mugre.(a Jefe de ruta ordeno cerrar las ventan que va directo del paciente).
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)
• Pendiente terapias fisioterapeuta
• pendiente terapias ocupacional
•Pendiente terapias fonoaudiologo

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50pm, se administra una dosis adicional según orden médica.
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (++)
Deposición (-)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral (Desayuno, almuerzo,)
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

Higiene aseo personal.
Entrega Aux- Adriana Beltrán
Recibe Aux- Lizeth Hernández

17/03/2026 08:00 Se administra tableta losartan 50mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

17/03/2026 08:10 Se administra tableta Esomeprazol 20mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

17/03/2026 08:20 Se administra capsula Amantadina 100mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

17/03/2026 08:30 Se administra tableta Citicolina 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

17/03/2026 09:00 Fisioterapeuta Andrés Rodríguez realiza terapia física a la paciente en la unidad sin complicaciones se observa paciente cooperativa con buen patrón respiratorio sin cambios en su estado general

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

17/03/2026 10:20 Paciente recibe y tolera dieta corriente desayuno sin complicaciones se asiste en la alimentación se observa paciente sin cambios en su estado general

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

17/03/2026 11:15 Se realiza cambio de posición a la paciente se lubrica la piel con crema se realiza masaje y ejercicio de flexión y estiramiento sin complicaciones se observa a la paciente tranquila con buen patrón respiratorio sin cambios en su estado general

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

17/03/2026 11:30 Se administra tableta Ácido acetilsalicílico 100mg vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

17/03/2026 12:10 Se realiza traslado del paciente con ayuda de grúa hacia la silla poceta. Se lleva a cabo baño general, aplicando shampoo en cuero cabelludo y retirando con enjuague; posteriormente se aplica jabón líquido corporal, se enjuaga y se procede al secado completo de la piel. Finalizado el aseo, se traslada a la cama hospitalaria con apoyo de grúa. Se realiza secado cuidadoso de la región genital y glútea, aplicando crema con nistatina y crema Almipro. Se coloca pañal limpio y se viste con ropa limpia y adecuada. Durante el procedimiento, el paciente presentó episodios de nerviosismo.

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

17/03/2026 13:00 Se administra Acido valproico 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

17/03/2026 13:25 Paciente recibe y tolera dieta corriente almuerzo sin complicaciones se asiste en la alimentación se observa paciente sin cambios en su estado general

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

17/03/2026 14:00 Después del almuerzo se administra jarabe Escitalopram en solución oral, 20 cc, según indicación médica(psiquiatra) Tolera la administración por vía oral sin complicaciones, sin presencia de náuseas ni vómito, Paciente tranquila.

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

17/03/2026 15:15 se realiza ejercicios a la paciente de estimulación con la pelota y se sienta en la silla de ruedas con ayuda de la grua la paciente colabora se observa estable con buen patrón respiratorio sin cambios en su estado general

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

17/03/2026 17:20 Se realiza a la paciente comodidad y confort se realiza cambio de pañal y se realiza aseo genital aplicando cremas antidermatitis y antiulceras sin complicaciones se deja pañal limpio se observa paciente con buen patrón respiratorio sin cambios en su estado general

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

17/03/2026 18:30 se observa a la paciente dormida tranquila afebril con buen patrón respiratorio sin cambios en su estado general

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

17/03/2026 19:00 Recibo paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: Encefalopatia hipoxica,crisis epilépticas, cuadriplejia flácida y polineuropatia no especificada, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable tranquila presenta pequeños hematomas en miembros inferiores y superiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria, con barandas de seguridad elevadas en posición Fowler.

Paciente estable desorientada en las 3 esferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO:
Paciente se mantiene hemodinámicamente estable y tranquila. Tolera adecuadamente la vía oral para la administración de medicamentos y la ingesta de alimentos, paciente en silla de ruedas, tolero las terapias físicas particulares.

OBSERVACIONES
Dentro del domicilio Se observo hace tiempo fuga en el baño donde se baña la paciente, familiar niega que las auxiliares no avisaron.
• Dentro del domicilio Se observa hace tiempo material mecánicos, a fuera llenos de polvo y mugre.(a Jefe de ruta ordeno cerrar las ventan que va directo del paciente).
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)
• Pendiente terapias fisioterapeuta
• pendiente terapias ocupacional
•Pendiente terapias fonoaudiologo

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50pm, se administra una dosis adicional según orden médica.
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (++)
Deposición (++)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral (Desayuno, almuerzo,)
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal.
Recibe Aux- Adriana Beltrán
Entrega Aux- Lizeth Hernandez

17/03/2026 19:00

Entrego paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: Encefalopatia hipoxica,crisis epilépticas, cuadriplejia flácida y polineuropatia no especificada, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable tranquila presenta pequeños hematomas en miembros inferiores y superiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria, con barandas de seguridad elevadas en posición Fowler.

Paciente estable desorientada en las 3 esferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado,

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO:
Paciente se mantiene hemodinámicamente estable y tranquila. Tolera adecuadamente la vía oral para la administración de medicamentos y la ingesta de alimentos, se sentó paciente en silla de ruedas recibió terapia física sin complicaciones estuvo estable durante el día.

OBSERVACIONES
Dentro del domicilio Se observo hace tiempo fuga en el baño donde se baña la paciente, familiar niega que las auxiliares no avisaron.
• Dentro del domicilio Se observa hace tiempo material mecánicos, a fuera llenos de polvo y mugre.(a Jefe de ruta ordeno cerrar las ventan que va directo del paciente).
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)
• Pendiente terapias fisioterapeuta
• pendiente terapias ocupacional
•Pendiente terapias fonoaudiologo

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50pm, se administra una dosis adicional según orden médica.
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (++)
Deposición (++)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral (Desayuno, almuerzo,)
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal.

Control de signos vitales

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

TA: 110/60 mmHg
FC: 82 x'
Fr: 17 x'
SPO2: 97 %
T: 36.5 C
Entrega Aux- Lizeth Hernández
Recibe Aux- Adriana Beltrán

17/03/2026 20:00 Se administra tableta losartan 50mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

17/03/2026 20:20 Se administra capsula Amantadina 100mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

17/03/2026 20:30 Se administra tableta Citicolina 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

17/03/2026 20:50 Se administra dos cápsulas de Ácido valproico 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

17/03/2026 20:57 Se asiste a la hora de la cena , proporcionándole una dieta sólida, se le da tiempo suficiente para que mastique y trague cada bocado, antes de ofrecerle el siguiente, tolera por via oral sin complicacion, paciente colaborador, apetito conservado.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

17/03/2026 21:00 Se administra Quetiapina 200mg, mas dos tabletas Quetiapina 25mg un total administrados 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

17/03/2026 21:45 Se realiza higiene bucal con cepillo electrico y crema colgate y agua. Se realiza cambio de pañal empleando los elementos necesarios (pañal limpio, toallitas húmedas, crema antipañalitis, guantes de látex). Se asegura la cama hospitalaria contra la pared.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

17/03/2026 22:40 Se aplica crema corporal en miembros superiores e inferiores. Se realiza cambio de posición a decúbito lateral izquierdo, colocando almohadas de soporte en región dorsal y entre miembros inferiores para favorecer alineación corporal y confort del paciente. Durante el procedimiento, paciente presenta episodio de nerviosismo.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

17/03/2026 23:20 Se observa paciente dormida con buen patrón respiratorio.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

18/03/2026 01:21

Se realiza cambio de posición a decúbito lateral derecho, colocando almohadas de soporte en región dorsal y entre miembros inferiores para favorecer alineación corporal y confort del paciente. Durante el procedimiento, paciente presenta episodio de nerviosismo.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

18/03/2026 02:25

Se observa paciente dormida con buen patrón respiratorio.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

18/03/2026 03:25

Se realiza cambio de posición a la paciente se lubrica la piel con crema se realiza masaje y ejercicio de flexión y estiramiento sin complicaciones se observa a la paciente tranquila con buen patrón respiratorio sin cambios en su estado general

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

18/03/2026 03:40

Se realiza cambio de posición a decúbito lateral izquierdo, colocando almohadas de soporte en región dorsal y entre miembros inferiores para favorecer alineación corporal y confort del paciente.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

18/03/2026 03:40

Se realiza cambio de posición a decúbito lateral izquierdo, colocando almohadas de soporte en región dorsal y entre miembros inferiores para favorecer alineación corporal y confort del paciente.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

18/03/2026 05:00

Se administra Acido valproico 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

18/03/2026 06:39

Se realiza tendido de sábanas garantizando limpieza y comodidad del paciente, dejando la superficie libre de arrugas, se procede a realiza cambio de pañal empleando los elementos necesarios (pañal limpio, toallitas húmedas, crema antipañalitis, guantes de látex). Se asegura la cama hospitalaria contra la pared para aportar mayor seguridad al paciente.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

18/03/2026 07:00

Recibo paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: Encefalopatia hipoxica,crisis epilépticas, cuadriplejia flácida y polineuropatia no especificada, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable dormida con buen patrón respiratorio presenta pequeños hematomas en miembros inferiores y superiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria, con barandas de seguridad elevadas posición decúbito supino.

Paciente estable desorientada en las 3 esferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

OBSERVACIONES
• Dentro del domicilio Se observa hace tiempo material mecánicos, a fuera llenos de polvo y mugre.(a Jefe de ruta ordeno cerrar las ventana que va directo del paciente).
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)
• Pendiente terapias fisioterapeuta
• pendiente terapias ocupacional
•Pendiente terapias fonoaudiologo

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50pm, se administra una dosis adicional según orden médica.
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (++)
Deposición (-)

Control de signos vitales
TA: 130/85mmHg
FC: 80 x'
Fr: 16 x'
SPO2: 95%
T: 37.3C

Entrega Aux- Adriana Beltrán
Recibe Aux- Lizeth Hernandez

18/03/2026 07:00 Entrego paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: Encefalopatia hipoxica,crisis epilépticas, cuadriplejia flácida y polineuropatia no especificada, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

Adriana

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable dormida con buen patrón respiratorio presenta pequeños hematomas en miembros inferiores y superiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

atención domiciliaria, con barandas de seguridad elevadas posición decúbito supino.

Paciente estable desorientada en las 3 esferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO:
Paciente se mantiene hemodinámicamente estable y tranquila. Tolera adecuadamente la vía oral para la administración de medicamentos y la ingesta de alimentos, Concilio sueño temprano.

OBSERVACIONES
• Dentro del domicilio Se observa hace tiempo material mecánicos, a fuera llenos de polvo y mugre.(a Jefe de ruta ordeno cerrar las ventan que va directo del paciente).
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)
• Pendiente terapias fisioterapeuta
• pendiente terapias ocupacional
•Pendiente terapias fonoaudiologo

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50pm, se administra una dosis adicional según orden médica.
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (++)
Deposición (--)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral (Cena)
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal.
Entrega Aux- Adriana Beltrán
Recibe Aux- Lizeth Hernandez

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

18/03/2026 08:00	Se administra tableta losartan 50mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	HERNANDEZ DELGADO LIZETH
18/03/2026 08:10	Se administra tableta Esomeprazol 20mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	HERNANDEZ DELGADO LIZETH
18/03/2026 08:20	Se administra capsula Amantadina 100mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	HERNANDEZ DELGADO LIZETH
18/03/2026 08:30	Se administra tableta Citicolina 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	HERNANDEZ DELGADO LIZETH
18/03/2026 09:24	Paciente recibe y tolera dieta corriente sin complicaciones se asiste en la alimentación se observa paciente sin cambios en su estado general	HERNANDEZ DELGADO LIZETH
18/03/2026 10:35	se realiza ejercicios a la paciente de estimulación con la pelota la paciente colabora se observa estable con buen patrón respiratorio sin cambios en su estado general	HERNANDEZ DELGADO LIZETH
18/03/2026 11:30	Se administra tableta Ácido acetilsalicílico 100mg vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	HERNANDEZ DELGADO LIZETH
18/03/2026 12:35	Se realiza traslado del paciente con ayuda de grúa hacia la silla poceta. Se lleva a cabo baño general, aplicando shampoo en cuero cabelludo y retirando con enjuague; posteriormente se aplica jabón líquido corporal, se enjuaga y se procede al secado completo de la piel. Finalizado el aseo, se traslada a la cama hospitalaria con apoyo de grúa. Se realiza secado cuidadoso de la región genital y glútea, aplicando crema con nistatina y crema Almipro. Se coloca pañal limpio y se viste con ropa limpia y adecuada. Durante el procedimiento, el paciente presentó episodios de nerviosismo.	HERNANDEZ DELGADO LIZETH
18/03/2026 13:00	Se administra Acido valproico 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	HERNANDEZ DELGADO LIZETH
18/03/2026 13:15	Paciente recibe y tolera dieta corriente almuerzo sin complicaciones se asiste en la alimentación se observa paciente sin cambios en su estado general	

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

18/03/2026 14:00	Después del almuerzo se administra jarabe Escitalopram en solución oral, 20 cc, según indicación médica(psiquiatra) Tolera la administración por vía oral sin complicaciones, sin presencia de náuseas ni vómito, Paciente tranquila.	HERNANDEZ DELGADO LIZETH
18/03/2026 15:25	Se realiza cambio de posición a la paciente se lubrica la piel con crema se realiza masaje y ejercicio de flexión y estiramiento sin complicaciones se observa a la paciente tranquila con buen patrón respiratorio sin cambios en su estado general	HERNANDEZ DELGADO LIZETH
18/03/2026 17:30	Se realiza a la paciente comodidad y confort se realiza cambio de pañal y se realiza aseo genital aplicando cremas antidermatitis y antiulceras sin complicaciones se deja pañal limpio se observa paciente con buen patrón respiratorio sin cambios en su estado general	HERNANDEZ DELGADO LIZETH
18/03/2026 18:00	paciente recibe terapia de fonoaudiólogia por el profesional Jonathan Ibáñez se utiliza la grua para movilizar a la paciente se traslada a silla de ruedas sin complicaciones se arregla la unidad cama y tendidos se observa paciente en buen estado general sin cambios	HERNANDEZ DELGADO LIZETH
18/03/2026 19:00	Entrego paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO DX: Encefalopatia hipoxica,crisis epilépticas, cuadriplejia flácida y polineuropatia no especificada, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida. Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable dormida con buen patrón respiratorio presenta pequeños hematomas en miembros inferiores y superiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes. Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria, con barandas de seguridad elevadas posición decúbito supino. Paciente estable desorientada en las 3 esferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica, Ojos normoreactivos a la luz, Mucosa nasal húmeda sin laceraciones, Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis). NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO: Paciente se mantiene hemodinámicamente estable y tranquila. Tolera adecuadamente la vía oral para la administración de medicamentos y la ingesta de alimentos, se realizo terapia de fonoaudiólogia, auxiliar realizo ejercicios en miembros superiores e inferiores y se utilizo pelotas con incentivo. OBSERVACIONES • Dentro del domicilio Se observa hace tiempo material mecánicos, a fuera llenos de polvo y mugre.(a Jefe de ruta ordeno cerrar las ventan que va directo del paciente). •Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco •observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.	HERNANDEZ DELGADO LIZETH

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)
• Pendiente terapias fisioterapeuta
• pendiente terapias ocupacional
•Pendiente terapias fonoaudiologo

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50pm, se administra una dosis adicional según orden médica.
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (++)
Deposición (+)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral (desayuno, almuerzo)
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal.
terapia con la pelota ejercicios en miembros superiores e inferiores.

Control de signos vitales
TA: 110/70 mmHg
FC: 87x'
Fr: 17 x'
SPO2: 97%
T: 36.5 'C

Entrega Aux- Lizeth Hernández
Recibe Aux- Adriana Beltrán

18/03/2026 19:00

Recibo paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: Encefalopatia hipoxica,crisis epilépticas, cuadriplejia flácida y polineuropatia no especificada, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable dormida con buen patrón respiratorio presenta pequeños hematomas en miembros inferiores y superiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria, con barandas de seguridad elevadas posición decúbito supino.

Paciente estable desorientada en las 3 esferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO:
Paciente se mantiene hemodinámicamente estable y tranquila. Tolera adecuadamente la vía oral para la administración de medicamentos y la ingesta de alimentos, se realizo terapia de fonoaudiólogia, auxiliar realizo ejercicios en miembros superiores e inferiores y se utilizo pelotas con incentivo.

OBSERVACIONES
• Dentro del domicilio Se observa hace tiempo material mecánicos, a fuera llenos de polvo y mugre.(a Jefe de ruta ordeno cerrar las ventan que va directo del paciente).
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)
• Pendiente terapias fisioterapeuta
• pendiente terapias ocupacional
•Pendiente terapias fonoaudiologo

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50pm, se administra una dosis adicional según orden médica.
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (++)
Deposición (+)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral (desayuno, almuerzo)
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal.
terapia con la pelota ejercicios en miembros superiores e inferiores.
Entrega Aux- Lizeth Hernández
Recibe Aux- Adriana Beltrán

18/03/2026 20:00 Se administra tableta losartan 50mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

Adriana

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

18/03/2026 20:20	Se administra capsula Amantadina 100mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
18/03/2026 20:30	Se administra tableta Citicolina 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
18/03/2026 20:50	Se administra dos cápsulas de Ácido valproico 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
18/03/2026 21:00	Se administra Quetiapina 200mg, mas dos tabletas Quetiapina 25mg un total administrados 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
18/03/2026 21:08	Se asiste a la hora de la cena , proporcionándole una dieta sólida, se le da tiempo suficiente para que mastique y trague cada bocado, antes de ofrecerle el siguiente, tolera por via oral sin complicacion, paciente colaborador, apetito conservado.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
18/03/2026 21:27	Se procede a realiza cambio de pañal empleando los elementos necesarios (pañal limpio, toallitas húmedas, crema antipañalitis, guantes de látex). Se retiran prendas de vestir, se realiza higiene corporal y se aplica crema hidratante en piel para favorecer la integridad cutánea. Posteriormente, se coloca pijama.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
18/03/2026 22:23	Se realiza cambio de posición a decúbito lateral izquierdo, colocando almohadas de soporte en región dorsal y entre miembros inferiores para favorecer alineación corporal y confort del paciente. Durante el procedimiento, paciente presenta episodio de nerviosismo.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
18/03/2026 23:24	Se observa paciente despierta, tranquila.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
18/03/2026 23:51	Se realiza cambio de posición a decúbito lateral izquierdo, colocando almohadas de soporte en región dorsal y entre miembros inferiores para favorecer alineación corporal y confort del paciente. Durante el procedimiento, paciente presenta episodio de nerviosismo.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
19/03/2026 04:04	Se observa paciente dormida con buen patrón respiratorio.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

19/03/2026 05:00	Se administra Acido valproico 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
19/03/2026 06:23	Se realiza cambio de pañal empleando los elementos necesarios (pañal limpio, toallitas húmedas, crema antipañalitis, guantes de látex). Se asegura la cama hospitalaria contra la pared.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
19/03/2026 06:37	Se retira pijama y se realiza lubricación de la piel con crema corporal. Posteriormente, se coloca ropa limpia y seca, paciente estable con ropa limpia piel hidratada.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
19/03/2026 06:55	Se realiza cambio de sábanas garantizando limpieza y comodidad del paciente, dejando la superficie libre de arrugas, realizo cambio de posición decúbito supino, paciente estable y tranquila.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
19/03/2026 07:00	Entrego paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO DX: Encefalopatia hipoxica,crisis epilépticas, cuadriplejia flácida y polineuropatia no especificada, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida. Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable dormida con buen patrón respiratorio presenta pequeños hematomas en miembros inferiores y superiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes. Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria, con barandas de seguridad elevadas posición decúbito supino. Paciente estable desorientada en las 3 esferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica, Ojos normoreactivos a la luz, Mucosa nasal húmeda sin laceraciones, Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis). NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO: Paciente se mantiene hemodinámicamente estable y tranquila. Tolera adecuadamente la vía oral para la administración de medicamentos y la ingesta de alimentos, Presento insomnio. OBSERVACIONES • Dentro del domicilio Se observa hace tiempo material mecánicos, a fuera llenos de polvo y mugre.(a Jefe de ruta ordeno cerrar las ventan que va directo del paciente). •Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco •observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada. •Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)
• Pendiente terapias fisioterapeuta
• pendiente terapias ocupacional
•Pendiente terapias fonoaudiologo

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50pm, se administra una dosis adicional según orden médica.
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (++)
Deposición (-)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral (cena)
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal.
terapia con la pelota ejercicios en miembros superiores e inferiores.
Entrega Aux- Adriana Beltrán
Recibe Aux- Lizeth Hernández

19/03/2026 07:00

Recibo paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: Encefalopatia hipoxica,crisis epilépticas, cuadriplejia flácida y polineuropatia no especificada, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable dormida con buen patrón respiratorio presenta pequeños hematomas en miembros inferiores y superiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria, con barandas de seguridad elevadas posición decúbito supino.

Paciente estable desorientada en las 3 esferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

OBSERVACIONES
• Dentro del domicilio Se observa hace tiempo material mecánicos, a fuera llenos de polvo y mugre.(a Jefe de ruta ordeno cerrar las ventan que va directo del paciente).
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)
• Pendiente terapias fisioterapeuta
• pendiente terapias ocupacional
•Pendiente terapias fonoaudiologo

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50pm, se administra una dosis adicional según orden médica.
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Control de signos vitales
TA:130/90 mmHg
FC: 84 x'
Fr:17x'
SPO2: 98 %
T: 36.7 'C

Entrega Aux- Adriana Beltrán
Recibe Aux- Lizeth Hernández

19/03/2026 08:00 Se administra tableta losartan 50mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

19/03/2026 08:10 Se administra tableta Esomeprazol 20mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

19/03/2026 08:20 Se administra capsula Amantadina 100mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

19/03/2026 08:30 Se administra tableta Citicolina 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

19/03/2026 09:20 Fisioterapeuta Andrés Rodríguez realiza terapia física a la paciente en la unidad sin complicaciones se observa paciente cooperativa con buen patrón respiratorio sin cambios en su estado general

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

19/03/2026 10:35 Paciente recibe y tolera dieta corriente desayuno sin complicaciones se asiste en la alimentación se observa paciente sin cambios en su estado general

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

19/03/2026 11:30 Se administra tableta Ácido acetilsalicílico 100mg vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

19/03/2026 12:40 Se realiza traslado del paciente con ayuda de grúa hacia la silla poceta. Se lleva a cabo baño general, aplicando shampoo en cuero cabelludo y retirando con enjuague; posteriormente se aplica jabón líquido corporal, se enjuaga y se procede al secado completo de la piel. Finalizado el aseo, se traslada a la cama hospitalaria con apoyo de grúa. Se realiza secado cuidadoso de la región genital y glútea, aplicando crema con nistatina y crema Almipro. Se coloca pañal limpio y se viste con ropa limpia y adecuada. Durante el procedimiento, el paciente presentó episodios de nerviosismo.

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

19/03/2026 13:00 Se administra Acido valproico 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

19/03/2026 14:10 Paciente recibe y tolera dieta corriente almuerzo sin complicaciones se asiste en la alimentación se observa paciente sin cambios en su estado general

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

19/03/2026 14:20 Se realiza cambio de posición a decúbito lateral derecho colocando almohadas de soporte en región dorsal y entre miembros inferiores para favorecer alineación corporal y confort del paciente. Durante el procedimiento, paciente dormida con buen patrón respiratorio.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

19/03/2026 14:20 Se realiza cambio de posición a decúbito lateral derecho colocando almohadas de soporte en región dorsal y entre miembros inferiores para favorecer alineación corporal y confort del paciente. Durante el procedimiento, paciente dormida con buen patrón respiratorio.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

19/03/2026 14:50 Después del almuerzo se administra jarabe Escitalopram en solución oral, 20 cc, según indicación médica(psiquiatra) Tolera la administración por vía oral sin complicaciones, sin presencia de náuseas ni vómito, Paciente tranquila.

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

19/03/2026 15:45

Se realiza cambio de posición a la paciente se lubrica la piel con crema se realiza masaje y ejercicio de flexión y estiramiento sin complicaciones se observa a la paciente tranquila con buen patrón respiratorio sin cambios en su estado general

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

19/03/2026 17:00

Se realiza a la paciente comodidad y confort se realiza cambio de pañal y se realiza aseo genital aplicando cremas antidermatitis y antiulceras sin complicaciones se deja pañal limpio se observa paciente con buen patrón respiratorio sin cambios en su estado general

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

19/03/2026 18:25

se realiza ejercicios a la paciente de estimulación con la pelota la paciente colabora se observa estable con buen patrón respiratorio sin cambios en su estado general

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

19/03/2026 19:00

Entrego paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: Encefalopatia hipoxica,crisis epilépticas, cuadriplejia flácida y polineuropatia no especificada, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable dormida con buen patrón respiratorio presenta pequeños hematomas en miembros inferiores y superiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria, con barandas de seguridad elevadas posición decúbito supino.

Paciente estable desorientada en las 3 esferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO:
Paciente se mantiene hemodinámicamente estable y tranquila. Tolera adecuadamente la vía oral para la administración de medicamentos y la ingesta de alimentos, se realizo terapia de fonoaudiólogia, auxiliar realizo ejercicios en miembros superiores e inferiores y se utilizo pelotas con incentivo, fisioterapeuta Andrés realizo terapia física sin complicaciones.

OBSERVACIONES
• Dentro del domicilio Se observa hace tiempo material mecánicos, a fuera llenos de polvo y mugre.(a Jefe de ruta ordeno cerrar las ventan que va directo del paciente).
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.

HERNANDEZ DELGADO LIZETH

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)
• Pendiente terapias fisioterapeuta
• pendiente terapias ocupacional
•Pendiente terapias fonoaudiologo

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50pm, se administra una dosis adicional según orden médica.
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (++)
Deposición (+)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral (desayuno, almuerzo)
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal.
terapia con la pelota ejercicios en miembros superiores e inferiores.

Control de signos vitales
TA: 130/80 mmHg
FC: 78 x'
Fr: 18 x'
SPO2: 97%
T: 36.6 'C

Entrega Aux- Lizeth Hernández
Recibe Aux- Adriana Beltrán

19/03/2026 19:00

Ingreso al domicilio con elementos de protección personal realizó lavado de manos y recibo pqciente femenina de 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: Encefalopatia hipoxica,crisis epilépticas, cuadriplejia flácida y polineuropatia no especificada, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

PEÑALOZA FIGUEREDO ROSA MARY

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno Lizbeth Hernández quien informo estado de la paciente se encuentra estable dormida con buen patrón respiratorio presenta pequeños hematomas en miembros inferiores y superiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria, con barandas de seguridad elevadas posición decúbito supino.

Paciente estable desorientada en las 3 esferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión,
extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO:
Paciente se mantiene hemodinámicamente estable y tranquila. Tolera adecuadamente la vía oral para la administración de medicamentos y la ingesta de alimentos, Presento insomnio.

OBSERVACIONES
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)
• Pendiente terapias fisioterapeuta
• pendiente terapias ocupacional
•Pendiente terapias fonoaudiologo

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50pm, se administra una dosis adicional según orden médica.
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (++)
Deposición (-)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral (cena)
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal.
terapia con la pelota ejercicios en miembros superiores e inferiores.

Control de signos vitales
TA:125/80mmHg
FC: 70x'
Fr:18 x'
SPO2: 95%
T: 36.8 'C

Entrega Aux- Lizbeth Hernández 19/03/2026
07: 00 Entrego paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: Encefalopatia hipoxica,crisis epilépticas, cuadriplejia flácida y polineuropatia no especificada, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable dormida con buen patrón respiratorio presenta pequeños hematomas en miembros inferiores y superiores izquierdos y derechos por causa

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria, con barandas de seguridad elevadas posición decúbito supino.

Paciente estable desorientada en las 3 esferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

NOVEDADES PRESENTA
Paciente se mantiene hemodinámicamente estable y tranquila. Tolera adecuadamente la vía oral para la administración de medicamentos y la ingesta de alimentos, Presento insomnio.

OBSERVACIONES
• Dentro del domicilio Se observa hace tiempo material mecánicos, a fuera llenos de polvo y mugre.(a Jefe de ruta ordeno cerrar las ventan que va directo del paciente).
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)
• Pendiente terapias fisioterapeuta
• pendiente terapias ocupacional
•Pendiente terapias fonoaudiologo

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50pm, se administra una dosis adicional según orden médica.
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (++)
Deposición (-)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral (cena)
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

Higiene aseo personal.
terapia con la pelota ejercicios en miembros superiores e inferiores.

Control de signos vitales
TA:125/80mmHg
FC: 70x'
Fr:18 x'
SPO2: 95%
T: 36.8 'C

Entrega :Lizeth Hernández
recibe : RosaMary Peñaloza

19/03/2026 19:30 Previo lavado de manos asisto en alimentación dieta sólida y líquida, la cual la paciente tolera vía oral sin novedad alguna, seguido de esto realizó higiene bucal con crema y cepillo sin novedad

PEÑALOZA FIGUEREDO ROSA MARY

19/03/2026 20:00 previo lavado de manos según los correctos de enfermería Se administra tableta losartan 50mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

PEÑALOZA FIGUEREDO ROSA MARY

20/03/2026 01:30 pqciente continua dormida asisto en acompañamiento

PEÑALOZA FIGUEREDO ROSA MARY

20/03/2026 01:35 Realizó cambio de posición semi fowler, realizó estiramiento de sábanas lubricación de la piel con crema lubriderm acojinamiento de prominensias óseas

PEÑALOZA FIGUEREDO ROSA MARY

20/03/2026 02:40 paciente continua dormida

PEÑALOZA FIGUEREDO ROSA MARY

20/03/2026 03:30 Realizó cambio de posición, estiramiento de sábanas lubricación de la piel y Asísto en acompañamiento

PEÑALOZA FIGUEREDO ROSA MARY

20/03/2026 04:09 se observa paciente dormida asisto en acompañamiento

PEÑALOZA FIGUEREDO ROSA MARY

20/03/2026 05:00 previo lavado de manos según los correctos de enfermería Se administra Acido valproico 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

PEÑALOZA FIGUEREDO ROSA MARY

20/03/2026 05:05 se observa pqciente despierta, le informo y realizó cambio de pañal desechable aseo genital y aplicó crema antipañalitis, ajusto pañal limpio seguido estiramiento de sábanas, lubricación de la piel, acojinamiento de prominensias óseas

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

PEÑALOZA FIGUEREDO ROSA MARY

20/03/2026 06:10 Realizó aseo general de la unidad del paciente

PEÑALOZA FIGUEREDO ROSA MARY

20/03/2026 07:00

NOTA ACLARATORIA:
DESCARTO ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REALIZÓ LAVADO DE MANIS Y ENTREGO paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: Encefalopatia hipoxica,crisis epilépticas, cuadriplejia flácida y polineuropatia no especificada, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable dormida con buen patrón respiratorio presenta pequeños hematomas en miembros inferiores y superiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria, con barandas de seguridad elevadas posición decúbito supino.

Paciente estable desorientada en las 3 esferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO:
Paciente se mantiene hemodinámicamente estable y tranquila. Tolera adecuadamente la vía oral para la administración de medicamentos y la ingesta de alimentos, Presento insomnio.

OBSERVACION: Paciente paso buen turno tolerando oxígeno ambiente sin novedad alguna
se entrega turno a las 7:00 am recibe auxiliar Adriana Beltrán
PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)
• Pendiente terapias fisioterapeuta
• pendiente terapias ocupacional
•Pendiente terapias fonoaudiologo

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H

PEÑALOZA FIGUEREDO ROSA MARY

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50pm, se administra una dosis adicional según orden médica.
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (++)
Deposición (-)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral (cena)
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal.
terapia con la pelota ejercicios en miembros superiores e inferiores.

Control de signos vitales
TA:125/80mmHg
FC: 70x'
Fr:18 x'
SPO2: 95%
T: 36.8 'C
ENTREGA : ROSAMARY PEÑALOZA
RECIBE:ADRIANA BELTRÁN

20/03/2026 07:00

Descartó elementos de protección personal realizó lavado de manos y entrego paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: Encefalopatia hipoxica,crisis epilépticas, cuadriplejia flácida y polineuropatia no especificada, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

PEÑALOZA FIGUEREDO ROSA MARY

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable dormida con buen patrón respiratorio presenta pequeños hematomas en miembros inferiores y superiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria, con barandas de seguridad elevadas posición decúbito supino.

Paciente estable desorientada en las 3 esferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión,
extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO:
Paciente se mantiene hemodinámicamente estable y tranquila. Tolera adecuadamente la vía oral para la administración de medicamentos y la ingesta de alimentos, Presento insomnio.

OBSERVACION
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)
• Pendiente terapias fisioterapeuta
• pendiente terapias ocupacional
•Pendiente terapias fonoaudiologo

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50pm, se administra una dosis adicional según orden médica.
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (++)
Deposición (-)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral (cena)
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
higiene aseo personal.
terapia con la pelota ejercicios en miembros superiores e inferiores. .

Control de signos vitales
TA:122/60 mmhg
FC: 70x'
Fr:18 x'
SPO2: 97%
T: 36.6 'C

Entrega Aux- Adriana Beltrán
Recibe Aux- Lizeth Hernández

20/03/2026 07:00

ENTREGO paciente femenino, 57 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: secuelas de infarto cerebral,encefalopatía no especificada pielectas renal izquierda, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, crisis hepilepticas, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable dormida con buen patrón respiratorio presenta pequeños hematomas en miembros inferiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria, con barandas de seguridad elevadas en posición en posición decúbito supino.

Paciente estable desorientada en las 3 desferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado

Andrea valencia.

VALENCIA MEDINA TANIA ANDREA

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO:
Paciente tolero por via oral medicamentos concilio sueño temprano.

OBSERVACIONES
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50pm, se administra una dosis adicional según orden médica.
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (++)
Deposición (+)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral (Cena)
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal,(Se Realizo higiene bucal)

SIGNOS VITALES:
TA: 108/80 mmhg
Fc:83 x'
FR: 17×'
SPO2: 94 %
T: 36.7°C

20/03/2026 07:00

Recibo paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: Encefalopatia hipoxica,crisis epilépticas, cuadriplejia flácida y polineuropatia no especificada, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable dormida con buen patrón respiratorio presenta pequeños hematomas en miembros inferiores y superiores izquierdos y derechos por causa

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria, con barandas de seguridad elevadas posición decúbito supino.

Paciente estable desorientada en las 3 esferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO:
Paciente se mantiene hemodinámicamente estable y tranquila. Tolera adecuadamente la vía oral para la administración de medicamentos y la ingesta de alimentos, Concilio sueño temprano.

OBSERVACIONES
• Dentro del domicilio Se observa hace tiempo material mecánicos, a fuera llenos de polvo y mugre.(a Jefe de ruta ordeno cerrar las ventan que va directo del paciente).
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)
• Pendiente terapias fisioterapeuta
• pendiente terapias ocupacional
•Pendiente terapias fonoaudiologo

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50pm, se administra una dosis adicional según orden médica.
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (++)
Deposición (-)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral (cena)
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

Higiene aseo personal.
terapia con la pelota ejercicios en miembros superiores e inferiores.
Recibe Aux- Adriana Beltrán
Entrega Aux- Rosa Mary peñaloza

20/03/2026 07:40 Se realiza cambio de pañal empleando los elementos necesarios (pañal limpio, toallitas húmedas, crema antipañalitis, guantes de látex). Se asegura la cama hospitalaria contra la pared.
Se traslada paciente en grúa a la silla de ruedas.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

20/03/2026 08:00 Se administra tableta losartan 50mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

20/03/2026 08:10 Se administra tableta Esomeprazol 20mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

20/03/2026 08:20 Se administra capsula Amantadina 100mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

20/03/2026 08:30 Se administra tableta Citicolina 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

20/03/2026 08:31 Se realiza higiene bucal con cepillo electrico y crema colgate y agua.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

20/03/2026 08:40 Se asiste a la hora del desayuno, proporcionándole una dieta sólida, se le da tiempo suficiente para que mastique y trague cada bocado, antes de ofrecerle el siguiente, tolera por via oral sin complicacion, paciente colaborador, apetito conservado.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

20/03/2026 10:00 Se realiza traslado del paciente con ayuda de grúa hacia la silla poceta. Se lleva a cabo baño general, aplicando shampoo en cuero cabelludo y retirando con enjuague; posteriormente se aplica jabón líquido corporal, se enjuaga y se procede al secado completo de la piel. Finalizado el aseo, se traslada a la cama hospitalaria con apoyo de grúa. Se realiza secado cuidadoso de la región genital y glútea, aplicando crema con nistatina y crema Almipro. Se coloca pañal limpio y se viste con ropa limpia y adecuada. Durante el procedimiento, el paciente presentó episodios de nerviosismo.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

20/03/2026 10:37 Ingreso al domicilio familiar hijo de la paciente (Fernándo), se hace acompañamiento.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

20/03/2026 11:15 Se realizan masajes en región facial y cervical utilizando equipo de masaje facial eléctrico para favorecer la relajación muscular y la estimulación de la circulación. Posteriormente se aplica crema hidratante en miembros superiores e inferiores mediante masajes suaves para hidratación y bienestar de la piel. Se complementa la atención con la realización

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

	de ejercicios pasivos en extremidades superiores e inferiores con el fin de mantener la movilidad articular y prevenir rigidez. Paciente tolera el procedimiento sin complicaciones.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
20/03/2026 11:30	Se administra tableta Ácido acetilsalicílico 100mg vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
20/03/2026 11:30	Realizó cambio de posición decúbito lateral derecho, realizó lubricacion de la piel, acojinamiento de prominensias óseas y asisto en acompañamiento paciente concilia sueño	PEÑALOZA FIGUEREDO ROSA MARY
20/03/2026 13:00	Se administra Acido valproico 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
20/03/2026 13:40	Se asiste a la hora del almuerzo, proporcionándole una dieta sólida, se le da tiempo suficiente para que mastique y trague cada bocado, antes de ofrecerle el siguiente, tolera por via oral sin complicacion, paciente colaborador, apetito conservado.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
20/03/2026 13:41	paciente recibe alimentacion sin ninguna novedad	VALENCIA MEDINA TANIA ANDREA
20/03/2026 14:10	Después del almuerzo se administra jarabe Escitalopram en solución oral, 20 cc según indicación médica(psiquiatra) Tolera la administración por vía oral sin complicaciones, sin presencia de náuseas ni vómito, Paciente tranquila.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
20/03/2026 14:17	Se realiza higiene bucal con cepillo electrico y crema colgate y agua.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
20/03/2026 15:35	Se realiza cambio de posición a decúbito lateral izquierdo, colocando almohadas de soporte en región dorsal y entre miembros inferiores para favorecer alineación corporal y confort del paciente. Durante el procedimiento, paciente presenta episodio de nerviosismo.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
20/03/2026 16:11	Se realiza higiene y arreglo de uñas, efectuando corte y limpieza de las mismas. Posteriormente se procede a pintar las uñas, dejando a la paciente limpia y arreglada.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

20/03/2026 17:42 cambio pañal sin ninguna novedad por deposicion positiva

VALENCIA MEDINA TANIA ANDREA

20/03/2026 18:11 Se hace acompañamiento y supervisa el desarrollo de las terapia realizada por el Fisioterapeuta partículas (Andrés Rodríguez).Realiza terapias de estiramiento en cama y postura en posición sentado, se utilizo grúa, paciente permanece nerviosa signos de dificultad irritabilidad, inquietud, llanto, paciente tolera las terapias.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

20/03/2026 18:38 Se realiza aseo y organización de la unidad del paciente en domicilio, incluyendo limpieza de cama, colchón, barandas y superficie del entorno inmediato. Se realiza cambio de ropa de cama, dejando sábanas limpias, secas y bien ajustadas, garantizando condiciones adecuadas de higiene, orden y confort.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

20/03/2026 18:40 Ingreso al domicilio compañera de turno se hace inducción.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

20/03/2026 19:00 Recibo paciente femenino, 57 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: secuelas de infarto cerebral,encefalopatía no especificada pielectas renal izquierda, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, crisis hepilepticas, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable dormida con buen patrón respiratorio presenta pequeños hematomas en miembros inferiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria, con barandas de seguridad elevadas en posición en posición decúbito supino.

Paciente estable desorientada en las 3 desferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO:
Paciente tolero por via oral medicamentos concilio sueño temprano.

OBSERVACIONES
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.

VALENCIA MEDINA TANIA ANDREA

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50pm, se administra una dosis adicional según orden médica.
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (+++++)
Deposición (+)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral (Cena)
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal,(Se Realizo higiene bucal)

SIGNOS VITALES:
TA: 108/80 mmhg
Fc:83 x'
FR: 17×'
SPO2: 94 %
T: 36.7°C

20/03/2026 19:00

Entrego paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: Encefalopatia hipoxica,crisis epilépticas, cuadriplejia flácida y polineuropatia no especificada, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable tranquila presenta pequeños hematomas en miembros inferiores y superiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria, con barandas de seguridad elevadas posición decúbito supino.

Paciente estable desorientada en las 3 esferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO:
Paciente se mantiene hemodinámicamente estable y tranquila. Tolera adecuadamente la vía oral para la administración de medicamentos y la ingesta de alimentos, Concilio sueño temprano.

OBSERVACIONES
• Dentro del domicilio Se observa hace tiempo material mecánicos, a fuera llenos de polvo y mugre.(a Jefe de ruta ordeno cerrar las ventan que va directo del paciente).
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)
• Pendiente terapias fisioterapeuta
• pendiente terapias ocupacional
•Pendiente terapias fonoaudiologo

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50pm, se administra una dosis adicional según orden médica.
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (++)
Deposición (-)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral (Desayuno, almuerzo)
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal.
terapia con la pelota ejercicios en miembros superiores e inferiores.
Entrega Aux- Adriana Beltrán
Recibe Aux- Andrea Valencia.

20/03/2026 20:10 previo lavado de manos según los correctos de enfermería Se administra tableta Amlodipino 5mg vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

PEÑALOZA FIGUEREDO ROSA MARY

20/03/2026 20:20 previo lavado de manos según los correctos de enfermería se administra tableta Amlodipino 5mg vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

PEÑALOZA FIGUEREDO ROSA MARY

20/03/2026 20:30 según los correctos de enfermería Se administra tableta Citicolina 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

20/03/2026 20:50	previo lavado de manos según los correctos de enfermería Se administra dos cápsulas de Ácido valproico 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	PEÑALOZA FIGUEREDO ROSA MARY
20/03/2026 21:00	previo lavado de manos según los correctos de enfermería Se administra Quetiapina 200mg, mas dos tabletas Quetiapina 25mg un total administrados 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	PEÑALOZA FIGUEREDO ROSA MARY
20/03/2026 21:30	Realizó cambio de pañal desechable se observa diuresis positiva en pañal, realizó aseo genital, aplicó crema antipañalitis y ajusto pañal desechable limpio, seguido realizó cambio de vestuario se coloca pijama cómoda y se única paciente en posición decúbito lateral izquierdo tolerando posición	PEÑALOZA FIGUEREDO ROSA MARY
20/03/2026 22:30	se observa paciente dormida tranquila cómoda asisto en su acompañamiento	PEÑALOZA FIGUEREDO ROSA MARY
21/03/2026 07:00	Recibo paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO DX: Encefalopatia hipoxica,crisis epilépticas, cuadriplejia flácida y polineuropatia no especificada, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida. Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra nerviosa con episodios de llanto, ansiosa .presenta pequeños hematomas en miembros inferiores y superiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes. Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria, con barandas de seguridad elevadas posición decúbito supino. Paciente estable desorientada en las 3 esferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica, Ojos normoreactivos a la luz, Mucosa nasal húmeda sin laceraciones, Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis). NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO: Paciente se mantiene nerviosa, ansiosa con episodios de llanto, paciente Tolera adecuadamente la vía oral para la administración de medicamentos, auxiliar de turno informo que la noche concilio sueño temprano. OBSERVACIONES • Dentro del domicilio Se observa hace tiempo material mecánicos, a fuera llenos de polvo y mugre.(a Jefe de ruta ordeno cerrar las ventan que va directo del paciente). •Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco •observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.	PEÑALOZA FIGUEREDO ROSA MARY BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)
• Pendiente terapias fisioterapeuta
• pendiente terapias ocupacional
•Pendiente terapias fonoaudiologo

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50pm, se administra una dosis adicional según orden médica.
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (++)
Deposición (-)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral (cena)
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal.
terapia con la pelota ejercicios en miembros superiores e inferiores.
Recibe Aux- Adriana Beltrán
Entrega Aux- Andrea Valencia.

21/03/2026 07:10 Se realiza cambio de pañal empleando los elementos necesarios (pañal limpio, toallitas húmedas, crema antipañalitis, guantes de látex). Se asegura la cama hospitalaria contra la pared. Se retiran ropa y se realiza lubricación de la piel con crema corporal. Posteriormente, se coloca ropa limpia y seca, paciente estable con ropa limpia piel hidratada.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

21/03/2026 07:41 Paciente presenta episodios de llanto y nerviosismo. Se aplican medidas de confort, realizando masaje con aceite esencial en cuello y espalda. Por indicación de familiar, se administran gotas esenciales "Calma". Se coloca humidificador con gotas naturales con el fin de favorecer la relajación de la paciente.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

21/03/2026 07:42 Se realiza higiene bucal con cepillo electrico y crema colgate y agua, se realiza limpieza facial, se peina paciente.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

21/03/2026 08:00 Se administra tableta losartan 50mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

21/03/2026 08:10	Se administra tableta Esomeprazol 20mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
21/03/2026 08:20	Se administra capsula Amantadina 100mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
21/03/2026 08:30	Se administra tableta Citicolina 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
21/03/2026 08:33	Se asiste a la hora del desayuno, proporcionándole una dieta sólida, se le da tiempo suficiente para que mastique y trague cada bocado, antes de ofrecerle el siguiente, tolera por via oral sin complicacion, paciente colaborador, apetito conservado.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
21/03/2026 09:40	Se hace acompañamiento y supervisa el desarrollo de las terapia realizada por el Fisioterapeuta partículas (Andrés Rodríguez).Realiza terapias de estiramiento en cama y postura en posición sentado, se utilizo grúa, paciente permanece nerviosa signos de dificultad irritabilidad, inquietud, llanto, paciente tolera las terapias.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
21/03/2026 11:30	Se administra tableta Ácido acetilsalicílico 100mg vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
21/03/2026 12:00	Se realiza traslado del paciente con ayuda de grúa hacia la silla poceta. Se lleva a cabo baño general, aplicando shampoo en cuero cabelludo y retirando con enjuague; posteriormente se aplica jabón líquido corporal, se enjuaga y se procede al secado completo de la piel. Finalizado el aseo, se traslada a la cama hospitalaria con apoyo de grúa. Se realiza secado cuidadoso de la región genital y glútea, aplicando crema con nistatina y crema Almipro. Se coloca pañal limpio y se viste con ropa limpia y adecuada. Durante el procedimiento, el paciente presentó episodios de nerviosismo.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
21/03/2026 13:00	Se administra Acido valproico 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
21/03/2026 13:30	Se asiste a la hora del almuerzo, proporcionándole una dieta sólida, se le da tiempo suficiente para que mastique y trague cada bocado, antes de ofrecerle el siguiente, tolera por via oral sin complicacion, paciente colaborador, apetito conservado.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
21/03/2026 13:53	Después del almuerzo se administra jarabe Escitalopram en solución oral, 20 cc, según indicación médica(psiquiatra) Tolera la administración por vía oral sin complicaciones, sin presencia de náuseas ni vómito, Paciente tranquila.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

21/03/2026 13:55	Se realiza higiene bucal con cepillo electrico y crema colgate y agua.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
21/03/2026 14:36	Se realiza cambio de posición a decúbito lateral izquierdo, colocando almohadas de soporte en región dorsal y entre miembros inferiores para favorecer alineación corporal y confort del paciente. Durante el procedimiento, paciente presenta episodio de nerviosismo.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
21/03/2026 15:42	Se realizan masajes en región facial y cervical con equipo de masaje facial eléctrico para relajación muscular y estimulación de la circulación. Se aplica crema hidratante en miembros superiores e inferiores mediante masajes suaves. Además, se realizan ejercicios pasivos en extremidades para mantener la movilidad articular. Paciente tolera el procedimiento sin complicaciones	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
21/03/2026 16:30	se realiza estiramiento de sabanas para comodidad de paciente, se deja libre de arrugas, se coloca almohadas para mayor soporte y entrepiernas, realizo cambio de posición derecho , paciente estable dormida con buen patrón respiratorio	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
21/03/2026 18:09	Se aplica crema después del baño (Betametafona +Clotrimazol+ Neomocina) Parte de la espalda y hombros.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
21/03/2026 18:17	Se realiza cambio de pañal empleando los elementos necesarios (pañal limpio, toallitas húmedas, crema antipañalitis, guantes de látex). Se asegura la cama hospitalaria contra la pared.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
21/03/2026 19:00	Recibo paciente femenino, 57 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO DX: secuelas de infarto cerebral,encefalopatía no especificada pielectas renal izquierda, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, crisis hepilepticas, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida. Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable dormida con buen patrón respiratorio presenta pequeños hematomas en miembros inferiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes. Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria, con barandas de seguridad elevadas en posición en posición decúbito supino. Paciente estable desorientada en las 3 desferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica, Ojos normoreactivos a la luz, Mucosa nasal húmeda sin laceraciones, Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados,	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH Andrea valencia. VALENCIA MEDINA TANIA ANDREA

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO:
Paciente tolero por via oral medicamentos concilio sueño temprano.

OBSERVACIONES
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50pm, se administra una dosis adicional según orden médica.
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (++)
Deposición (+)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral (Cena)
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal,(Se Realizo higiene bucal)

SIGNOS VITALES:
TA: 108/82 mmhg
Fc:84 x'
FR: 17×'
SPO2: 94 %
T: 36.0°C

21/03/2026 19:00

Entrego paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: Encefalopatia hipoxica,crisis epilépticas, cuadriplejia flácida y polineuropatia no especificada, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable y tranquila presenta pequeños hematomas en miembros inferiores y superiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria, con barandas de seguridad elevadas posición decúbito supino.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

Paciente estable desorientada en las 3 esferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO:
Paciente se mantiene nerviosa, ansiosa con episodios de llanto, paciente Tolera adecuadamente la vía oral para la administración de medicamentos, Ingreso al domicilio Fisioterapeuta, y familiar (mamá de la paciente doña Alis)

OBSERVACIONES
• Dentro del domicilio Se observa hace tiempo material mecánicos, a fuera llenos de polvo y mugre.(a Jefe de ruta ordeno cerrar las ventan que va directo del paciente).
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)
• Pendiente terapias fisioterapeuta
• pendiente terapias ocupacional
•Pendiente terapias fonoaudiologo

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50pm, se administra una dosis adicional según orden médica.
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (++)
Deposición (++)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral (Desayuno, almuerzo)
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal.
terapia con la pelota ejercicios en miembros superiores e inferiores.
Entrega Aux- Adriana Beltrán
Recibe Aux- Andrea Valencia

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

22/03/2026 07:00

Recibo paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: Encefalopatia hipoxica,crisis epilépticas, cuadriplejia flácida y polineuropatia no especificada, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable dormida con buen patrón respiratorio presenta pequeños hematomas en miembros inferiores y superiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria, con barandas de seguridad elevadas posición semifowler.

Paciente estable desorientada en las 3 esferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO:
Paciente se mantiene nerviosa, ansiosa con episodios de llanto, paciente Tolera adecuadamente la vía oral para la administración de medicamentos, concilio sueño temprano.

OBSERVACIONES
• Dentro del domicilio Se observa hace tiempo material mecánicos, a fuera llenos de polvo y mugre.(a Jefe de ruta ordeno cerrar las ventan que va directo del paciente).
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)
• Pendiente terapias fisioterapeuta
• pendiente terapias ocupacional
•Pendiente terapias fonoaudiologo

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50pm, se administra una dosis adicional según orden médica.
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (++)
Deposición (--)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral (cena)
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal.
terapia con la pelota ejercicios en miembros superiores e inferiores.
Recibe Aux- Adriana Beltrán
Entrega Aux- Andrea Valencia

22/03/2026 07:00

ENTREGO paciente femenino, 57 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: secuelas de infarto cerebral,encefalopatía no especificada pielectas renal izquierda, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, crisis hepilepticas, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable dormida con buen patrón respiratorio presenta pequeños hematomas en miembros inferiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria, con barandas de seguridad elevadas en posición en posición decúbito supino.

Paciente estable desorientada en las 3 desferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO:
Paciente tolero por via oral medicamentos concilio sueño temprano.

OBSERVACIONES
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo

Andrea valencia.

VALENCIA MEDINA TANIA ANDREA

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50pm, se administra una dosis adicional según orden médica.
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (++)
Deposición (-)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral (Cena)
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal,(Se Realizo higiene bucal)

SIGNOS VITALES:
TA: 106/81 mmhg
Fc:82 x'
FR: 17×'
SPO2: 94 %
T: 36.2°C

22/03/2026 07:18 Se realiza cambio de pañal empleando los elementos necesarios (pañal limpio, toallitas húmedas, crema antipañalitis, guantes de látex). Se asegura la cama hospitalaria contra la pared. Se retiran bata y se realiza lubricación de la piel con crema corporal. Posteriormente, se coloca ropa limpia y seca, paciente estable con ropa limpia piel hidratada.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

22/03/2026 08:00 Se administra tableta losartan 50mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

22/03/2026 08:10 Se administra tableta Esomeprazol 20mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

22/03/2026 08:20 Se administra capsula Amantadina 100mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

22/03/2026 08:30 Se administra tableta Citicolina 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

22/03/2026 09:10 Se asiste a la hora del desayuno, proporcionándole una dieta sólida, se le da tiempo suficiente para que mastique y trague cada bocado, antes de ofrecerle el siguiente, tolera por via oral sin complicacion, paciente colaborador, apetito conservado.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

22/03/2026 09:35 Se observa paciente estable viendo televisión, los cuentos de los hermanos Grimm, hace acompañamiento.

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

22/03/2026 10:00	Ingreso al domicilio congresista ayudante de la iglesia, hace oración y le da el sagrado sacramento la ostia, Ingreso al domicilio familiar de la paciente madre alis, se hace acompañamiento.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
22/03/2026 11:30	Se administra tableta Ácido acetilsalicílico 100mg vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
22/03/2026 11:41	Se realiza traslado del paciente con ayuda de grúa hacia la silla poceta. Se lleva a cabo baño general, aplicando shampoo en cuero cabelludo y retirando con enjuague; posteriormente se aplica jabón líquido corporal, se enjuaga y se procede al secado completo de la piel. Finalizado el aseo, se traslada a la cama hospitalaria con apoyo de grúa. Se realiza secado cuidadoso de la región genital y glútea, aplicando crema con nistatina y crema Almipro. Se coloca pañal limpio y se viste con ropa limpia y adecuada. Durante el procedimiento, el paciente presentó episodios de nerviosismo.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
22/03/2026 14:00	se realiza higiene bucal con cepillo electrico y crema colgate y agua.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
22/03/2026 14:30	Se asiste a la hora del almuerzo, proporcionándole una dieta sólida, se le da tiempo suficiente para que mastique y trague cada bocado, antes de ofrecerle el siguiente, tolera por via oral sin complicacion, paciente colaborador, apetito conservado.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
22/03/2026 14:53	Se administra tableta Ácido acetilsalicílico 100mg vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
22/03/2026 14:54	Se hace corrección nota Después del almuerzo se administra jarabe Escitalopram en solución oral, 20 cc, según indicación médica(psiquiatra) Tolera la administración por vía oral sin complicaciones, sin presencia de náuseas ni vómito, Paciente tranquila.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
22/03/2026 15:33	Se realiza cambio de posición semifowler, paciente estable tranquila.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
22/03/2026 16:05	Ingreso al domicilio familiares de la paciente LUZ BELÉN, sobrina (julieth, e esposo y hijos).	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

22/03/2026 16:10

Se realiza cambio de posición a decúbito lateral izquierdo, colocando almohadas de soporte en región dorsal y entre miembros inferiores para favorecer alineación corporal y confort del paciente. Durante el procedimiento, paciente presenta episodio de nerviosismo.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

22/03/2026 16:53

Se aplica crema después del baño (Betametafona +Clotrimazol+ Neomocina) Parte de la espalda y hombros.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

22/03/2026 17:36

Se realiza aseo y organización de la unidad del paciente en domicilio, incluyendo limpieza de cama, colchón, barandas y superficie del entorno inmediato. Se realiza cambio de ropa de cama, dejando sábanas limpias, secas y bien ajustadas, garantizando condiciones adecuadas de higiene, orden y confort. Unidad del paciente queda limpia y organizada, sin novedades.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

22/03/2026 18:25

Ingreso al domicilio auxiliar turno se hace indicación sobre la paciente.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

22/03/2026 19:00

Entrego paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: Encefalopatia hipoxica,crisis epilépticas, cuadriplejia flácida y polineuropatia no especificada, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable tranquila, presenta pequeños hematomas en miembros inferiores y superiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria, con barandas de seguridad elevadas posición decúbito supino.

Paciente estable desorientada en las 3 esferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO:
Paciente estable tranquila, ingreso al domicilio familiares se hace acompañamiento, ingreso a las 18: 25 auxiliar de turno se hace inducción.

OBSERVACIONES
• Dentro del domicilio Se observa hace tiempo material mecánicos, a fuera llenos de polvo y mugre.(a Jefe de ruta ordeno cerrar las ventan que va directo del paciente).
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)
• Pendiente terapias fisioterapeuta
• pendiente terapias ocupacional
•Pendiente terapias fonoaudiologo

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50pm, se administra una dosis adicional según orden médica.
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (++)
Deposición (--)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral (Desayuno, almuerzo)
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal.
terapia con la pelota ejercicios en miembros superiores e inferiores.

Control de signos vitales
TA: 105/60mmHg
FC: 64x'
Fr:17 x'
SPO2: 97%
T: 36.1° C

Entrego Aux- Adriana Beltrán
Recibo Aux- Astrid Herrera

22/03/2026 19:00

Recibo paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: Encefalopatia hipoxica,crisis epilépticas, cuadriplejia flácida y polineuropatia no especificada, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

Astrid Carolina Herrera

HERRERA SILVA ASTRID CAROLINA

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable tranquila, presenta pequeños hematomas en miembros inferiores y superiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria, con barandas de seguridad elevadas posición decúbito supino.

Paciente estable desorientada en las 3 esferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

22/03/2026 20:00 Se administra tableta losartan 50mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

HERRERA SILVA ASTRID CAROLINA

22/03/2026 20:20 Se administra capsula Amantadina 100mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

HERRERA SILVA ASTRID CAROLINA

22/03/2026 20:30 Se administra tableta Citicolina 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

HERRERA SILVA ASTRID CAROLINA

22/03/2026 20:50 Se administra dos cápsulas de Ácido valproico 500mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

HERRERA SILVA ASTRID CAROLINA

22/03/2026 21:03 Se administra Quetiapina 200mg, mas dos tabletas Quetiapina 25mg un total administrados 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

HERRERA SILVA ASTRID CAROLINA

22/03/2026 23:30 Se realizó cambio de pañal: se retira pañal desechable, procedimiento de limpieza de la región perineal con solución adecuada y material estéril.
Se aplica crema protectora en la zona perineal para prevenir irritación o dermatitis por contacto con la orina.
Paciente quedó confortable, con la piel limpia e integral

HERRERA SILVA ASTRID CAROLINA

23/03/2026 00:09 Se realiza cambio de posición: Adecúbito lateral izquierdo, con el fin de favorecer el confort de la paciente y prevenir lesiones por presión. Paciente queda en posición adecuada, cómoda y con tolerancia al procedimiento.

HERRERA SILVA ASTRID CAROLINA

23/03/2026 03:30 Se realiza cambio de posición: Adecúbito lateral derecho, con el fin de favorecer el confort de la paciente y prevenir lesiones por presión. Paciente queda en posición adecuada, cómoda y con tolerancia al procedimiento.

HERRERA SILVA ASTRID CAROLINA

23/03/2026 04:50 Se realizó cambio de pañal: se retira pañal desechable, procedimiento de limpieza de la región perineal con solución adecuada y material estéril.
Se aplica crema protectora en la zona perineal para prevenir irritación o dermatitis por contacto con la orina.
Paciente quedó confortable, con la piel limpia e integral

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

HERRERA SILVA ASTRID CAROLINA

23/03/2026 05:05 Se administra Acido valproico 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

HERRERA SILVA ASTRID CAROLINA

23/03/2026 07:00 Entrego paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: Encefalopatia hipoxica,crisis epilépticas, cuadriplejia flácida y polineuropatia no especificada, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable tranquila, presenta pequeños hematomas en miembros inferiores y superiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria, con barandas de seguridad elevadas posición decúbito supino.

Paciente estable desorientada en las 3 esferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO:
Paciente estable tranquila, dormida en posicvión cúbito lateral derecho con acompañamiento de familiares hermana (Carme Ramirez) y cuñado (José).

OBSERVACIONES
• Dentro del domicilio Se observa hace tiempo material mecánicos, a fuera llenos de polvo y mugre.(a Jefe de ruta ordeno cerrar las ventan que va directo del paciente).
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)
• Pendiente terapias fisioterapeuta
• pendiente terapias ocupacional
•Pendiente terapias fonoaudiologo

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H

HERRERA SILVA ASTRID CAROLINA

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50pm, se administra una dosis adicional según orden médica.
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (++)
Deposición (--)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral (comida)
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal.
•Se interactúa con la paciente (hablar para estimular)

Entrego Aux- Astrid Herrera
Recibo Aux- Andrea Valencia

23/03/2026 07:00

Recibo paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: Encefalopatia hipoxica,crisis epilépticas, cuadriplejia flácida y polineuropatia no especificada, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

Andrea valencia.

VALENCIA MEDINA TANIA ANDREA

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual me informa estado de la paciente se encuentra estable dormida con buen patrón respiratorio presenta pequeños hematomas en miembros inferiores y superiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria, con barandas de seguridad elevadas posición decúbito supino.

Paciente estable desorientada en las 3 esferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO:
Paciente se mantiene hemodinámicamente estable y tranquila. Tolera adecuadamente la vía oral para la administración de medicamentos y la ingesta de alimentos, Presento insomnio.

OBSERVACIONES
• Dentro del domicilio Se observa hace tiempo material mecánicos, a fuera llenos de polvo y mugre.(a Jefe de ruta ordeno cerrar las ventan que va directo del paciente).
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)
• Pendiente terapias fisioterapeuta
• pendiente terapias ocupacional
•Pendiente terapias fonoaudiologo

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50pm, se administra una dosis adicional según orden médica.
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (++)
Deposición (-)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral (cena)
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal.
terapia con la pelota ejercicios en miembros superiores e inferiores.

Control de signos vitales
TA:125/80mmHg
FC: 70x'
Fr:18 x'
SPO2: 95%
T: 36.8 'C

Entrega Aux- Carolina
Recibe Aux- Andrea Valencia

23/03/2026 14:00 paciente recibe almuerzo sin novedad via oral

Andrea valencia.

VALENCIA MEDINA TANIA ANDREA

23/03/2026 14:01 realizó cambio de posición con un poco de dificultad por motivo que familiares no colaboran se acojinaron prominencias osea para evitar herridas por presión

Andrea valencia.

VALENCIA MEDINA TANIA ANDREA

23/03/2026 15:00 realizo cambio de pañal sin novedad alico crema

Andrea valencia.

VALENCIA MEDINA TANIA ANDREA

23/03/2026 15:17 por recomendación y actorizacion del familiar la paciente se le coloca unificador de aceite para relajar ala paciente cuando presenta episodios de ansiedad

Andrea valencia.

VALENCIA MEDINA TANIA ANDREA

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

23/03/2026 17:05 se realiza cambio de pañal por disposición limpio y aplicó crema antipañalitis sin ninguna novedad

Andrea valencia.

VALENCIA MEDINA TANIA ANDREA

23/03/2026 17:10 paciente recibe agua con un poco de dificultad pero sin signos de alarma

Andrea valencia.

VALENCIA MEDINA TANIA ANDREA

23/03/2026 18:10 le cambio pantalón ala paciente para que se sienta cómoda paciente estable

Andrea valencia.

VALENCIA MEDINA TANIA ANDREA

23/03/2026 19:00 Recibo paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: Encefalopatia hipoxica,crisis epilépticas, cuadriplejia flácida y polineuropatia no especificada, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable dormida presenta pequeños hematomas en miembros inferiores y superiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria, con barandas de seguridad elevadas posición semifowler.

Paciente estable desorientada en las 3 esferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO:
Paciente se mantiene nerviosa, ansiosa con episodios de llanto, paciente Tolera adecuadamente la vía oral para la administración de medicamentos, estable y tranquila.

OBSERVACIONES
• Dentro del domicilio Se observa hace tiempo material mecánicos, a fuera llenos de polvo y mugre.(a Jefe de ruta ordeno cerrar las ventan que va directo del paciente).
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.

Adriana

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

• Pendiente cita psicóloga (Mayo)
• Pendiente terapias fisioterapeuta
• pendiente terapias ocupacional
•Pendiente terapias fonoaudiologo

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50pm, se administra una dosis adicional según orden médica.
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (+)
Deposición (+)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral (Desayuno, almuerzo)
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal.
terapia con la pelota ejercicios en miembros superiores e inferiores.
Recibe Aux- Adriana Beltrán
Entrega Aux- Andrea Valencia

23/03/2026 19:00

Entrego paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: Encefalopatia hipoxica,crisis epilépticas, cuadriplejia flácida y polineuropatia no especificada, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

Andrea valencia.

VALENCIA MEDINA TANIA ANDREA

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable y tranquila presenta pequeños hematomas en miembros inferiores y superiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria, con barandas de seguridad elevadas posición decúbito supino.

Paciente estable desorientada en las 3 esferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO:
Paciente se mantiene nerviosa, ansiosa con episodios de llanto, paciente Tolera adecuadamente la vía oral para la administración de medicamentos, Ingreso al domicilio Fisioterapeuta, y familiar (mamá de la paciente doña Alis)

OBSERVACIONES
• Dentro del domicilio Se observa hace tiempo material mecánicos, a fuera llenos de polvo y mugre.(a Jefe de ruta

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

ordeno cerrar las ventan que va directo del paciente).
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)
• Pendiente terapias fisioterapeuta
• pendiente terapias ocupacional
•Pendiente terapias fonoaudiologo

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50pm, se administra una dosis adicional según orden médica.
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (++)
Deposición (++)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral (Desayuno, almuerzo)
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal.
terapia con la pelota ejercicios en miembros superiores e inferiores.

Control de signos vitales
TA: 117/84mmHg
FC: 65 x'
Fr:19 x'
SPO2: 95%
T: 36.5C

Recibe Aux- Andrea Valencia

23/03/2026 19:23 Se retiran ropa de vestir y se realiza lubricación de la piel con crema corporal. Posteriormente, se coloca bata limpia y seca, paciente estable con ropa limpia piel hidratada.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

23/03/2026 19:40 Se asiste a la hora de la cena , proporcionándole una dieta blanda , se le da tiempo suficiente para que mastique y trague cada bocado, antes de ofrecerle el siguiente, tolera por via oral sin complicacion, paciente colaborador, apetito conservado.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

23/03/2026 20:00 Se administra tableta losartan 50mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

23/03/2026 20:20	Se administra capsula Amantadina 100mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
23/03/2026 20:30	Se administra tableta Citicolina 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
23/03/2026 20:50	Se administra dos cápsulas de Ácido valproico 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
23/03/2026 21:00	Se administra Quetiapina 200mg, mas dos tabletas Quetiapina 25mg un total administrados 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
23/03/2026 22:21	Se realiza higiene bucal con cepillo electrico y crema colgate y agua. Se realiza cambio de pañal empleando los elementos necesarios (pañal limpio, toallitas húmedas, crema antipañalitis, guantes de látex).	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
23/03/2026 22:22	Se realiza cambio de posición a decúbito lateral izquierdo, colocando almohadas de soporte en región dorsal y entre miembros inferiores para favorecer alineación corporal y confort del paciente. Durante el procedimiento, paciente presenta estable y tranquila.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
24/03/2026 02:40	Se realiza cambio de posición a decúbito lateral izquierdo, colocando almohadas de soporte en región dorsal y entre miembros inferiores para favorecer alineación corporal y confort del paciente. Durante el procedimiento, paciente estable dormida.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
24/03/2026 04:50	Se realiza Durante el procedimiento, paciente presenta episodio de nerviosismo.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
24/03/2026 05:00	Se administra Acido valproico 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

24/03/2026 06:13

Se realiza higiene bucal con cepillo electrico y crema colgate y agua. Se realiza cambio de pañal empleando los elementos necesarios (pañal limpio, toallitas húmedas, crema antipañalitis, guantes de látex).

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

24/03/2026 07:00

Entrego paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: Encefalopatia hipoxica,crisis epilépticas, cuadriplejia flácida y polineuropatia no especificada, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable dormida con buen patrón respiratorio presenta pequeños hematomas en miembros inferiores y superiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria, con barandas de seguridad elevadas posición semifowler.

Paciente estable desorientada en las 3 esferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO:
Paciente se mantiene nerviosa, ansiosa con episodios de llanto, paciente Tolera adecuadamente la vía oral para la administración de medicamentos, estable y tranquila.

OBSERVACIONES
• Dentro del domicilio Se observa hace tiempo material mecánicos, a fuera llenos de polvo y mugre.(a Jefe de ruta ordeno cerrar las ventan que va directo del paciente).
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)
• Pendiente terapias fisioterapeuta
• pendiente terapias ocupacional
•Pendiente terapias fonoaudiologo

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50pm, se administra una dosis adicional según orden médica.
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (+)
Deposición (++)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral(cena)
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal.
terapia con la pelota ejercicios en miembros superiores e inferiores.
Entrega Aux- Adriana Beltrán
Recibe Aux- Astrid Herrera

24/03/2026 07:00

Recibo paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: Encefalopatia hipoxica,crisis epilépticas, cuadriplejia flácida y polineuropatia no especificada, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable tranquila, presenta pequeños hematomas en miembros inferiores y superiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria, con barandas de seguridad elevadas posición decúbito supino.

Paciente estable desorientada en las 3 esferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

HERRERA SILVA ASTRID CAROLINA

24/03/2026 08:00

Se administra tableta losartan 50mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

HERRERA SILVA ASTRID CAROLINA

24/03/2026 08:10

Se administra tableta Esomeprazol 20mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

HERRERA SILVA ASTRID CAROLINA

24/03/2026 08:20

Se administra capsula Amantadina 100mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

24/03/2026 08:30	Se hace acompañamiento y supervisa el desarrollo de las terapia realizada por el Fisioterapeuta partículas (Andrés Rodríguez).Realiza terapias de estiramiento en cama y postura en posición sentado, se utilizo grúa, paciente permanece nerviosa signos de dificultad irritabilidad, inquietud, llanto, paciente tolera las terapias.	HERRERA SILVA ASTRID CAROLINA
24/03/2026 08:30	Se administra tableta Citicolina 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	HERRERA SILVA ASTRID CAROLINA
24/03/2026 09:40	se suministró el desayuno a la paciente [luz Belén], quien se encuentra en cama. Se verificó que la paciente toleró adecuadamente los alimentos, sin signos de disfagia ni malestar.	HERRERA SILVA ASTRID CAROLINA
24/03/2026 10:30	Se realizó aseo completo en todas las áreas asignadas. Se verificó y limpió el área de los medicamentos, así como el espacio donde se almacenan las ropas, las sábanas y demás insumos. Se organizó todo, se corrió, se limpio el polvo, se limpió a fondo cada superficie. Se dejó todo en orden, listo para su uso.	HERRERA SILVA ASTRID CAROLINA
24/03/2026 11:30	Se administra dos cápsulas de ASA 100 mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	HERRERA SILVA ASTRID CAROLINA
24/03/2026 12:10	Se realiza movilización de la paciente con ayuda de grúa, trasladándola de la cama a la silla especial de ruedas, siguiendo medidas de seguridad y brindando apoyo durante el procedimiento. Posteriormente, se realiza cambio de colchón y tendido de cama, dejando la unidad de la paciente en orden, limpia y confortable. Paciente queda ubicada en silla de ruedas, en condiciones estables.	HERRERA SILVA ASTRID CAROLINA
24/03/2026 13:05	se suministró el almuerzo a la paciente dieta solida [luz Belén], quien se encuentra en cama. Se verificó que la paciente toleró adecuadamente los alimentos, sin signos de disfagia ni malestar.	HERRERA SILVA ASTRID CAROLINA
24/03/2026 13:30	Se realizó cambio de pañal: se retira pañal desechable, procedimiento de limpieza de la región perineal con solución adecuada y material estéril. Se aplica crema protectora en la zona perineal para prevenir irritación o dermatitis por contacto con la orina. Paciente quedó confortable, con la piel limpia e integral	HERRERA SILVA ASTRID CAROLINA
24/03/2026 14:10	Paciente queda en cama en posición semifowler, con barandas elevadas para prevención de caídas. Se observa en estado de reposo, dormida, tranquila y sin signos aparentes de incomodidad. Queda bajo cuidado de enfermería.	HERRERA SILVA ASTRID CAROLINA
24/03/2026 15:45	Paciente en estado de postración en cama, dependiente para actividades básicas de la vida diaria. Se realiza movilización con ayuda de grúa desde la cama hacia silla de baño, preservando medidas de seguridad durante el procedimiento. Posteriormente, se ingresa al baño, donde se brinda baño completo. Finalizado el baño, paciente permanece en silla mientras se realiza secado corporal completo. Luego, con apoyo de grúa, se efectúa nuevamente traslado seguro desde	HERRERA SILVA ASTRID CAROLINA

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

la silla hacia la cama. En cama se coloca pañal, se viste a la paciente y se deja en condiciones de comodidad y seguridad.

HERRERA SILVA ASTRID CAROLINA

24/03/2026 16:30

Se realiza cambio de posición: Adecúbito lateral derecho, con el fin de favorecer el confort de la paciente y prevenir lesiones por presión. Paciente queda en posición adecuada, cómoda y con tolerancia al procedimiento.

HERRERA SILVA ASTRID CAROLINA

24/03/2026 18:25

Se realizó cambio de pañal: se retira pañal desechable, procedimiento de limpieza de la región perineal con solución adecuada y material estéril.
Se aplica crema protectora en la zona perineal para prevenir irritación o dermatitis por contacto con la orina.
Paciente quedó confortable, con la piel limpia e integral

HERRERA SILVA ASTRID CAROLINA

24/03/2026 19:00

Entrego paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: Encefalopatia hipoxica,crisis epilépticas, cuadriplejia flácida y polineuropatia no especificada, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable dormida con buen patrón respiratorio presenta pequeños hematomas en miembros inferiores y superiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria, con barandas de seguridad elevadas posición semifowler.

Paciente estable desorientada en las 3 esferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO:
Paciente se mantiene nerviosa, ansiosa con episodios de llanto, paciente Tolera adecuadamente la vía oral para la administración de medicamentos, estable y tranquila.

OBSERVACIONES
• Dentro del domicilio Se observa hace tiempo material mecánicos, a fuera llenos de polvo y mugre.(a Jefe de ruta ordeno cerrar las ventan que va directo del paciente).
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)
• Pendiente terapias fisioterapeuta
• pendiente terapias ocupacional
•Pendiente terapias fonoaudiologo

HERRERA SILVA ASTRID CAROLINA

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50pm, se administra una dosis adicional según orden médica.
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (+++)
Deposición (-)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral(Desayuno, almuerzo)
•se realizó aseo completo a todas las áreas asignadas, limpieza de implementos y máquinas.
•se hace acompañamiento y supervisión el desarrollo de las terapias realizadas por el fisioterapeuta particulares (Andrés Rodríguez).
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•se realiza el baño completo durante el procedimiento se tiene medidas de seguridad.
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal.
terapia con la pelota ejercicios en miembros superiores e inferiores.

Entrega Aux- Astrid Herrera
Recibe Aux- Adriana Beltrán

24/03/2026 19:00

Recibo paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: Encefalopatia hipoxica,crisis epilépticas, cuadriplejia flácida y polineuropatia no especificada, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable tranquila, presenta pequeños hematomas en miembros inferiores y superiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria, con barandas de seguridad elevadas posición semifowler.

Paciente estable desorientada en las 3 esferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión,
extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO:
Paciente se mantiene nerviosa, ansiosa con episodios de llanto, paciente Tolera adecuadamente la vía oral para la administración de medicamentos, Ingreso al domicilio Fisioterapeuta partículas(Andres Rodriguez)
OBSERVACIONES
• Dentro del domicilio Se observa hace tiempo material mecánicos, a fuera llenos de polvo y mugre.(a Jefe de ruta

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

ordeno cerrar las ventan que va directo del paciente).
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)
• Pendiente terapias fisioterapeuta
• pendiente terapias ocupacional
•Pendiente terapias fonoaudiologo

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50pm, se administra una dosis adicional según orden médica.
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (+)
Deposición (--)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral(Desayuno, almuerzo)
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal.
terapia con la pelota ejercicios en miembros superiores e inferiores.
Recibe Aux- Adriana Beltrán
Entrega Aux- Astrid Herrera

24/03/2026 20:00 Se administra tableta losartan 50mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

24/03/2026 20:10 Se administra tableta Amlodipino 5mg vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

24/03/2026 20:20 Se administra capsula Amantadina 100mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

24/03/2026 20:28 Se asiste a la hora de la cena , proporcionándole una dieta sólida, se le da tiempo suficiente para que mastique y trague cada bocado, antes de ofrecerle el siguiente, tolera por via oral sin complicacion, paciente colaborador, apetito

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

conservado.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

24/03/2026 20:30 Se administra tableta Citicolina 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

24/03/2026 20:50 Se administra dos cápsulas de Ácido valproico 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

24/03/2026 21:00 Se administra Quetiapina 200mg, mas dos tabletas Quetiapina 25mg un total administrados 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

24/03/2026 22:29 Se realiza higiene bucal con cepillo electrico y crema colgate y agua.Se realiza cambio de pañal empleando los elementos necesarios (pañal limpio, toallitas húmedas, crema antipañalitis, guantes de látex). Se asegura la cama hospitalaria contra la pared.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

24/03/2026 22:33 Se realiza cambio de posición a decúbito lateral izquierdo, colocando almohadas de soporte en región dorsal y entre miembros inferiores para favorecer alineación corporal y confort del paciente. Durante el procedimiento, paciente presenta episodio de nerviosismo.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

24/03/2026 23:21 Se observa paciente dormida con buen patrón respiratorio.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

24/03/2026 23:25 Se realiza cambio de posición a decúbito lateral derecho, colocando almohadas de soporte en región dorsal y entre miembros inferiores para favorecer alineación corporal y confort del paciente. Durante el procedimiento, paciente presenta episodio de nerviosismo.Se realiza cambio de posición a decúbito lateral izquierdo, colocando almohadas de soporte en región dorsal y entre miembros inferiores para favorecer alineación corporal y confort del paciente. Durante el procedimiento, paciente presenta episodio de nerviosismo.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

25/03/2026 01:25 Se realiza cambio de posición a decúbito lateral derecho colocando almohadas de soporte en región dorsal y entre miembros inferiores para favorecer alineación corporal y confort del paciente. Durante el procedimiento, paciente estable dormida.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

25/03/2026 03:00 Se realiza cambio de posición a decúbito supino. Durante el procedimiento, paciente presenta episodio de nerviosismo.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

25/03/2026 04:53 Se realiza cambio de posición semifowler, estable dormida con buen patrón respiratorio.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

25/03/2026 05:00 Se administra Acido valproico 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

25/03/2026 06:10 Se realiza cambio de pañal empleando los elementos necesarios (pañal limpio, toallitas húmedas, crema antipañalitis, guantes de látex). Se asegura la cama hospitalaria contra la pared.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

25/03/2026 06:11 se realiza estiramiento de sábanas para comodidad de paciente, se deja libre de arrugas, se realiza cambio de posición decúbito supino, paciente estable dormida con buen patrón respiratorio.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

25/03/2026 06:22 Se realiza cambio de posición semifowler, se realiza higiene bucal con cepillo electrico y crema colgate y agua, se lubrica labios.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

25/03/2026 06:45 Se Presentacion paciente luz Belén Ramirez carrillo, se realiza indicación a la auxiliar de ruta

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

25/03/2026 07:00 Entrego paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: Encefalopatia hipoxica,crisis epilépticas, cuadriplejia flácida y polineuropatia no especificada, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable dormida con buen patrón respiratorio, presenta pequeños hematomas en miembros inferiores y superiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria, con barandas de seguridad elevadas posición semifowler

Paciente estable desorientada en las 3 esferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO:
Paciente se mantiene nerviosa, ansiosa con episodios de llanto, paciente Tolera adecuadamente la vía oral para la administración de medicamentos, concilio sueño temprano, se realizo los cambios de posiciones.

OBSERVACIONES
• Dentro del domicilio Se observa hace tiempo material mecánicos, a fuera llenos de polvo y mugre.(a Jefe de ruta ordeno cerrar las ventan que va directo del paciente).
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)
• Pendiente terapias fisioterapeuta
• pendiente terapias ocupacional
•Pendiente terapias fonoaudiologo

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50pm, se administra una dosis adicional según orden médica.
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (+)
Deposición (--)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral(cena)
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal.
terapia con la pelota ejercicios en miembros superiores e inferiores.
Entrega Aux- Adriana Beltrán
Recibe Aux- Paola lemus

25/03/2026 07:00

Entrego paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: Encefalopatia hipoxica,crisis epilépticas, cuadriplejia flácida y polineuropatia no especificada, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable dormida con buen patrón respiratorio, presenta pequeños hematomas en miembros inferiores y superiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria, con barandas de seguridad elevadas posición semifowler

Irlene Paola lemus M.

LEMUS MADARIAGA IRLENE PAOLA

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

Paciente estable desorientada en las 3 esferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO:
Paciente se mantiene nerviosa, ansiosa con episodios de llanto, paciente Tolera adecuadamente la vía oral para la administración de medicamentos, concilio sueño temprano, se realizo los cambios de posiciones.

OBSERVACIONES
• Dentro del domicilio Se observa hace tiempo material mecánicos, a fuera llenos de polvo y mugre.(a Jefe de ruta ordeno cerrar las ventan que va directo del paciente).
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)
• Pendiente terapias fisioterapeuta
• pendiente terapias ocupacional
•Pendiente terapias fonoaudiologo

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50pm, se administra una dosis adicional según orden médica.
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (+)
Deposición (-)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral(cena)
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal.
terapia con la pelota ejercicios en miembros superiores e inferiores.

Control de signos vitales
TA:114/65mmHg

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

FC: 66x'
Fr: 18x'
SPO2: 97%
T: 36.0° C

Entrega Aux- Adriana Beltrán
Recibe Aux- Paola lemus

25/03/2026 07:28 se observa paciente en cama hospitalaria, dormida, Se realiza cambio postural con el fin de favorecer el cuidado de la piel y mantener la integridad cutánea. Se colocan almohadas de soporte en cabeza, espalda y entrepierna para prevenir zonas de presión, cama hospitalaria queda con barandas de seguridad elevadas.

Irlene Paola lemus M.

LEMUS MADARIAGA IRLENE PAOLA

25/03/2026 07:35 Se llama a paciente por su nombre, responde con balbuceo. Se explica procedimiento a realizar. Se realiza cambio de posición de decúbito supino a posición Fowler en cama hospitalaria. Se efectúan estiramientos de miembros superiores de manera asistida,tolerando procedimeinto sin complicación.

Irlene Paola lemus M.

LEMUS MADARIAGA IRLENE PAOLA

25/03/2026 08:00 Previo lavado de manos con técnica aséptica y cumplimiento de protocolos de bioseguridad, verificando los 15 correctos para la administración de medicamentos, se administra losartán 50 mg (1 tableta) por vía oral con 50 cc de agua, según prescripción médica.
Paciente tolera la administración sin presentar reacciones adversas.

Irlene Paola lemus M.

LEMUS MADARIAGA IRLENE PAOLA

25/03/2026 08:10 Previo lavado de manos con técnica aséptica y cumplimiento de protocolos de bioseguridad, verificando los 15 correctos para la administración de medicamentos, se administra esomeprazol 20 mg (1tab) por vía oral con 50 cc de agua, según prescripción médica.
Paciente tolera la administración sin presentar reacciones adversas.

Irlene Paola lemus M.

LEMUS MADARIAGA IRLENE PAOLA

25/03/2026 08:20 Previo lavado de manos con técnica aséptica y cumplimiento de protocolos de bioseguridad, verificando los 15 correctos para la administración de medicamentos, se administra amantadina de 100 mg (1cap) por vía oral con 50 cc de agua, según prescripción médica.
Paciente tolera la administración sin presentar reacciones adversas

Irlene Paola lemus M.

LEMUS MADARIAGA IRLENE PAOLA

25/03/2026 08:30 Previo lavado de manos con técnica aséptica y cumplimiento de protocolos de bioseguridad, verificando los 15 correctos para la administración de medicamentos, se administra citicolina de 250 mg (1 tableta) por vía oral con 50 cc de agua, según prescripción médica.
Paciente tolera la administración sin presentar reacciones adversas.

Irlene Paola lemus M.

LEMUS MADARIAGA IRLENE PAOLA

25/03/2026 08:42 Se brinda apoyo espiritual a la paciente. Se realiza lectura del día, ante la cual la paciente demuestra agrado.

Irlene Paola lemus M.

LEMUS MADARIAGA IRLENE PAOLA

25/03/2026 09:00 previo lavado de manos siguiendo protocolos de bioseguridad , se brinda asistencia durante la alimentación. Paciente ingiere alimentos sólidos(arepa con tortilla de huevo, yogur griego) , los cuales se fraccionan en porciones pequeñas para favorecer la deglución. Tolera la ingesta con poca dificultad deglute poco ,se administran líquidos con pitillo.

Irlene Paola lemus M.

LEMUS MADARIAGA IRLENE PAOLA

25/03/2026 09:43 Paciente identificado por su nombre, responde al llamado. Se explica la importancia de realizar cambios posturales y del adecuado soporte en zonas de presión. Se realiza cambio de posición de Fowler a decúbito lateral izquierdo, colocando soporte adecuado en cabeza, región intertrocantérea (entrepierna) y espalda. Se proporciona comodidad y confort. Paciente queda en cama hospitalaria con barandas de seguridad elevadas.

Irlene Paola lemus M.

LEMUS MADARIAGA IRLENE PAOLA

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

25/03/2026 10:30	Paciente es movilizada mediante grúa eléctrica, con técnica adecuada y sin incidentes, desde la cama hacia silla tipo pato, con apoyo y acompañamiento de la hermana Carmen Ramírez. Posteriormente se traslada al baño, donde se realiza higiene personal, manteniendo privacidad y confort. Se realiza baño cefalocaudal: se aplica agua en todo el cuerpo, seguido de shampoo en cuero cabelludo con masajes circulares para favorecer la circulación. Posteriormente se aplica jabón líquido en cuello, orejas y miembros superiores; de igual manera en espalda y miembros inferiores con ayuda de paño. Se realiza aseo de genitales con jabón íntimo, enjuagando con abundante agua. Se procede a secado del cuerpo y traslado nuevamente a la unidad en cama hospitalaria, mediante grúa eléctrica, manteniendo privacidad y confort. Se observa piel íntegra, sin signos de irritación ni lesiones. Paciente tolera el procedimiento sin complicaciones.	Irlene Paola lemus M. LEMUS MADARIAGA IRLENE PAOLA
25/03/2026 10:45	Previo lavado de manos y cumplimiento de normas de bioseguridad, se realiza limpieza y desinfección de la unidad del paciente. Se procede a retiro de residuos y organización del entorno. Se efectúa limpieza de cama hospitalaria, barandas, mesa auxiliar y superficies de contacto frecuente, utilizando solución desinfectante según protocolo institucional. Se realiza cambio de ropa de cama, dejándola limpia, seca y sin arrugas. Se mantiene adecuada ventilación e iluminación del área. Se verifica correcta disposición de elementos y equipos. Unidad queda limpia, ordenada y en condiciones adecuadas para la atención del paciente	Irlene Paola lemus M. LEMUS MADARIAGA IRLENE PAOLA
25/03/2026 10:58	se observa pacienre en cama hospitalaria dormida , se realiza adecuada hidratación de piel y zonas de presión. se cambia a posicion fowler en cama hospitalaria se coloca con puntos de presión con adecuado soporte barandas de seguridad elevadas.	Irlene Paola lemus M. LEMUS MADARIAGA IRLENE PAOLA
25/03/2026 11:30	Previo lavado de manos con técnica aséptica y cumplimiento de protocolos de bioseguridad, verificando los 15 correctos para la administración de medicamentos, se administra ácido acetil salicilico de 100mg (1 tableta) por vía oral con 50 cc de agua, según prescripción médica. Paciente tolera la administración sin presentar reacciones adversas.	Irlene Paola lemus M. LEMUS MADARIAGA IRLENE PAOLA
25/03/2026 12:15	Se realiza intervención de estimulación sensorial enfocada en motricidad fina. Durante la actividad, el paciente realiza agarre de objetos, identificando y verbalizando el color correspondiente de cada uno. Se brinda acompañamiento y orientación durante el ejercicio. Paciente participa activamente, con adecuada tolerancia a la actividad, presentando poca dificultad durante el desarrollo de la misma.	Irlene Paola lemus M. LEMUS MADARIAGA IRLENE PAOLA
25/03/2026 13:32	previo lavado de manos siguiendo protocolos de bioseguridad , se brinda asistencia durante la alimentación. Paciente ingiere alimentos sólidos(almuerzo pollo guisado , arroz agua Cate y jugo de fruta) , los cuales se fraccionan en porciones pequeñas para favorecer la deglución. Tolera la ingesta de alimentos con poca dificultad deglute poco , alimentación pausas paciente en varias ocasiones tiene atragantamiento se administran líquidos con pitillo tolerando.	Irlene Paola lemus M. LEMUS MADARIAGA IRLENE PAOLA
25/03/2026 13:35	Previo lavado de manos con técnica aséptica y cumplimiento de protocolos de bioseguridad, verificando los 15 correctos para la administración de medicamentos, se administra ACIDO VALPROICO de 250 mg (1 CAP) por vía oral con 50 cc de agua, según prescripción médica. Paciente tolera la administración sin presentar reacciones adversas.	Irlene Paola lemus M. LEMUS MADARIAGA IRLENE PAOLA
25/03/2026 14:10	Previo lavado de manos con técnica aséptica y cumplimiento de protocolos de bioseguridad, verificando los 15 correctos para la administración de medicamentos, se administra jarabe escitalopram de 120 ml (20 cc) por vía oral , según prescripción médica. Paciente tolera la administración sin presentar reacciones adversas	Irlene Paola lemus M. LEMUS MADARIAGA IRLENE PAOLA
25/03/2026 14:30	Previo lavado de manos con técnica aséptica y cumplimiento de protocolos de bioseguridad, verificando los 15 correctos para la administración de medicamentos, se administra jarabe escitalopram de 120 ML (20 cc) por vía oral , según prescripción médica.pos administración se dan a inferir 30 cc de agua . Paciente tolera la administración sin presentar reacciones adversas.	Irlene Paola lemus M. LEMUS MADARIAGA IRLENE PAOLA
25/03/2026 15:00	previo lavado de manos se realiza adecuada hidratación de piel para mantener la integridad de la piel se cambia paciente a posición decubito lateral derecho con previo acojinamiento de prominecias oseas , cama hospitalaria con barandas de seguridad elevadas.	Irlene Paola lemus M.

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

25/03/2026 15:12	paciente recibe visita de madre alix carrillo ,recibe apoyo emosional paciente interactúa de manera positiva , realizan el santo rosario , paciente participa con agrado .	LEMUS MADARIAGA IRLENE PAOLA
25/03/2026 16:05	se observa paciente dormida en cama hospitalaria con barandas de seguridad elevadas , posición decubito lateral , con previo soporte en zonas de presión manejando buen patrón respiratorio .	LEMUS MADARIAGA IRLENE PAOLA
25/03/2026 16:40	Se realiza higiene de genitales posterior a eliminación. Se efectúa aseo con agua y jabón íntimo, seguido de enjuague con agua. Se observa piel íntegra, hidratada, sin signos de irritación. Se procede a secado de la zona con toalla suave. Se aplica crema Almipro en región inguinal y glútea. Se coloca pañal limpio, seco y en adecuadas condiciones para su uso.	LEMUS MADARIAGA IRLENE PAOLA
25/03/2026 17:05	Se explica al paciente el procedimiento a realizar, verificando comprensión. Se posiciona en decúbito lateral y se coloca arnés de grúa, asegurando adecuada sujeción de miembros superiores e inferiores. Se verifica correcta posición del paciente. Se desciende brazo de grúa, se asegura al paciente y se realiza elevación suave, sin incidentes. Se moviliza a silla de ruedas neurológica. Se traslada a sala en compañía de familiar, hermana Carmen Ramírez.	LEMUS MADARIAGA IRLENE PAOLA
25/03/2026 17:15	Paciente en silla de ruedas neurológica, consciente y hemodinámicamente estable. Se posiciona en semifowler, manteniendo adecuada alineación corporal y confort. Ingresa a unidad domiciliaria fonoaudiólogo particular Jonathan Ibáñez, quien realiza intervención terapéutica consistente en electroestimulación a nivel cervical y ejercicios miofuncionales enfocados en músculo orbicular de los labios, orientados a mejorar función orofacial. Durante el procedimiento, paciente tolera adecuadamente la terapia, Finaliza sesión sin complicaciones. Paciente permanece en silla de ruedas neurológica, en posición confortable y con acompañamiento familiar.	LEMUS MADARIAGA IRLENE PAOLA
25/03/2026 18:00	Paciente en silla neurológica, consciente, orientada, se observa quejumbrosa y ansiosa, manifestando verbalmente no sentirse bien en dicha posición. Se brinda información previa sobre el procedimiento a realizar, favoreciendo la tranquilidad y cooperación de la paciente. Previo lavado de manos y aplicando medidas de bioseguridad, se procede a la colocación de arnés con técnica adecuada, verificando correcta posición y sujeción. Posteriormente, se desciende brazo de grúa eléctrica, se asegura paciente y se realiza movilización controlada desde silla neurológica hacia cama hospitalaria, con vigilancia continua durante todo el procedimiento. Movilización realizada sin eventos adversos, paciente tolera adecuadamente. Se posiciona en cama hospitalaria en decúbito supino, con adecuada alineación corporal y barandas de seguridad elevadas. Se deja paciente en condiciones de confort y seguridad.	LEMUS MADARIAGA IRLENE PAOLA
25/03/2026 18:25	Se realiza valoración de la piel, evidenciándose íntegra, sin signos de irritación ni lesiones. Se verifica pañal seco, en condiciones aptas para su uso. Se aplica crema hidratante mediante masajes suaves, según tolerancia del paciente, favoreciendo la circulación. Se brinda educación sobre la importancia de mantener la piel hidratada, evitando exceso de humedad, con el fin de prevenir la aparición de lesiones por presión en paciente en cama.	LEMUS MADARIAGA IRLENE PAOLA
25/03/2026 19:00	Recibo paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO DX: Encefalopatia hipoxica,crisis epilépticas, cuadriplejia flácida y polineuropatia no especificada, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida. Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable despierta con buen patrón respiratorio, presenta pequeños hematomas en miembros inferiores y superiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes. Paciente se encuentra estable, en cama hospitlaria posición decubito supino colchón antiescaras ,paciente en el programa de atención domiciliaria Paciente estable desorientada en las 3 esferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado,	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara con olor fuerte , extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO:
Paciente se mantiene ansiosa manifiesta que se siente triste , paciente Tolera adecuadamente la vía oral para la administración de medicamentos, durante el turno mantuvo despierta alerta , se realizo los cambios de posiciones tolerando sin complicación.
se relaiza terapia de fonoaudiología particular sin complicación.
OBSERVACIONES
• Dentro del domicilio Se observa hace tiempo material mecánicos, a fuera llenos de polvo y mugre.(a Jefe de ruta ordeno cerrar las ventan que va directo del paciente).
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)
• Pendiente terapias fisioterapeuta
• pendiente terapias ocupacional
•Pendiente terapias fonoaudiologo

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:30 pm un a dosis adicional por orden médica
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (+)
Deposición (-)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral(desayuno y almuerzo)
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal.
terapia con la pelota ejercicios en miembros superiores e inferiores.
Recibe Aux- Adriana Beltrán
Entrega Aux- Paola lemus

25/03/2026 19:04 Entrego paciente femenina, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: Encefalopatia hipoxica,crisis epilépticas, cuadriplejia flácida y polineuropatia no especificada, hipertensión esencial,

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

incontinencia urinaria, no especificada, constipación, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

Irlene Paola lemus M.

LEMUS MADARIAGA IRLENE PAOLA

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno (Adriana Beltrán)la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable despierta con buen patrón respiratorio, presenta pequeños hematomas en miembros inferiores y superiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en cama hospitlaria posición decubito supino colchón antiescaras ,paciente en el programa de atención domiciliaria

Paciente estable desorientada en las 3 esferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara con olor fuerte , extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO:
Paciente se mantiene ansiosa manifiesta que se siente triste , paciente Tolera adecuadamente la vía oral para la administración de medicamentos, durante el turno mantuvo despierta alerta , se realizo los cambios de posiciones tolerando sin complicación.
, se relaiza terapia de fonoaudiología particular sin complicación.
OBSERVACIONES
• Dentro del domicilio Se observa hace tiempo material mecánicos, a fuera llenos de polvo y mugre.(a Jefe de ruta ordeno cerrar las ventan que va directo del paciente).
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)
• Pendiente terapias fisioterapeuta
• pendiente terapias ocupacional
•Pendiente terapias fonoaudiologo

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:30 pm un a dosis adicional por orden médica
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

Elimino (+)
Deposición (-)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral(desayuno y almuerzo)
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal.
terapia con la pelota ejercicios en miembros superiores e inferiores.

Control de signos vitales
TA:135/60 mm/ Hg
FC: 74x'
Fr: 18x'
SPO2: 95%
T: 36.4 °C
Recibe
Aux- Adriana Beltrán
Entrega Aux- Paola lemus

25/03/2026 19:28 Se asiste a la hora de la cena , proporcionándole una dieta sólida, se le da tiempo suficiente para que mastique y trague cada bocado, antes de ofrecerle el siguiente, tolera por via oral sin complicacion, paciente colaborador, apetito conservado.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

25/03/2026 20:00 Se administra tableta losartan 50mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

25/03/2026 20:10 Se administra tableta Amlodipino 5mg vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

25/03/2026 20:20 Se administra capsula Amantadina 100mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

25/03/2026 20:30 Se administra tableta Citicolina 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

25/03/2026 20:50 Se administra dos cápsulas de Ácido valproico 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

25/03/2026 21:00 Se administra Quetiapina 200mg, mas dos tabletas Quetiapina 25mg un total administrados 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

25/03/2026 21:24 Se realiza higiene bucal con cepillo electrico y crema colgate y agua.

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

25/03/2026 22:00	Se retiran ropa de vestir y se realiza lubricación de la piel con crema corporal. Posteriormente, se coloca bata limpia y seca, paciente estable con bata limpia piel hidratada, permanece en cama hospitalaria bajo vigilancia y acompañamiento. Se realiza cambio de pañal empleando los elementos necesarios (pañal limpio, toallitas húmedas, crema antipañalitis, guantes de látex). Se asegura la cama hospitalaria contra la pared.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
25/03/2026 22:40	Se realiza cambio de posición a decúbito lateral izquierdo, colocando almohadas de soporte en región dorsal y entre miembros inferiores para favorecer alineación corporal y confort del paciente. Durante el procedimiento, paciente presenta episodio de nerviosismo.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
25/03/2026 23:07	Se hace vigilancia a la paciente Se observa paciente dormida con buen patrón respiratorio.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
26/03/2026 02:09	Se observa paciente dormida con buen patrón respiratorio.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
26/03/2026 04:07	Se realiza cambio de posición a decúbito lateral derecho, colocando almohadas de soporte en región dorsal y entre miembros inferiores para favorecer alineación corporal y confort del paciente. Durante el procedimiento, paciente presenta episodio de nerviosismo.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
26/03/2026 05:00	Se administra Acido valproico 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
26/03/2026 06:01	Se realiza cambio de pañal empleando los elementos necesarios (pañal limpio, toallitas húmedas, crema antipañalitis, guantes de látex). Se asegura la cama hospitalaria contra la pared. Se realiza cambio de sábanas y pongo sábanas limpias.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
26/03/2026 06:01	Se retiran bata y se realiza lubricación de la piel con crema corporal. Posteriormente, se coloca pijama limpia y seca, paciente estable con ropa limpia piel hidratada.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
26/03/2026 06:38	Se realiza aseo y organización de la unidad del paciente en domicilio, incluyendo limpieza de cama, colchón, barandas y superficie del entorno inmediato.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

26/03/2026 06:38

Se realiza cambio de posición a decúbito lateral izquierdo, colocando almohadas de soporte en región dorsal y entre miembros inferiores para favorecer alineación corporal y confort del paciente. Durante el procedimiento, paciente dormida con buen patrón respiratorio.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

26/03/2026 07:00

Entrego paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: Encefalopatia hipoxica,crisis epilépticas, cuadriplejia flácida y polineuropatia no especificada, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable dormida con buen patrón respiratorio, presenta pequeños hematomas en miembros inferiores y superiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en cama hospitlaria posición decubito supino colchón antiescaras ,paciente en el programa de atención domiciliaria

Paciente estable desorientada en las 3 esferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara con olor fuerte , extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO:
Paciente se mantiene ansiosa manifiesta que se siente triste , paciente Tolera adecuadamente la vía oral para la administración de medicamentos, durante el turno mantuvo despierta alerta en horas de las 00:00 concilio sueño, se realizo los cambios de posiciones tolerando sin complicación.

OBSERVACIONES
• Dentro del domicilio Se observa hace tiempo material mecánicos, a fuera llenos de polvo y mugre.(a Jefe de ruta ordeno cerrar las ventan que va directo del paciente).
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)
• Pendiente terapias fisioterapeuta
• pendiente terapias ocupacional
•Pendiente terapias fonoaudiologo

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50 pm un a dosis adicional por orden médica
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (+)
Deposición (-)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral(cena)
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal.
terapia con la pelota ejercicios en miembros superiores e inferiores.
Entrego Aux- Adriana Beltrán
Recibe Aux- Astrid Herrera

26/03/2026 07:00

Recibo paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: Encefalopatia hipoxica,crisis epilépticas, cuadriplejia flácida y polineuropatia no especificada, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable dormida con buen patrón respiratorio presenta pequeños hematomas en miembros inferiores y superiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria, con barandas de seguridad elevadas posición semifowler.

Paciente estable desorientada en las 3 esferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO:
Paciente se mantiene nerviosa, ansiosa con episodios de llanto, paciente Tolera adecuadamente la vía oral para la administración de medicamentos, estable y tranquila.

OBSERVACIONES
• Dentro del domicilio Se observa hace tiempo material mecánicos, a fuera llenos de polvo y mugre.(a Jefe de ruta ordeno cerrar las ventan que va directo del paciente).
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)

Astrid Carolina Herrera

HERRERA SILVA ASTRID CAROLINA

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

• Pendiente terapias fisioterapeuta
• pendiente terapias ocupacional
•Pendiente terapias fonoaudiologo

ALERGICOS: DIPIRON

Entrega Aux- Adriana Beltrán
Recibe Aux- Astrid Herrera

26/03/2026 08:00 Se administra tableta losartan 50mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

HERRERA SILVA ASTRID CAROLINA

26/03/2026 08:10 Se administra tableta Esomeprazol 20mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

HERRERA SILVA ASTRID CAROLINA

26/03/2026 08:20 Se administra capsula Amantadina 100mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

HERRERA SILVA ASTRID CAROLINA

26/03/2026 08:30 Se hace acompañamiento y supervisa el desarrollo de las terapia realizada por el Fisioterapeuta partículas (Andrés Rodríguez).Realiza terapias de estiramiento en cama y postura en posición sentado, se utilizo grúa, paciente permanece nerviosa signos de dificultad irritabilidad, inquietud, llanto, paciente tolera las terapias.

HERRERA SILVA ASTRID CAROLINA

26/03/2026 08:30 Se administra tableta Citicolina 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

HERRERA SILVA ASTRID CAROLINA

26/03/2026 09:40 Paciente en estado de postración en cama, dependiente para actividades básicas de la vida diaria. Se realiza movilización con ayuda de grúa desde lav cama hacia silla de baño, preservando medidas de seguridad durante el procedimiento. Posteriormente, se ingresa al baño, donde se brinda baño completo. Finalizado el baño, paciente permanece en silla mientras se realiza secado corporal completo. Luego, con apoyo de grúa, se efectúa nuevamente traslado seguro desde la silla hacia la cama. En cama se coloca pañal, se viste a la paciente y se deja en condiciones de comodidad y seguridad.

HERRERA SILVA ASTRID CAROLINA

26/03/2026 10:30 Se realizó el aseo rutinario en la habitación de la paciente. Se limpió el polvo de los muebles, se trapeó el suelo en el área del baño y se revisaron las superficies para mantener el orden. El aseo se hizo con los insumos habituales, garantizando limpieza y orden."

HERRERA SILVA ASTRID CAROLINA

26/03/2026 11:10 Se evidencia que la grúa de movilización presenta fallas en su funcionamiento, específicamente en el control manual, donde el botón de descenso no responde adecuadamente, por lo cual requiere mantenimiento. Asimismo, se observa que el chaleco (arnés) utilizado para la movilización del paciente se encuentra deteriorado, presentando desgaste en sus sujeciones.
El día de hoy se realizó el baño del paciente utilizando la grúa; sin embargo, se decide suspender su uso a partir de este momento debido a las condiciones mencionadas, con el fin de garantizar la seguridad del paciente.
Se informa oportunamente al familiar sobre la situación, quien manifiesta que gestionará la reparación de los equipos.

HERRERA SILVA ASTRID CAROLINA

26/03/2026 11:21 se suministró el desayuno a la paciente dieta sólida [luz Belén], quien se encuentra en cama. Se verificó que la paciente toleró adecuadamente los alimentos, sin signos de disfagia ni malestar.

HERRERA SILVA ASTRID CAROLINA

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

26/03/2026 11:30 Se administra tableta Ácido acetilsalicílico 100mg vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

HERRERA SILVA ASTRID CAROLINA

26/03/2026 12:00 Se realizó cambio de pañal: se retira pañal desechable, procedimiento de limpieza de la región perineal con solución adecuada y material estéril.
Se aplica crema protectora en la zona perineal para prevenir irritación o dermatitis por contacto con la orina.
Paciente quedó confortable, con la piel limpia e integral

HERRERA SILVA ASTRID CAROLINA

26/03/2026 12:15 Se realiza cambio de posición: Adecúbito lateral derecho, con el fin de favorecer el confort de la paciente y prevenir lesiones por presión. Paciente queda en posición adecuada, cómoda y con tolerancia al procedimiento.

HERRERA SILVA ASTRID CAROLINA

26/03/2026 13:10 En la fecha y hora actual, se realiza traslado de la paciente desde la cama hacia la silla de ruedas especial mediante el uso de grúa. Durante el procedimiento se evidencia que la grúa presenta fallas en su funcionamiento, probablemente asociadas a falta de mantenimiento, por lo cual se solicita apoyo del señor Carlos, conocido de la familia, para garantizar una movilización segura.
El traslado se realiza con las debidas precauciones, logrando completar el procedimiento sin incidentes. El señor Carlos se encuentra presente además por motivo de un arreglo de una tableta en la aviación, por ese motivo se realizo el traslado al área de la sala.
Posteriormente, la paciente es ubicada en la sala en su silla de ruedas especial, quedando en posición cómoda y segura, bajo supervisión.
Se deja constancia de la necesidad de mantenimiento de la grúa para garantizar la seguridad en futuras movilizaciones.
Auxiliar de enfermería:
Astrid Carolina Herrera

HERRERA SILVA ASTRID CAROLINA

26/03/2026 13:25 se suministró el almuerzo a la paciente dieta sólida [luz Belén], quien se encuentra en cama. Se verificó que la paciente toleró adecuadamente los alimentos, sin signos de disfagia ni malestar.

HERRERA SILVA ASTRID CAROLINA

26/03/2026 14:15 Paciente Luz Belén se encuentra en la sala en compañía del personal de enfermería, en espera del secado de las tabletas previamente instaladas. Durante este tiempo, se realizan actividades de acompañamiento y estimulación, manteniendo a la paciente en un ambiente tranquilo y seguro. Paciente se observa estable, sin presentar novedades.

HERRERA SILVA ASTRID CAROLINA

26/03/2026 16:00 Se registra que durante el turno se recibe la visita del hijo de la paciente, el señor Carlos Fernando Espitia. Al momento del encuentro, la paciente presenta cambio en su estado emocional, evidenciando llanto al ver a su familiar. Se brinda acompañamiento y contención emocional durante la visita. Posteriormente, la paciente permanece en su lugar. Se continúa monitoreo del estado general.

HERRERA SILVA ASTRID CAROLINA

26/03/2026 18:00 Se realizó cambio de pañal: se retira pañal desechable, procedimiento de limpieza de la región perineal con solución adecuada y material estéril.
Se aplica crema protectora en la zona perineal para prevenir irritación o dermatitis por contacto con la orina.
Paciente quedó confortable, con la piel limpia e integral

HERRERA SILVA ASTRID CAROLINA

26/03/2026 19:00 Entrego paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: Encefalopatia hipoxica,crisis epilépticas, cuadriplejia flácida y polineuropatia no especificada, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez),

HERRERA SILVA ASTRID CAROLINA

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable dormida con buen patrón respiratorio, presenta pequeños hematomas en miembros inferiores y superiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en cama hospitlaria posición decubito supino colchón antiescaras ,paciente en el programa de atención domiciliaria

Paciente estable desorientada en las 3 esferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara con olor fuerte , extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO:
Paciente se mantiene ansiosa manifiesta que se siente triste , paciente Tolera adecuadamente la vía oral para la administración de medicamentos.
Se realiza con movilización con ayuda de grua preservando la seguridad del paciente el baño
•Se hace acompañamiento y supervisión en el desarrollo de terapias realizadas por el fisioterapeuta particular (Andrés Rodríguez)
•Se realizó aseo rutinario de las áreas asignadas

OBSERVACIONES
• Dentro del domicilio Se observa hace tiempo material mecánicos, a fuera llenos de polvo y mugre.(a Jefe de ruta ordeno cerrar las ventan que va directo del paciente).
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.
•Se evidencia que la grúa de movilización presenta fallas en su funcionamiento, también se observa que el chaleco (arnés)
Utilizado para la movilización de la paciente se encuentra deteriorado.(presenta desgaste en sus sujeciones) Por lo tanto requiere mantenimiento, se decide suspender su uso apartir de la fecha

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)
• Pendiente terapias fisioterapeuta
• pendiente terapias ocupacional
•Pendiente terapias fonoaudiologo

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50 pm un a dosis adicional por orden médica
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

Elimino (++)
Deposición (-)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral(desayuno, almuerzo)
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal.
terapia con la pelota ejercicios en miembros superiores e inferiores.

Entrego Aux- Astrid Herrera
Recibe Aux- Amparo García

26/03/2026 19:00

Recibo paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: Encefalopatia hipoxica,crisis epilépticas, cuadriplejia flácida y polineuropatia no especificada, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

Amparo G.
B. Amparo. Garcia. C.
Auxiliar de Enfermeria
CC - 1.09 1.7.057
Reg 54-3555

GARCIA CARDENAS BLANCA AMPARO

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable tranquila presenta pequeños hematomas en miembros inferiores y superiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en el domicilio en cama hospitalaria con colchón anti escara funcional en el programa de atención domiciliaria, con barandas de seguridad elevadas en posición Fowler.

Paciente estable desorientada en las 3 esferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara, extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO:
Paciente se mantiene hemodinámicamente estable y tranquila. Tolera adecuadamente la vía oral para la administración de medicamentos y la ingesta de alimentos.

OBSERVACIONES
•observa hace tiempo material mecánicos, a fuera llenos de polvo y mugre.(a Jefe de ruta ordeno cerrar las ventan que va directo del paciente).
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
* Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
* Pendiente cita psicóloga (Mayo)
* Pendiente terapias fisioterapeuta
* pendiente terapias ocupacional
•Pendiente terapias fonoaudiologo

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50pm, se administra una dosis adicional según orden médica.
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (++)
Deposición (-)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral (Desayuno, almuerzo)
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal.

26/03/2026 20:00 Se administra tableta losartan 50mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

GARCIA CARDENAS BLANCA AMPARO

26/03/2026 20:20 Se administra capsula Amantadina 100mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

GARCIA CARDENAS BLANCA AMPARO

26/03/2026 20:30 Se administra tableta Citicolina 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones

GARCIA CARDENAS BLANCA AMPARO

26/03/2026 20:50 Se administra dos cápsulas de Ácido valproico 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

GARCIA CARDENAS BLANCA AMPARO

26/03/2026 21:00 Se administra Quetiapina 200mg, mas dos tabletas Quetiapina 25mg un total administrados 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

GARCIA CARDENAS BLANCA AMPARO

26/03/2026 21:09 Se asiste a la hora de la cena , proporcionándole una dieta blanda, se le da tiempo suficiente para que mastique y trague cada bocado, antes de ofrecerle el siguiente, tolera por via oral sin complicacion, paciente colaborador, apetito conservado.

GARCIA CARDENAS BLANCA AMPARO

26/03/2026 21:59 Se retiran ropa de vestir y se realiza lubricación de la piel con crema corporal. Posteriormente, se coloca pijama limpia y seca, paciente estable con ropa pijama piel hidratada

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

26/03/2026 23:01	Se realiza cambio de posición a decúbito lateral izquierdo, colocando almohadas de soporte en región dorsal y entre miembros inferiores para favorecer alineación corporal y confort del paciente. Durante el procedimiento, paciente presenta episodio de nerviosismo.	GARCIA CARDENAS BLANCA AMPARO Amparo G. B.Amparo. Garcia.C. Auxiliar de Enfermeria CC. 60317067 Reg 61-3955
27/03/2026 00:01	Se realiza cambio de posición a decúbito lateral derecho , colocando almohadas de soporte en región dorsal y entre miembros inferiores para favorecer alineación corporal y confort del paciente. Durante el procedimiento, paciente dormida.	GARCIA CARDENAS BLANCA AMPARO Amparo G. B.Amparo. Garcia.C. Auxiliar de Enfermeria CC. 60317067 Reg 61-3955
27/03/2026 05:00	Se administra Acido valproico 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	GARCIA CARDENAS BLANCA AMPARO Amparo G. B.Amparo. Garcia.C. Auxiliar de Enfermeria CC. 60317067 Reg 61-3955
27/03/2026 06:07	Se realiza cambio de pañal empleando los elementos necesarios (pañal limpio, toallitas húmedas, crema antipañalitis, guantes de látex). Se asegura la cama hospitalaria contra la pared. Se realiza cambio de sábanas y pongo sábanas limpias.	GARCIA CARDENAS BLANCA AMPARO Amparo G. B.Amparo. Garcia.C. Auxiliar de Enfermeria CC. 60317067 Reg 61-3955
27/03/2026 07:00	Entrego paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO DX: Encefalopatia hipoxica,crisis epilépticas, cuadriplejia flácida y polineuropatia no especificada, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida. Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable dormida con buen patrón respiratorio, presenta pequeños hematomas en miembros inferiores y superiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes. Paciente se encuentra estable, en cama hospitlaria posición decubito supino colchón antiescaras ,paciente en el programa de atención domiciliaria con barandas de seguridad elevadas en posición decubito supino. Paciente estable desorientada en las 3 esferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica, Ojos normoreactivos a la luz, Mucosa nasal húmeda sin laceraciones, Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara con olor fuerte , extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis). NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO: Paciente se mantiene dormida. Durante el turno paciente Tolera adecuadamente la vía oral para la administración de medicamentos. Concilio sueño temprano. OBSERVACIONES * Dentro del domicilio Se observa hace tiempo material mecánicos, a fuera llenos de polvo y mugre.(a Jefe de ruta ordeno cerrar las ventan que va directo del paciente). •Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco •observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.	GARCIA CARDENAS BLANCA AMPARO Amparo G. B.Amparo. Garcia.C. Auxiliar de Enfermeria CC. 60317067 Reg 61-3955 GARCIA CARDENAS BLANCA AMPARO

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.
•Se evidencia que la grúa de movilización presenta fallas en su funcionamiento, también se observa que el chaleco (arnés)
Utilizado para la movilización de la paciente se encuentra deteriorado.(presenta desgaste en sus sujeciones) Por lo tanto requiere mantenimiento, se decide suspender su uso apartir de la fecha

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
* Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
* Pendiente cita psicóloga (Mayo)
* Pendiente terapias fisioterapeuta
* pendiente terapias ocupacional
•Pendiente terapias fonoaudiologo

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50 pm un a dosis adicional por orden médica
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (++)
Deposición (-)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral(Cena)
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal.
terapia con la pelota ejercicios en miembros superiores e inferiores.

27/03/2026 07:00

Recibo paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: Encefalopatia hipoxica,crisis epilépticas, cuadriplejia flácida y polineuropatia no especificada, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable dormida con buen patrón respiratorio, presenta pequeños hematomas en miembros inferiores y superiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en cama hospitlaria posición decubito supino colchón antiescaras ,paciente en el programa de atención domiciliaria con barandas de seguridad elevadas en posición semifowler.

Paciente estable desorientada en las 3 esferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados,

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara con olor fuerte , extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO:
Paciente se mantiene dormida. Durante el turno paciente Tolera adecuadamente la vía oral para la administración de medicamentos. Concilio sueño temprano.

OBSERVACIONES
• Dentro del domicilio Se observa hace tiempo material mecánicos, a fuera llenos de polvo y mugre.(a Jefe de ruta ordeno cerrar las ventan que va directo del paciente).
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.
•Se evidencia que la grúa de movilización presenta fallas en su funcionamiento, también se observa que el chaleco (arnés)
Utilizado para la movilización de la paciente se encuentra deteriorado.(presenta desgaste en sus sujeciones) Por lo tanto requiere mantenimiento, se decide suspender su uso apartir de la fecha

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)
• Pendiente terapias fisioterapeuta
• pendiente terapias ocupacional
•Pendiente terapias fonoaudiologo

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50 pm un a dosis adicional por orden médica
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (++)
Deposición (-)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral(Cena)
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal.
terapia con la pelota ejercicios en miembros superiores e inferiores.
Recibe Aux- Adriana Beltrán
Entrego Aux- Amparo Garcia

27/03/2026 07:13 Se realiza higiene bucal con cepillo electrico y crema colgate y agua, se realiza peinado.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

27/03/2026 08:00 Se administra tableta losartan 50mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

27/03/2026 08:10	Se administra tableta Esomeprazol 20mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
27/03/2026 08:20	Se administra capsula Amantadina 100mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
27/03/2026 08:30	Se administra capsula Amantadina 100mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
27/03/2026 08:37	Se asiste a la hora del desayuno, proporcionándole una dieta sólida, se le da tiempo suficiente para que mastique y trague cada bocado, antes de ofrecerle el siguiente, tolera por via oral sin complicacion, paciente colaborador, apetito conservado.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
27/03/2026 09:23	Se realiza cambio de posición semifowler.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
27/03/2026 11:23	Se realiza baño en cama al paciente, utilizando agua tibia, jabón liquido y toallas limpias. Se efectúa aseo en cara, brazos, tronco, extremidades e higiene íntima. Durante el procedimiento se realiza depilación en zona íntima y axilas, con adecuada tolerancia. Posteriormente, se seca la piel cuidadosamente y se aplica crema hidratante para favorecer la integridad cutánea. Se cambia ropa limpia y pijama. Se observa piel íntegra, Paciente permanece tranquila y tolera satisfactoriamente el procedimiento.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
27/03/2026 11:30	Se administra tableta Ácido acetilsalicílico 100mg vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
27/03/2026 13:00	Se administra Acido valproico 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
27/03/2026 13:41	Asisto a la hora del almuerzo del paciente proporcionándole una dieta sólida, se le da tiempo suficiente para que mastique y trague cada bocado, antes de ofrecerle el siguiente, tolera por via oral sin complicacion, paciente colaborador, apetito conservado.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

27/03/2026 13:45 Después del almuerzo se administra jarabe Escitalopram en solución oral, 20 cc, según indicación médica(psiquiatra) Tolera la administración por vía oral sin complicaciones, sin presencia de náuseas ni vómito, Paciente tranquila.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

27/03/2026 14:02 Se realiza higiene bucal con cepillo electrico y crema colgate y agua. Se realiza cambio de posición semifowler, paciente estable tranquila reposando, en acompañamiento del familiar doña alis (madre de la paciente) y carlos Omar conocido.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

27/03/2026 15:08 Se realiza cambio de posición a decúbito lateral izquierdo, colocando almohadas de soporte en región dorsal y entre miembros inferiores para favorecer alineación corporal y confort del paciente. Durante el procedimiento, paciente presenta episodio de nerviosismo.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

27/03/2026 16:45 Se realiza actividad de estimulación cognitiva y reconocimiento de colores. Paciente participa en la actividad, logrando identificar algunos colores con apoyo. Paciente tolera la actividad sin presentar complicaciones.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

27/03/2026 17:38 Se realiza cambio de pañal empleando los elementos necesarios (pañal limpio, toallitas húmedas, crema antipañalitis, guantes de látex). Se asegura la cama hospitalaria contra la pared. Se realiza cambio de sábanas y pongo sábanas limpias.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

27/03/2026 18:23 Ingresa al domicilio el fonoaudiólogo particular Jhonathan Ibáñez, quien realiza terapia con electroestimulación y masajes en región cervical, Paciente se encuentra estable, tranquila y colaboradora durante el procedimiento.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

27/03/2026 19:00 Recibo paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: Encefalopatia hipoxica,crisis epilépticas, cuadriplejia flácida y polineuropatia no especificada, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable tranquila, dormida, presenta pequeños hematomas en miembros inferiores y superiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en cama hospitlaria posición decubito supino colchón antiescaras ,paciente en el programa de atención domiciliaria con barandas de seguridad elevadas en posición decúbito supino.

Paciente estable desorientada en las 3 esferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara con olor fuerte , extremidades superiores normales con flexión y extensión,

HERRERA SILVA ASTRID CAROLINA

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

27/03/2026 19:00

Entrego paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: Encefalopatia hipoxica,crisis epilépticas, cuadriplejia flácida y polineuropatia no especificada, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable tranquila presenta pequeños hematomas en miembros inferiores y superiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en cama hospitlaria posición decubito supino colchón antiescaras ,paciente en el programa de atención domiciliaria con barandas de seguridad elevadas en posición decúbito.

Paciente estable desorientada en las 3 esferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara con olor fuerte , extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO:
Paciente se mantiene dormida. Durante el turno paciente Tolera adecuadamente la vía oral para la administración de medicamentos. Ingreso al domicilio fonoaudiologo particular, paciente colaboradora y tolera la terapias.

OBSERVACIONES
• Dentro del domicilio Se observa hace tiempo material mecánicos, a fuera llenos de polvo y mugre.(a Jefe de ruta ordeno cerrar las ventan que va directo del paciente).
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.
•Se evidencia que la grúa de movilización presenta fallas en su funcionamiento, también se observa que el chaleco (arnés)
Utilizado para la movilización de la paciente se encuentra deteriorado.(presenta desgaste en sus sujeciones) Por lo tanto requiere mantenimiento, se decide suspender su uso apartir de la fecha

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)
• Pendiente terapias fisioterapeuta
• pendiente terapias ocupacional
•Pendiente terapias fonoaudiologo

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50 pm un a dosis adicional por orden médica
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (++)
Deposición (-)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral(Desayuno, almuerzo)
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal.
terapia con la pelota ejercicios en miembros superiores e inferiores.
Entrego Aux- Adriana Beltrán
Recibe Aux- Astrid Herrera

27/03/2026 20:00 Se administra tableta losartan 50mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

HERRERA SILVA ASTRID CAROLINA

27/03/2026 20:10 Se administra tableta Amlodipino 5mg vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones

HERRERA SILVA ASTRID CAROLINA

27/03/2026 20:20 Se administra capsula Amantadina 100mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

HERRERA SILVA ASTRID CAROLINA

27/03/2026 20:30 Se administra tableta Citicolina 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

HERRERA SILVA ASTRID CAROLINA

27/03/2026 20:50 Se administra dos cápsulas de Ácido valproico 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

HERRERA SILVA ASTRID CAROLINA

27/03/2026 21:00 Se administra Quetiapina 200mg, mas dos tabletas Quetiapina 25mg un total administrados 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

HERRERA SILVA ASTRID CAROLINA

27/03/2026 22:00 Se realiza cambio de posición: Adecúbito lateral izquierdo, con el fin de favorecer el confort de la paciente y prevenir lesiones por presión. Paciente queda en posición adecuada, cómoda y con tolerancia al procedimiento.

HERRERA SILVA ASTRID CAROLINA

27/03/2026 23:00 Se realizó cambio de pañal: se retira pañal desechable, procedimiento de limpieza de la región perineal con solución adecuada y material estéril.

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

Se aplica crema protectora en la zona perineal para prevenir irritación o dermatitis por contacto con la orina.
Paciente quedó confortable, con la piel limpia e integral

HERRERA SILVA ASTRID CAROLINA

28/03/2026 02:00

Se realiza cambio de posición: Adecúbito lateral derecho, con el fin de favorecer el confort de la paciente y prevenir lesiones por presión. Paciente queda en posición adecuada, cómoda y con tolerancia al procedimiento.

HERRERA SILVA ASTRID CAROLINA

28/03/2026 05:20

Se realizó cambio de pañal: se retira pañal desechable, procedimiento de limpieza de la región perineal con solución adecuada y material estéril.
Se aplica crema protectora en la zona perineal para prevenir irritación o dermatitis por contacto con la orina.
Paciente quedó confortable, con la piel limpia e integral

HERRERA SILVA ASTRID CAROLINA

28/03/2026 07:00

Entrego paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: Encefalopatia hipoxica,crisis epilépticas, cuadriplejia flácida y polineuropatia no especificada, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable tranquila, dormida, presenta pequeños hematomas en miembros inferiores y superiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en cama hospitlaria posición decubito supino colchón antiescaras ,paciente en el programa de atención domiciliaria con barandas de seguridad elevadas en posición decúbito supino.

Paciente estable desorientada en las 3 esferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión,
extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara con olor fuerte , extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO:
Paciente se mantiene dormida. Durante el turno paciente Tolera adecuadamente la vía oral para la administración de medicamentos. Concilio sueño temprano, se realizo los cambios de posiciones.

OBSERVACIONES
* Dentro del domicilio Se observa hace tiempo material mecánicos, a fuera llenos de polvo y mugre.(a Jefe de ruta ordeno cerrar las ventan que va directo del paciente).
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.
•Se evidencia que la grúa de movilización presenta fallas en su funcionamiento, también se observa que el chaleco (arnés)
Utilizado para la movilización de la paciente se encuentra deteriorado.(presenta desgaste en sus sujeciones) Por lo tanto requiere mantenimiento, se decide suspender su uso apartir de la fecha

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)

HERRERA SILVA ASTRID CAROLINA

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
* Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
* Pendiente cita psicóloga (Mayo)
* Pendiente terapias fisioterapeuta
* pendiente terapias ocupacional
•Pendiente terapias fonoaudiologo

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50 pm un a dosis adicional por orden médica
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (++)
Deposición (+)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral(cena)
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal.
terapia con la pelota ejercicios en miembros superiores e inferiores.

Entrega Aux- Astrid Herrera
Recibe Aux- Amparo

28/03/2026 07:00

Con previo lavado de manos y EPP,Recibo paciente adulto mayor femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: Encefalopatia hipoxica
*crisis epilépticas
*cuadriplejia flácida *polineuropatia no especificada
*hipertensión esencial, *incontinencia urinaria, no especificada
*constipación
*fractura de pelvis (resuelta) *fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso
*Transtorno mixto de ansiedad y depresión

Amparo G.
B. Amparo. Garcia. C.
Auxiliar de Enfermeria
CC. 60317067
Reg 84-3955

GARCIA CARDENAS BLANCA AMPARO

ANTECEDENTE PATOLOGICO PERSONALES :
*secuelas post covid 19, *hipertensión arterial esencial primaria, *encefalopatía hipoxemica apraxia verbal
*síndrome de movilidad reducida.

VALORACION CEFALOCAUDAL:se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara con olor fuerte , extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).pte desorientada en tiempo,lugar,espacio,Glasgow 14/15,afebril,pte alerta al llamado,lenguaje incoherente
Pte en domicilio con cama hospitalaria con barandas elevadas en compañía del familiar,hija Carmen Ramírez,Cuñado José,esposo Carlos omar.

OBSERVACIONES:

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

• Dentro del domicilio Se observa hace tiempo material mecánicos, a fuera llenos de polvo y mugre.(a Jefe de ruta ordeno cerrar las ventan que va directo del paciente).
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)
• Pendiente terapias fisioterapeuta
• pendiente terapias ocupacional
•Pendiente terapias fonoaudiologo

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50 pm un a dosis adicional por orden médica
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (+)
Deposición (-)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS DEL TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal.
terapia con la pelota ejercicios en miembros superiores e inferiores.
SIGNOS VITALES:
TA: 100/75mm/Hg
FC: 78x'
FR: 16x'
SPO2:95 %
T:36.2 °C

28/03/2026 08:00 se administra medicamento ordenado por vo
se realiza baño general en cama con jabón y agua,se seca,se lubrica piel,se viste,se deja comoda

Amparo G.
B.Amparo. Garcia.C.
Auxiliar de Enfermeria
CC. 50317067
Reg 54-3955

GARCIA CARDENAS BLANCA AMPARO

28/03/2026 08:00 Con previo lavado de manos, uso de epp y cumpliendo los 15 correctos (1 Realizar higiene de manos, 2 Indagar antecedentes alérgicos correctos,3 Toma de signos vitales, Medicamento correcto,5 Dosis correcta,6 Vía administración correcta,7 Hora correcta,8 Pte correcto, 9 Técnica administración correcta,10 Velocidad de infusión correcta,11 Verificar fecha de caducidad, 12 Prepare y administre usted mismo el medicamento,13 Realice usted mismo el registro de los medicamentos después de administrar,14 No administrar medicamento bajo orden verbal,15 Educar al familiar y el pte sobre el medicamento que se administro)se administra 1 tableta de Losartan x50mg vo

Amparo G.
B.Amparo. Garcia.C.
Auxiliar de Enfermeria
CC. 50317067
Reg 54-3955

GARCIA CARDENAS BLANCA AMPARO

28/03/2026 08:10 Con previo lavado de manos, uso de epp y cumpliendo los 15 correctos (1 Realizar higiene de manos, 2 Indagar antecedentes alérgicos correctos,3 Toma de signos vitales, Medicamento correcto,5 Dosis correcta,6 Vía administración correcta,7 Hora correcta,8 Pte correcto, 9 Técnica administración correcta,10 Velocidad de infusión correcta,11 Verificar fecha de caducidad, 12 Prepare y administre usted mismo el medicamento,13 Realice usted mismo el registro de los medicamentos después de administrar,14 No administrar medicamento bajo orden verbal,15 Educar al familiar y el pte sobre el medicamento que se administro)se administra 1 tableta de esomeprazol x20mg vo

Amparo G.
B.Amparo. Garcia.C.
Auxiliar de Enfermeria
CC. 50317067
Reg 54-3955

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

28/03/2026 08:10	se administra medicamento ordenada por vo Recibe desayuno vo sin novedad.	GARCIA CARDENAS BLANCA AMPARO
28/03/2026 08:15	se administra medicamento ordenado por vo	GARCIA CARDENAS BLANCA AMPARO
28/03/2026 08:20	se administra medicamento ordenado por vo	GARCIA CARDENAS BLANCA AMPARO
28/03/2026 08:20	Con previo lavado de manos, uso de epp y cumpliendo los 15 correctos (1 Realizar higiene de manos, 2 Indagar antecedentes alérgicos correctos,3 Toma de signos vitales, Medicamento correcto,5 Dosis correcta,6 Vía administración correcta,7 Hora correcta,8 Pte correcto, 9 Técnica administración correcta,10 Velocidad de infusión correcta,11 Verificar fecha de caducidad, 12 Prepare y administre usted mismo el medicamento,13 Realice usted mismo el registro de los medicamentos después de administrar,14 No administrar medicamento bajo orden verbal,15 Educar al familiar y el pte sobre el medicamento que se administro)se administra 1 tableta de amantadina x100mg vo	GARCIA CARDENAS BLANCA AMPARO
28/03/2026 08:30	Ingresa al Domicilio con previo lavado de manos y utilizando elementos de protección personal Fisioterapeuta Andrés Rodríguez quién realiza terapia física sin complicaciones hasta el momento.	GARCIA CARDENAS BLANCA AMPARO
28/03/2026 08:30	Con previo lavado de manos, uso de epp y cumpliendo los 15 correctos (1 Realizar higiene de manos, 2 Indagar antecedentes alérgicos correctos,3 Toma de signos vitales, Medicamento correcto,5 Dosis correcta,6 Vía administración correcta,7 Hora correcta,8 Pte correcto, 9 Técnica administración correcta,10 Velocidad de infusión correcta,11 Verificar fecha de caducidad, 12 Prepare y administre usted mismo el medicamento,13 Realice usted mismo el registro de los medicamentos después de administrar,14 No administrar medicamento bajo orden verbal,15 Educar al familiar y el pte sobre el medicamento que se administro)se administra 1 tableta de citicolina x250mg vo	GARCIA CARDENAS BLANCA AMPARO
28/03/2026 09:00	paciente tranquila dormida	GARCIA CARDENAS BLANCA AMPARO
28/03/2026 09:00	realizo baño de la paciente en cama sin novedad	Andrea valencia.
28/03/2026 10:00	se realiza cambio deposición en decúbito lateral izquierdo y se lubrica piel	VALENCIA MEDINA TANIA ANDREA
28/03/2026 11:00	pte ve television sin novedad	GARCIA CARDENAS BLANCA AMPARO

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

28/03/2026 11:30	se administra medicamento ordenado por vo	GARCIA CARDENAS BLANCA AMPARO
28/03/2026 11:30	Con previo lavado de manos, uso de epp y cumpliendo los 15 correctos (1 Realizar higiene de manos, 2 Indagar antecedentes alérgicos correctos,3 Toma de signos vitales, Medicamento correcto,5 Dosis correcta,6 Vía administración correcta,7 Hora correcta,8 Pte correcto, 9 Técnica administración correcta,10 Velocidad de infusión correcta,11 Verificar fecha de caducidad, 12 Prepare y administre usted mismo el medicamento,13 Realice usted mismo el registro de los medicamentos después de administrar,14 No administrar medicamento bajo orden verbal,15 Educar al familiar y el pte sobre el medicamento que se administro)se administra 1 tableta de asa x100mg vo	GARCIA CARDENAS BLANCA AMPARO
28/03/2026 12:00	se realiza cambio deposicion decúbito lateral derecho,se lubrica piel •Recibe y tolera almuerzo vo sin novedad	GARCIA CARDENAS BLANCA AMPARO
28/03/2026 12:00	se realiza cambio deposicion decúbito lateral derecho,se lubrica piel •Recibe y tolera almuerzo vo sin novedad	GARCIA CARDENAS BLANCA AMPARO
28/03/2026 13:00	se administra medicamento ordenado por vo	GARCIA CARDENAS BLANCA AMPARO
28/03/2026 13:00	Con previo lavado de manos, uso de epp y cumpliendo los 15 correctos (1 Realizar higiene de manos, 2 Indagar antecedentes alérgicos correctos,3 Toma de signos vitales, Medicamento correcto,5 Dosis correcta,6 Vía administración correcta,7 Hora correcta,8 Pte correcto, 9 Técnica administración correcta,10 Velocidad de infusión correcta,11 Verificar fecha de caducidad, 12 Prepare y administre usted mismo el medicamento,13 Realice usted mismo el registro de los medicamentos después de administrar,14 No administrar medicamento bajo orden verbal,15 Educar al familiar y el pte sobre el medicamento que se administro)se administra 1 capsula de acido valproico x250mg vo	GARCIA CARDENAS BLANCA AMPARO
28/03/2026 13:15	se administra medicamento ordenado por vo • pte viendo television	GARCIA CARDENAS BLANCA AMPARO
28/03/2026 13:30	Con previo lavado de manos, uso de epp y cumpliendo los 15 correctos (1 Realizar higiene de manos, 2 Indagar antecedentes alérgicos correctos,3 Toma de signos vitales, Medicamento correcto,5 Dosis correcta,6 Vía administración correcta,7 Hora correcta,8 Pte correcto, 9 Técnica administración correcta,10 Velocidad de infusión correcta,11 Verificar fecha de caducidad, 12 Prepare y administre usted mismo el medicamento,13 Realice usted mismo el registro de los medicamentos después de administrar,14 No administrar medicamento bajo orden verbal,15 Educar al familiar y el pte sobre el medicamento que se administro)se administra 20cc de escitalipram (bruliva) 120ml vo	GARCIA CARDENAS BLANCA AMPARO
28/03/2026 14:00	se realiza higiene genital con jabón y agua,se aplica crema y cambio de pañal,hizo de posicion poca cantidad •se realiza cambio deposición decúbito lateral izquierdo y se lubrica piel	GARCIA CARDENAS BLANCA AMPARO
28/03/2026 15:00	pte duerme en intervalos, ve television	GARCIA CARDENAS BLANCA AMPARO

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

28/03/2026 16:00

se realiza cambio deposición en decúbito supino y se lubrica piel
•pte tranquila

GARCIA CARDENAS BLANCA AMPARO

28/03/2026 17:00

pte viendo television

GARCIA CARDENAS BLANCA AMPARO

28/03/2026 18:00

se toma signos vitales y se registra
•se realiza cambio deposición en decúbito supino y se lubrica piel
•pte viendo television

GARCIA CARDENAS BLANCA AMPARO

28/03/2026 19:00

pte viendo televisión
queda en posición supino,se observa tranquila

GARCIA CARDENAS BLANCA AMPARO

28/03/2026 19:00

Recibo paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: Encefalopatia hipoxica,crisis epilépticas, cuadriplejia flácida y polineuropatia no especificada, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable tranquila presenta pequeños hematomas en miembros inferiores y superiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en cama hospitlaria posición decubito supino colchón antiescaras ,paciente en el programa de atención domiciliaria con barandas de seguridad elevadas en posición decúbito.

Paciente estable desorientada en las 3 esferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara con olor fuerte , extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO:
Paciente se mantiene dormida. Durante el turno paciente Tolera adecuadamente la vía oral para la administración de medicamentos. Ingreso al domicilio Fisioterapeuta partículas Andres Rodriguez.

OBSERVACIONES
• Dentro del domicilio Se observa hace tiempo material mecánicos, a fuera llenos de polvo y mugre.(a Jefe de ruta ordeno cerrar las ventan que va directo del paciente).
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.
•Se evidencia que la grúa de movilización presenta fallas en su funcionamiento, también se observa que el chaleco (arnés)
Utilizado para la movilización de la paciente se encuentra deteriorado.(presenta desgaste en sus sujeciones) Por lo tanto requiere mantenimiento, se decide suspender su uso apartir de la fecha

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)
• Pendiente terapias fisioterapeuta
• pendiente terapias ocupacional
•Pendiente terapias fonoaudiologo

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50 pm un a dosis adicional por orden médica
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (++)
Deposición (+)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral(Desayuno, almuerzo)
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal.
terapia con la pelota ejercicios en miembros superiores e inferiores.
Recibe Aux- Adriana Beltrán
Entrega Aux- Amparo Garcia

28/03/2026 19:43 Se asiste a la hora de la cena , proporcionándole una dieta sólida, se le da tiempo suficiente para que mastique y trague cada bocado, antes de ofrecerle el siguiente, tolera por via oral sin complicacion, paciente colaborador, apetito conservado.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

28/03/2026 20:00 Se administra tableta losartan 50mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

28/03/2026 20:20 Se administra capsula Amantadina 100mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

28/03/2026 20:30 Se administra tableta Citicolina 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

28/03/2026 20:50	Se administra dos cápsulas de Ácido valproico 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
28/03/2026 20:52	Se realiza higiene bucal con cepillo electrico y crema colgate y agua.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
28/03/2026 21:00	Se administra Quetiapina 200mg, mas dos tabletas Quetiapina 25mg un total administrados 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
28/03/2026 22:32	Se retiran ropa de vestir y se realiza lubricación de la piel con crema corporal. Posteriormente, se coloca pijama limpia y seca, paciente estable con ropa limpia piel hidratada.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
28/03/2026 22:53	Se realiza cambio de pañal empleando los elementos necesarios (pañal limpio, toallitas húmedas, crema antipañalitis, guantes de látex). Se asegura la cama hospitalaria contra la pared. Se realiza cambio de sábanas y pongo sábanas limpias.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
28/03/2026 23:10	Se realiza cambio de posición a decúbito lateral izquierdo, colocando almohadas de soporte en región dorsal y entre miembros inferiores para favorecer alineación corporal y confort del paciente. Durante el procedimiento, paciente presenta episodio de nerviosismo.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
29/03/2026 00:02	Se observa paciente dormida con buen patrón respiratorio.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
29/03/2026 01:28	Se observa paciente dormida con buen patrón respiratorio.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
29/03/2026 02:26	Se realiza cambio de posición a decúbito lateral derecho, colocando almohadas de soporte en región dorsal y entre miembros inferiores para favorecer alineación corporal y confort del paciente. Durante el procedimiento, paciente presenta episodio de nerviosismo.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

29/03/2026 03:27 Se hace vigilancia, paciente dolía con buen patrón respiratorio.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

29/03/2026 04:28 Se realiza cambio de posición semifowler, paciente estable con episodios de nerviosismo.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

29/03/2026 05:00 Se administra Acido valproico 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

29/03/2026 05:45 Se realiza cambio de pañal empleando los elementos necesarios (pañal limpio, toallitas húmedas, crema antipañalitis, guantes de látex). Se asegura la cama hospitalaria contra la pared. Se realiza cambio de sábanas y pongo sábanas limpias.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

29/03/2026 06:24 Se realiza cambio de sábana de movimiento garantizando limpieza y comodidad del paciente, dejando la superficie libre de arrugas, realizo cambio de posición decúbito supino, paciente estable dormida con buen patrón respiratorio.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

29/03/2026 06:26 Se aplico en el cambio de pañal crema 60mg vainas antipañalitis instacalm(nistatina +óxido de zinc) y crema Almipro pañalitis (óxido de zin) en los glúteos.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

29/03/2026 07:00 Entrego paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: Encefalopatia hipoxica,crisis epilépticas, cuadriplejia flácida y polineuropatia no especificada, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable tranquila presenta pequeños hematomas en miembros inferiores y superiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en cama hospitlaria posición decubito supino colchón antiescaras ,paciente en el programa de atención domiciliaria con barandas de seguridad elevadas en posición decúbito supino.

Paciente estable desorientada en las 3 esferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara con olor fuerte , extremidades superiores normales con flexión y extensión,

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO:
Paciente se mantiene dormida. Durante el turno paciente Tolera adecuadamente la vía oral para la administración de medicamentos. Concilio sueño temprano, se realizo los cambios de posiciones.

OBSERVACIONES
• Dentro del domicilio Se observa hace tiempo material mecánicos, a fuera llenos de polvo y mugre.(a Jefe de ruta ordeno cerrar las ventan que va directo del paciente).
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.
•Se evidencia que la grúa de movilización presenta fallas en su funcionamiento, también se observa que el chaleco (arnés)
Utilizado para la movilización de la paciente se encuentra deteriorado.(presenta desgaste en sus sujeciones) Por lo tanto requiere mantenimiento, se decide suspender su uso apartir de la fecha

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)
• Pendiente terapias fisioterapeuta
• pendiente terapias ocupacional
•Pendiente terapias fonoaudiologo

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50 pm un a dosis adicional por orden médica
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (++)
Deposición (+)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral(cena)
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal.
terapia con la pelota ejercicios en miembros superiores e inferiores.
Entrega Aux- Adriana Beltrán
Recibe Aux- Astrid Herrera

29/03/2026 07:00 Recibo:
Paciente: Luz Belén Ramírez Carrillo
Edad: 58 años
DX: Encefalopatía hipóxica, crisis epilépticas, cuadriplejia flácida, polineuropatía no especificada, HTA, incontinencia urinaria, constipación, fracturas de pelvis y pubis (resueltas), trastorno mixto de ansiedad y depresión.
Antecedentes: Secuelas post COVID-19, HTA, encefalopatía hipoxémica, apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

• VALORACIÓN CEFALOCAUDAL
Neurológico: Paciente desorientada en tiempo, espacio y lugar. Glasgow 15/15, alerta al llamado, lenguaje incoherente.
Cabeza: Normocéfala.
Ojos: Pupilas normorreactivas a la luz.
Nariz: Mucosa nasal húmeda, sin laceraciones.
Boca: Mucosa oral húmeda, labios hidratados, piezas dentales presentes, encías rosadas en buen estado.

Astrid Carolina Herrera

HERRERA SILVA ASTRID CAROLINA

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

Cuello: Simétrico, con cicatriz de traqueostomía, movilidad reducida, no doloroso, sin adenopatías, sin soplos carotídeos.
Tórax: Expandible, sin masas, ruidos cardíacos rítmicos sin soplos.
Pulmones: Murmullo vesicular conservado, sin ruidos sobreagregados.
Abdomen: Blando, globoso, depresible, no doloroso, sin masas. Cicatriz de gastrostomía en fosa ilíaca izquierda.
Genitourinario: Genitales íntegros, buena higiene, pañal limpio, diuresis espontánea clara con olor fuerte.
Extremidades superiores: Conservan flexión y extensión.
Extremidades inferiores: Sin dolor a la movilización, sin molestias en cadera izquierda.
Piel: Íntegra, hidratada, con hematomas en extremidades, cicatriz sacra epitelizada.

29/03/2026 08:00 Se administra tableta losartan 50mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

HERRERA SILVA ASTRID CAROLINA

29/03/2026 08:10 Se administra tableta Esomeprazol 20mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

HERRERA SILVA ASTRID CAROLINA

29/03/2026 08:20 Se administra capsula Amantadina 100mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

HERRERA SILVA ASTRID CAROLINA

29/03/2026 08:30 Se administra tableta Citicolina 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

HERRERA SILVA ASTRID CAROLINA

29/03/2026 09:00 se suministró el desayuno a la paciente dieta sólida [luz Belén], quien se encuentra en cama. Se verificó que la paciente toleró adecuadamente los alimentos, sin signos de disfagia ni malestar.

HERRERA SILVA ASTRID CAROLINA

29/03/2026 10:05 Se realiza baño en cama a paciente Luz Belén Ramírez Carrillo, femenina de 58 años de edad, con diagnósticos de encefalopatía hipóxica, crisis epilépticas, cuadriplejia flácida y polineuropatía no especificada, entre otros.
Durante el procedimiento se efectúa higiene corporal completa, incluyendo aseo de cavidad oral, limpieza de zona íntima, cambio de pañal y cambio de ropa de cama. Se observa piel íntegra, hidratada, sin presencia de lesiones, enrojecimientos ni signos de deterioro cutáneo.
Paciente en condición de dependencia total, colabora de manera pasiva. Tolera adecuadamente el procedimiento, sin signos de dolor o incomodidad.
Se deja paciente en posición cómoda, con barandas elevadas y en condiciones de seguridad.

HERRERA SILVA ASTRID CAROLINA

29/03/2026 10:55 Posterior a la realización del baño en cama, se procede a secado completo de la piel, observándose íntegra y sin lesiones aparentes. Se realiza lubricación con crema hidratante (lubriderm) en todo el cuerpo, seguida de masajes suaves con el fin de favorecer la circulación y mantener la integridad cutánea. Paciente tolera el procedimiento sin complicaciones.

HERRERA SILVA ASTRID CAROLINA

29/03/2026 11:30 Se administra tableta Ácido acetilsalicílico 100mg vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

HERRERA SILVA ASTRID CAROLINA

29/03/2026 11:50 Se realizó corte de uñas en manos y pies de la paciente Luz Belén Ramírez Carrillo. Se aplicó hidratación labial y se efectuaron cuidados faciales. La paciente se mostró cómoda y receptiva durante el procedimiento, sin signos de malestar.

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

29/03/2026 13:00	Se administra Acido valproico 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	HERRERA SILVA ASTRID CAROLINA
29/03/2026 13:00	Se administra Acido valproico 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.	HERRERA SILVA ASTRID CAROLINA
29/03/2026 13:15	Se realiza cambio de posición: Adecúbito lateral derecho, con el fin de favorecer el confort de la paciente y prevenir lesiones por presión. Paciente queda en posición adecuada, cómoda y con tolerancia al procedimiento.	HERRERA SILVA ASTRID CAROLINA
29/03/2026 13:20	se suministró el Almuerzo a la paciente dieta sólida [luz Belén], quien se encuentra en cama. Se verificó que la paciente toleró adecuadamente los alimentos, sin signos de disfagia ni malestar.	HERRERA SILVA ASTRID CAROLINA
29/03/2026 14:00	Después del almuerzo se administra jarabe Escitalopram en solución oral, 20 cc, según indicación médica(psiquiatra) Tolera la administración por vía oral sin complicaciones, sin presencia de náuseas ni vómito, Paciente tranquila.	HERRERA SILVA ASTRID CAROLINA
29/03/2026 15:10	Durante el turno se realizan actividades lúdicas con la paciente, incluyendo estimulación auditiva con música suave, conversación dirigida y masajes suaves en miembros superiores e inferiores. Se mantiene contacto visual y acompañamiento constante. Se deja en posición cómoda y segura.	HERRERA SILVA ASTRID CAROLINA
29/03/2026 16:00	Se realiza aseo completo en todas las áreas asignadas. Se verifica y limpia el área de medicamentos, así como los espacios destinados para el almacenamiento de ropa, sábanas y demás insumos. Se lleva a cabo limpieza profunda de superficies, incluyendo retiro de polvo y organización general. Adicionalmente, se realiza lavado de baño. Se deja el área en óptimas condiciones de higiene, ordenada y lista para su uso.	HERRERA SILVA ASTRID CAROLINA
29/03/2026 16:55	Se realiza cambio de posición: Adecúbito lateral izquierdo, con el fin de favorecer el confort de la paciente y prevenir lesiones por presión. Paciente queda en posición adecuada, cómoda y con tolerancia al procedimiento.	HERRERA SILVA ASTRID CAROLINA
29/03/2026 18:04	Se realizó cambio de pañal: se retira pañal desechable, procedimiento de limpieza de la región perineal con solución adecuada y material estéril. Se aplica crema protectora en la zona perineal para prevenir irritación o dermatitis por contacto con la orina. Paciente quedó confortable, con la piel limpia e integral	HERRERA SILVA ASTRID CAROLINA
29/03/2026 19:00	Con previo lavado de manos y EPP, Queda paciente adulto mayor femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO DX: Encefalopatia hipoxica *crisis epilépticas *cuadriplejia flácida *polineuropatia no especificada	HERRERA SILVA ASTRID CAROLINA B. Amparo. Garcia. C. Auxiliar de Enfermeria CC. 60.317.057 Reg 61-3555

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

GARCIA CARDENAS BLANCA AMPARO

*hipertensión esencial, *incontinencia urinaria, no especificada
*constipación
*fractura de pelvis (resuelta) *fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso
*Transtorno mixto de ansiedad y depresión

ANTECEDENTE PATOLOGICO PERSONALES :
*secuelas post covid 19, *hipertensión arterial esencial primaria, *encefalopatía hipoxemica apraxia verbal
*síndrome de movilidad reducida.

VALORACION CEFALOCAUDAL:se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara con olor fuerte , extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).pte desorientada en tiempo,lugar,espacio,Glasgow 14/15,afebril,pte alerta al llamado,lenguaje incoherente
Pte en domicilio con cama hospitalaria con barandas elevadas en compañía del familiar,hija Carmen Ramírez,Cuñado José,esposo Carlos omar.

OBSERVACIONES:
• Dentro del domicilio Se observa hace tiempo material mecánicos, a fuera llenos de polvo y mugre.(a Jefe de ruta ordeno cerrar las ventan que va directo del paciente).
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)
• Pendiente terapias fisioterapeuta
• pendiente terapias ocupacional
•Pendiente terapias fonoaudiologo

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50 pm un a dosis adicional por orden médica
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (+)
Deposición (+)poca cantidad

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS DEL TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal.
terapia con la pelota ejercicios en miembros superiores e inferiores.
SIGNOS VITALES:
TA: 100/70mm/Hg

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

FC: 80x'
FR: 16x'
SPO2:95 %
T:36.2°C

29/03/2026 19:00

Entrego paciente femenino, 58 años de edad, LUZ BELÉN RAMÍREZ CARRILLO
DX: Encefalopatía hipóxica, crisis epilépticas, cuadriplejia flácida, polineuropatía no especificada, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, constipación, fractura de pelvis (resuelta), fractura de pubis (resuelta) secundarias a evento adverso, trastorno mixto de ansiedad y depresión.
Antecedentes patológicos personales: Secuelas post COVID-19, hipertensión arterial esencial primaria, encefalopatía hipoxémica, apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.
Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar (cuñado José, hermana Carmen Ramírez), conocido (Carlos Omar) y auxiliar de turno. Paciente se encuentra estable, tranquila y despierta durante el turno, presenta pequeños hematomas en miembros superiores e inferiores bilaterales secundarios a terapias físicas. Se realiza hidratación de piel con crema corporal (Lubriderm) y cambios de posición.
Paciente en cama hospitalaria en posición decúbito supino, sobre colchón antiescaras, con barandas elevadas.
Paciente estable, desorientada en las tres esferas (tiempo, espacio y lugar), Glasgow 15/15, alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerando oxígeno ambiente, con buen patrón respiratorio y en adecuadas condiciones generales e higiénicas.
VALORACIÓN CEFALOCAUDAL:
Cabeza normocéfala, ojos normorreactivos a la luz, mucosa nasal y oral húmedas, labios hidratados, piezas dentales presentes, encías rosadas. Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, movilidad reducida, no doloroso a la movilización, sin adenopatías ni soplos carotídeos. Tórax expandible, ruidos cardíacos rítmicos sin soplos, campos pulmonares sin ruidos agregados. Abdomen blando, globoso, depresible, no doloroso, con cicatriz de gastrostomía en fosa ilíaca izquierda.
Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas, pañal limpio. Diuresis espontánea (urexis) normal, clara. Extremidades superiores con movilidad, inferiores sin dolor a la movilización. Piel íntegra e hidratada, con cicatriz sacra epitelizada y recuperada, en manejo con crema antipañalitis.
NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO:
Paciente se mantiene despierta y consciente durante el turno. Tolera adecuadamente la administración de medicamentos por vía oral. Se realizan cambios de posición. Se evidencia deposición durante el turno.
OBSERVACIONES:
• Presencia de material mecánico en el domicilio con acumulación de polvo (se indica cierre de ventana cercana al paciente por orden de jefe de ruta).
• Presencia de pápulas en piel en fase de resolución.
• Cicatriz de lesión sacra epitelizada y recuperada.
• Hematomas en miembros superiores e inferiores por uso de cabestrillos en terapias físicas.
• Grúa de movilización con fallas en funcionamiento y arnés deteriorado, por lo cual se suspende su uso y se informa a familiar.
PENDIENTES:
• Pendiente orden laboratorio (nutricionista Amauri Villalba)
• Control con médico del dolor en 6 meses (junio)
• Control con neurología
• Pendiente visita domiciliaria médico general (marzo)
• Pendiente visita domiciliaria jefe de ruta
• Pendiente cita con odontología
• Pendiente fisiatría (pérdida por transporte)
• Pendiente cita con psiquiatría
• Pendiente cita psicología (mayo)
• Pendiente terapias fisioterapia
• Pendiente terapia ocupacional
• Pendiente fonoaudiología
ALÉRGICOS: Dipirona
TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
(Según orden médica, sin cambios)
LÍQUIDOS ADMINISTRADOS Y ELIMINADOS:
Elimina (++)
Deposición (+)
ACTIVIDADES DE ENFERMERÍA REALIZADAS DURANTE EL TURNO:
• Asistencia en alimentación (desayuno y almuerzo vía oral)
• Cambios de posición frecuentes
• Hidratación de piel con crema Lubriderm
• Uso de almohadas para soporte
• Cambio de pañal y aseo genital según necesidad
• Higiene general del paciente
• Terapia con pelota en miembros superiores e inferiores
• Se realizó aseo general de las áreas asignadas, incluyendo limpieza completa del baño
• Se brindó cuidado facial, masajes suaves y cortos en miembros inferiores y superiores, se realizó corte de uñas a la paciente
• Se realizaron actividades lúdicas acordes al estado de la paciente, con adecuada tolerancia

ENTREGA:
Entrega: Aux. Astrid Herrera
Recibe: Aux. Amparo

Astrid Carolina Herrera

HERRERA SILVA ASTRID CAROLINA

29/03/2026 19:00

Con previo lavado de manos y EPP,Recibo paciente adulto mayor femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: Encefalopatia hipoxica
*crisis epilépticas

Amparo G.
B. Amparo. Garcia. C.
Auxiliar de Enfermeria
CC. 50317067
Reg 81-2005

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

GARCIA CARDENAS BLANCA AMPARO

*cuadriplejia flácida *polineuropatia no especificada
*hipertensión esencial, *incontinencia urinaria, no especificada
*constipación
*fractura de pelvis (resuelta) *fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso
*Transtorno mixto de ansiedad y depresión

ANTECEDENTE PATOLOGICO PERSONALES :
*secuelas post covid 19, *hipertensión arterial esencial primaria, *encefalopatía hipoxemica apraxia verbal
*síndrome de movilidad reducida.

VALORACION CEFALOCAUDAL:se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara con olor fuerte , extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).pte desorientada en tiempo,lugar,espacio,Glasgow 14/15,afebril,pte alerta al llamado,lenguaje incoherente
Pte en domicilio con cama hospitalaria con barandas elevadas en compañía del familiar,hija Carmen Ramírez,Cuñado José,esposo Carlos omar.

OBSERVACIONES:
• Dentro del domicilio Se observa hace tiempo material mecánicos, a fuera llenos de polvo y mugre.(a Jefe de ruta ordeno cerrar las ventan que va directo del paciente).
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)
• Pendiente terapias fisioterapeuta
• pendiente terapias ocupacional
•Pendiente terapias fonoaudiologo

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50 pm un a dosis adicional por orden médica
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (+)
Deposición (-)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS DEL TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal.

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

terapia con la pelota ejercicios en miembros superiores e inferiores.
SIGNOS VITALES:
TA: 105/73mm/Hg
FC: 75x'
FR: 16x'
SPO2:97%
T:36.5°C

30/03/2026 01:00 pte continúa dormida tranquila

GARCIA CARDENAS BLANCA AMPARO

30/03/2026 02:00 se realiza cambio deposición en decúbito lateral derecho y se lubrica piel

GARCIA CARDENAS BLANCA AMPARO

30/03/2026 03:00 pte continúa dormida tranquila

GARCIA CARDENAS BLANCA AMPARO

30/03/2026 04:00 se realiza cambio de posición en decúbito lateral izquierdo y se lubrica piel

GARCIA CARDENAS BLANCA AMPARO

30/03/2026 05:00 Con previo lavado de manos, uso de epp y cumpliendo los 15 correctos (1 Realizar higiene de manos, 2 Indagar antecedentes alérgicos correctos,3 Toma de signos vitales, Medicamento correcto,5 Dosis correcta,6 Vía administración correcta,7 Hora correcta,8 Pte correcto, 9 Técnica administración correcta,10 Velocidad de infusión correcta,11 Verificar fecha de caducidad, 12 Prepare y administre usted mismo el medicamento,13 Realice usted mismo el registro de los medicamentos después de administrar,14 No administrar medicamento bajo orden verbal,15 Educar al familiar y el pte sobre el medicamento que se administro)se administra 1 capsula de acido valproico x250mg vo

GARCIA CARDENAS BLANCA AMPARO

30/03/2026 05:00 se administra medicamento ordenado por vo,
• pte despierta tranquila
• se realiza higiene en genitales,se aplica crema y cambio de pañal

GARCIA CARDENAS BLANCA AMPARO

30/03/2026 06:00 se realiza cambio de posición en decúbito supino y se lubrica piel
• pte despierta tranquila

GARCIA CARDENAS BLANCA AMPARO

30/03/2026 07:00 pte se observa somnolienta,tranquila
• se toma signos vitales y se registra
• pte paso buena noche sin novedad

GARCIA CARDENAS BLANCA AMPARO

30/03/2026 07:00 Con previo lavado de manos y EPP, Queda paciente adulto mayor femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: Encefalopatia hipoxica
*crisis epilépticas
*cuadriplejia flácida *polineuropatia no especificada
*hipertensión esencial, *incontinencia urinaria, no especificada
*constipación

GARCIA CARDENAS BLANCA AMPARO

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

*fractura de pelvis (resuelta) *fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso
*Transtorno mixto de ansiedad y depresión

ANTECEDENTE PATOLOGICO PERSONALES :
*secuelas post covid 19, *hipertensión arterial esencial primaria, *encefalopatía hipoxemica apraxia verbal
*síndrome de movilidad reducida.

VALORACION CEFALOCAUDAL:se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara con olor fuerte , extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).pte desorientada en tiempo,lugar,espacio,Glasgow 14/15,afebril,pte alerta al llamado,lenguaje incoherente
Pte en domicilio con cama hospitalaria con barandas elevadas en compañía del familiar,hija Carmen Ramírez,Cuñado José,esposo Carlos omar.

OBSERVACIONES:
• Dentro del domicilio Se observa hace tiempo material mecánicos, a fuera llenos de polvo y mugre.(a Jefe de ruta ordeno cerrar las ventan que va directo del paciente).
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)
• Pendiente terapias fisioterapeuta
• pendiente terapias ocupacional
•Pendiente terapias fonoaudiologo

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50 pm un a dosis adicional por orden médica
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (+)
Deposición (+)poca cantidad

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS DEL TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal.
terapia con la pelota ejercicios en miembros superiores e inferiores.
SIGNOS VITALES:
TA: 103/72mm/Hg
FC: 72x'
FR: 16x'

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

30/03/2026 07:00

SPO2:96 %
T:36.4°C

Recibo paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: Encefalopatia hipoxica,crisis epilépticas, cuadriplejia flácida y polineuropatia no especificada, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable tranquila presenta pequeños hematomas en miembros inferiores y superiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en cama hospitlaria posición decubito supino colchón antiescaras ,paciente en el programa de atención domiciliaria con barandas de seguridad elevadas en posición decúbito supino.

Paciente estable desorientada en las 3 esferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara con olor fuerte , extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO:
Paciente se mantiene dormida. Durante el turno paciente Tolera adecuadamente la vía oral para la administración de medicamentos. Concilio sueño temprano.

OBSERVACIONES
• Dentro del domicilio Se observa hace tiempo material mecánicos, a fuera llenos de polvo y mugre.(a Jefe de ruta ordeno cerrar las ventan que va directo del paciente).
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.
•Se evidencia que la grúa de movilización presenta fallas en su funcionamiento, también se observa que el chaleco (arnés)
Utilizado para la movilización de la paciente se encuentra deteriorado.(presenta desgaste en sus sujeciones) Por lo tanto requiere mantenimiento, se decide suspender su uso apartir de la fecha

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)
• Pendiente terapias fisioterapeuta
• pendiente terapias ocupacional
•Pendiente terapias fonoaudiologo

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50 pm un a dosis adicional por orden médica

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (++)
Deposición (+)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral(cena)
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal.
terapia con la pelota ejercicios en miembros superiores e inferiores.
Recibe Aux- Adriana Beltrán
Entrega Aux- Amparo Garcia

30/03/2026 07:11 Se realiza higiene bucal con cepillo electrico y crema colgate y agua.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

30/03/2026 08:00 Se administra tableta losartan 50mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

30/03/2026 08:10 Se administra tableta Esomeprazol 20mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

30/03/2026 08:20 Se administra capsula Amantadina 100mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

30/03/2026 08:30 Se administra tableta Citicolina 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

30/03/2026 09:41 Se brinda asistencia al paciente durante el desayuno con dieta sólida, permitiendo el tiempo necesario para la masticación y deglución de cada bocado. Paciente tolera adecuadamente

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

30/03/2026 09:43 Se realiza higiene bucal al paciente con cepillo eléctrico, efectuando limpieza de cavidad oral. Paciente tolera el procedimiento adecuadamente

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

30/03/2026 11:30 Se administra tableta Ácido acetilsalicílico 100mg vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

30/03/2026 12:00 se realiza cambio deposición y decúbito lateral izquierdo y se lubrica piel

GARCIA CARDENAS BLANCA AMPARO

30/03/2026 13:00 Se administra Acido valproico 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

30/03/2026 13:53 Se brinda asistencia durante de almuerzo con dieta sólida, permitiendo tiempo para adecuada masticación y deglución. Paciente tolera adecuadamente.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

30/03/2026 13:55 Después del almuerzo se administra jarabe Escitalopram en solución oral, 20 cc, según indicación médica(psiquiatra) Tolera la administración por vía oral sin complicaciones, sin presencia de náuseas ni vómito, Paciente tranquila.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

30/03/2026 14:48 Se realiza higiene bucal al paciente con cepillo eléctrico, efectuando limpieza de cavidad oral. Paciente tolera el procedimiento adecuadamente

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

30/03/2026 15:15 Se informa que el familiar de la paciente, Carmen Elena Ramírez, refiere haber enviado a reparar el chaleco (arnés) de la grúa; sin embargo, la grúa continúa presentando fallas mecánicas pendientes de reparación. A pesar de ello, el familiar autoriza y solicita realizar el baño de la paciente utilizando dicho equipo

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

30/03/2026 15:30 Por indicación del familiar, la auxiliar de enfermería de turno realiza traslado de la paciente con apoyo de grúa hacia la silla poceta. Posteriormente se lleva a cabo baño general, aplicando shampoo en cuero cabelludo con posterior enjuague; se realiza higiene corporal con jabón líquido y se efectúa enjuague y secado completo de la piel.
Finalizado el aseo, la paciente es trasladada nuevamente a la cama hospitalaria con apoyo de grúa. Se realiza secado cuidadoso de región genital y glútea, aplicando crema con nistatina y crema Almipro (óxido de zinc). Se coloca pañal limpio y se viste a la paciente con pijama y adecuada.
Durante el procedimiento, la paciente presenta episodios de nerviosismo, los cuales son manejados con acompañamiento y vigilancia durante la actividad.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

30/03/2026 16:45 Se realiza cambio de posición a decúbito lateral derecho, colocando almohadas de soporte en región dorsal y entre miembros inferiores para favorecer alineación corporal y confort del paciente. Durante el procedimiento, paciente presenta episodio de nerviosismo.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

30/03/2026 18:00 Se realiza cambio de pañal. Se aplica crema antipañalitis Instacalm (nistatina + óxido de zinc) y crema Almipro (óxido de zinc) en región glútea, con el fin de prevenir y tratar irritación por pañal. Paciente tolera el procedimiento sin complicaciones

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

30/03/2026 19:00

Entrego paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: Encefalopatia hipoxica,crisis epilépticas, cuadriplejia flácida y polineuropatia no especificada, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable tranquila presenta pequeños hematomas en miembros inferiores y superiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en cama hospitlaria posición decubito supino colchón antiescaras ,paciente en el programa de atención domiciliaria con barandas de seguridad elevadas en posición Fowler.

Paciente estable desorientada en las 3 esferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara con olor fuerte , extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO:
Paciente se mantiene despierta. Durante el turno paciente Tolera adecuadamente la vía oral para la administración de medicamentos. Se realizo los cambios de posicion.

OBSERVACIONES
• Dentro del domicilio Se observa hace tiempo material mecánicos, a fuera llenos de polvo y mugre.(a Jefe de ruta ordeno cerrar las ventan que va directo del paciente).
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.
•Se evidencia que la grúa de movilización presenta fallas en su funcionamiento,
Utilizado para la movilización de la paciente se encuentra deteriorado.(presenta desgaste en sus sujeciones) Por lo tanto requiere mantenimiento, se decide suspender su uso apartir de la fecha

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)
• Pendiente terapias fisioterapeuta
• pendiente terapias ocupacional
•Pendiente terapias fonoaudiologo

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50 pm un a dosis adicional por orden médica
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (++)
Deposición (+)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral(desayuno, almuerzo)
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal.
terapia con la pelota ejercicios en miembros superiores e inferiores.
Entrega Aux- Adriana Beltrán
Recibe Aux- Astrid Herrera

30/03/2026 19:00

Recibo paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: Encefalopatia hipoxica,crisis epilépticas, cuadriplejia flácida y polineuropatia no especificada, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable tranquila presenta pequeños hematomas en miembros inferiores y superiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en cama hospitlaria posición decubito supino colchón antiescaras ,paciente en el programa de atención domiciliaria con barandas de seguridad elevadas en posición Fowler.

Paciente estable desorientada en las 3 esferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara con olor fuerte , extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

Astrid Carolina Herrera

HERRERA SILVA ASTRID CAROLINA

30/03/2026 19:30

se suministró el cena a la paciente dieta sólida [luz Belén], quien se encuentra en cama. Se verificó que la paciente toleró adecuadamente los alimentos, sin signos de disfagia ni malestar.

Astrid Carolina Herrera

HERRERA SILVA ASTRID CAROLINA

30/03/2026 20:00

Con previo lavado de manos, uso de epp y cumpliendo los 15 correctos (1 Realizar higiene de manos, 2 Indagar antecedentes alérgicos correctos,3 Toma de signos vitales, Medicamento correcto,5 Dosis correcta,6 Vía administración correcta,7 Hora correcta,8 Pte correcto, 9 Técnica administración correcta,10 Velocidad de infusión correcta,11 Verificar fecha de caducidad, 12 Prepare y administre usted mismo el medicamento,13 Realice usted mismo el registro de los medicamentos después de administrar,14 No administrar medicamento bajo orden verbal,15 Educar al familiar y el pte sobre el medicamento que se administro)se administra 1 tableta de Losartan x50mg vo

Amparo G.
B. Amparo. Garcia. C.
Auxiliar de Enfermeria
CC. 50311067
Reg 5.1-3955

GARCIA CARDENAS BLANCA AMPARO

30/03/2026 20:00

se administra medicamento ordenado por vo
• se toma signos vitales y se registra
•se realiza cambio deposición en decúbito lateral izquierdo y se lubrica piel
•recibe y tolera dieta ordenado vo sin novedad

Amparo G.
B. Amparo. Garcia. C.
Auxiliar de Enfermeria
CC. 50311067
Reg 5.1-3955

GARCIA CARDENAS BLANCA AMPARO

30/03/2026 20:05

Se administra tableta losartan 50mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

HERRERA SILVA ASTRID CAROLINA

30/03/2026 20:20 Se administra capsula Amantadina 100mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

HERRERA SILVA ASTRID CAROLINA

30/03/2026 20:20 Con previo lavado de manos, uso de epp y cumpliendo los 15 correctos (1 Realizar higiene de manos, 2 Indagar antecedentes alérgicos correctos,3 Toma de signos vitales, Medicamento correcto,5 Dosis correcta,6 Vía administración correcta,7 Hora correcta,8 Pte correcto, 9 Técnica administración correcta,10 Velocidad de infusión correcta,11 Verificar fecha de caducidad, 12 Prepare y administre usted mismo el medicamento,13 Realice usted mismo el registro de los medicamentos después de administrar,14 No administrar medicamento bajo orden verbal,15 Educar al familiar y el pte sobre el medicamento que se administro)se administra 1 tableta de amantadina x100mg vo

GARCIA CARDENAS BLANCA AMPARO

30/03/2026 20:20 se administra medicamento ordenada por vo
• pte viendo television

GARCIA CARDENAS BLANCA AMPARO

30/03/2026 20:30 se administra medicamento ordenado por vo

GARCIA CARDENAS BLANCA AMPARO

30/03/2026 20:30 Con previo lavado de manos, uso de epp y cumpliendo los 15 correctos (1 Realizar higiene de manos, 2 Indagar antecedentes alérgicos correctos,3 Toma de signos vitales, Medicamento correcto,5 Dosis correcta,6 Vía administración correcta,7 Hora correcta,8 Pte correcto, 9 Técnica administración correcta,10 Velocidad de infusión correcta,11 Verificar fecha de caducidad, 12 Prepare y administre usted mismo el medicamento,13 Realice usted mismo el registro de los medicamentos después de administrar,14 No administrar medicamento bajo orden verbal,15 Educar al familiar y el pte sobre el medicamento que se administro)se administra 1 tableta de citicolina x250mg vo

GARCIA CARDENAS BLANCA AMPARO

30/03/2026 20:30 Se administra tableta Citicolina 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

HERRERA SILVA ASTRID CAROLINA

30/03/2026 20:50 Se administra dos cápsulas de Ácido valproico 500mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

HERRERA SILVA ASTRID CAROLINA

30/03/2026 20:50 Con previo lavado de manos, uso de epp y cumpliendo los 15 correctos (1 Realizar higiene de manos, 2 Indagar antecedentes alérgicos correctos,3 Toma de signos vitales, Medicamento correcto,5 Dosis correcta,6 Vía administración correcta,7 Hora correcta,8 Pte correcto, 9 Técnica administración correcta,10 Velocidad de infusión correcta,11 Verificar fecha de caducidad, 12 Prepare y administre usted mismo el medicamento,13 Realice usted mismo el registro de los medicamentos después de administrar,14 No administrar medicamento bajo orden verbal,15 Educar al familiar y el pte sobre el medicamento que se administro)se administra 2 capsula de acido valproico x250mg vo

GARCIA CARDENAS BLANCA AMPARO

30/03/2026 20:50 se administra medicamento ordenado por vo

GARCIA CARDENAS BLANCA AMPARO

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

30/03/2026 21:00 Se administra Quetiapina 200mg, mas dos tabletas Quetiapina 25mg un total administrados 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones

HERRERA SILVA ASTRID CAROLINA

30/03/2026 21:00 Con previo lavado de manos, uso de epp y cumpliendo los 15 correctos (1 Realizar higiene de manos, 2 Indagar antecedentes alérgicos correctos,3 Toma de signos vitales, Medicamento correcto,5 Dosis correcta,6 Vía administración correcta,7 Hora correcta,8 Pte correcto, 9 Técnica administración correcta,10 Velocidad de infusión correcta,11 Verificar fecha de caducidad, 12 Prepare y administre usted mismo el medicamento,13 Realice usted mismo el registro de los medicamentos después de administrar,14 No administrar medicamento bajo orden verbal,15 Educar al familiar y el pte sobre el medicamento que se administro)se administra 1 tableta de quetiapinax200mg+2 tabletas
de quetiapina X25 MG vo (250 mg noche)

GARCIA CARDENAS BLANCA AMPARO

30/03/2026 21:00 se administra medicamento ordenado por vo
• pte continúa viendo television

GARCIA CARDENAS BLANCA AMPARO

30/03/2026 21:45 Se realiza cambio de posición: cúbito dorsal, con el fin de favorecer el confort de la paciente y prevenir lesiones por presión. Paciente queda en posición adecuada, cómoda y con tolerancia al procedimiento.

HERRERA SILVA ASTRID CAROLINA

30/03/2026 22:00 se realiza cambio de pañal,se aplica crema
• se realiza cambio deposición en decúbito lateral derecho y se lubrica piel

GARCIA CARDENAS BLANCA AMPARO

30/03/2026 23:00 pte somnolienta,tranquila

GARCIA CARDENAS BLANCA AMPARO

30/03/2026 23:15 Se realizó cambio de pañal: se retira pañal desechable, procedimiento de limpieza de la región perineal con solución adecuada y material estéril.
Se aplica crema protectora en la zona perineal para prevenir irritación o dermatitis por contacto con la orina.
Paciente quedó confortable, con la piel limpia e integral

HERRERA SILVA ASTRID CAROLINA

31/03/2026 00:23 Se realiza cambio de posición: cúbito lateral izquierdo, con el fin de favorecer el confort de la paciente y prevenir lesiones por presión. Paciente queda en posición adecuada, cómoda y con tolerancia al procedimiento.

HERRERA SILVA ASTRID CAROLINA

31/03/2026 02:40 Se realiza cambio de posición: cúbito dorsal, con el fin de favorecer el confort de la paciente y prevenir lesiones por presión. Paciente queda en posición adecuada, cómoda y con tolerancia al procedimiento.

HERRERA SILVA ASTRID CAROLINA

31/03/2026 05:00 Se administra Acido valproico 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

HERRERA SILVA ASTRID CAROLINA

31/03/2026 05:10

Se realizó cambio de pañal: se retira pañal desechable, procedimiento de limpieza de la región perineal con solución adecuada y material estéril.
Se aplica crema protectora en la zona perineal para prevenir irritación o dermatitis por contacto con la orina.
Paciente quedó confortable, con la piel limpia e integral

HERRERA SILVA ASTRID CAROLINA

31/03/2026 05:20

Se realiza cambio de posición: Semi Fowler, con el fin de favorecer el confort de la paciente y prevenir lesiones por presión. Paciente queda en posición adecuada, cómoda y con tolerancia al procedimiento.

HERRERA SILVA ASTRID CAROLINA

31/03/2026 07:00

Con previo lavado de manos y EPP,Recibo paciente adulto mayor femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: Encefalopatia hipoxica
*crisis epilépticas
*cuadriplejia flácida *polineuropatia no especificada
*hipertensión esencial, *incontinencia urinaria, no especificada
*constipación
*fractura de pelvis (resuelta) *fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso
*Transtorno mixto de ansiedad y depresión

ANTECEDENTE PATOLOGICO PERSONALES :
*secuelas post covid 19, *hipertensión arterial esencial primaria, *encefalopatía hipoxemica apraxia verbal
*síndrome de movilidad reducida.

VALORACION CEFALOCAUDAL:se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara con olor fuerte , extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).pte desorientada en tiempo,lugar,espacio,Glasgow 14/15,afebril,pte alerta al llamado,lenguaje incoherente
Pte en domicilio con cama hospitalaria con barandas elevadas en compañía del familiar,hija Carmen Ramírez,Cuñado, Carlos omar,sr Jose

OBSERVACIONES:
• Dentro del domicilio Se observa hace tiempo material mecánicos, a fuera llenos de polvo y mugre.(a Jefe de ruta ordeno cerrar las ventan que va directo del paciente).
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)
• Pendiente terapias fisioterapeuta
• pendiente terapias ocupacional
•Pendiente terapias fonoaudiologo

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera

B. Amparo. Garcia. C.
Auxiliar de Enfermeria
CC. 50911767
Reg 81-3955

GARCIA CARDENAS BLANCA AMPARO

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50 pm un a dosis adicional por orden médica
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (+)
Deposición (-)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS DEL TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal.
terapia con la pelota ejercicios en miembros superiores e inferiores.
SIGNOS VITALES:
TA: 100/73mm/Hg
FC: 77x'
FR: 16x'
SPO2:97%
T:36.4°C

31/03/2026 07:00

Entrego paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: Encefalopatia hipoxica,crisis epilépticas, cuadriplejia flácida y polineuropatia no especificada, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

Astrid Carolina Herrera

HERRERA SILVA ASTRID CAROLINA

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable tranquila presenta pequeños hematomas en miembros inferiores y superiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en cama hospitlaria posición decubito supino colchón antiescaras ,paciente en el programa de atención domiciliaria con barandas de seguridad elevadas en posición Fowler.

Paciente estable desorientada en las 3 esferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara con olor fuerte , extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO:
Paciente se mantiene tranquila y dormida Durante el turno paciente. Tolera adecuadamente la vía oral para la administración de medicamentos. Se realizo los cambios de posicion, y cambio de pañal.

OBSERVACIONES
• Dentro del domicilio Se observa hace tiempo material mecánicos, a fuera llenos de polvo y mugre.(a Jefe de ruta ordeno cerrar las ventan que va directo del paciente).
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.
•Se evidencia que la grúa de movilización presenta fallas en su funcionamiento,
Utilizado para la movilización de la paciente se encuentra deteriorado.(presenta desgaste en sus sujeciones) Por lo tanto requiere mantenimiento, se decide suspender su uso apartir de la fecha

PENDIENTES:

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)
• Pendiente terapias fisioterapeuta
• pendiente terapias ocupacional
•Pendiente terapias fonoaudiologo

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50 pm un a dosis adicional por orden médica
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (++)
Deposición (-)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral(cena)
•Realizar cambios de posiciones, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente.
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal (lavado de boca)

Entrega Aux- Astrid Herrera
Recibe Aux- Amparo García

31/03/2026 07:30 se desviste paciente,se coloca la prenda para la grúa,se levanta pte de la cama en grua y. se sienta en silla de pato,se lleva pte al baño y se realiza baño general con jabón y abundante agua,se seca,se lleva pte Serca de la cama y se coloca la grúa para acostarla,se lubrica piel,se aplica crema en genitales,se coloca pañal,se viste,se deja comoda

Amparo G.
B.Amparo. Garcia.C.
Auxiliar de Enfermeria
CC.- 60317067
Reg 8.1-3955

GARCIA CARDENAS BLANCA AMPARO

31/03/2026 08:00 se administra medicamento ordenado por vo
*recibe y tolera desayuno vo sin novedad

Amparo G.
B.Amparo. Garcia.C.
Auxiliar de Enfermeria
CC.- 60317067
Reg 8.1-3955

GARCIA CARDENAS BLANCA AMPARO

31/03/2026 08:00 Con previo lavado de manos, uso de epp y cumpliendo los 15 correctos (1 Realizar higiene de manos, 2 Indagar antecedentes alérgicos correctos,3 Toma de signos vitales, Medicamento correcto,5 Dosis correcta,6 Vía administración correcta,7 Hora correcta,8 Pte correcto, 9 Técnica administración correcta,10 Velocidad de infusión correcta,11 Verificar fecha de caducidad, 12 Prepare y administre usted mismo el medicamento,13 Realice usted mismo el registro de los medicamentos después de administrar,14 No administrar medicamento bajo orden verbal,15 Educar al familiar y el pte sobre el medicamento que se administro)se administra 1 tableta de Losartan x50mg vo

Amparo G.
B.Amparo. Garcia.C.
Auxiliar de Enfermeria
CC.- 60317067
Reg 8.1-3955

GARCIA CARDENAS BLANCA AMPARO

31/03/2026 08:10 se administra medicamento ordenado por vo

Amparo G.
B.Amparo. Garcia.C.
Auxiliar de Enfermeria
CC.- 60317067
Reg 8.1-3955

GARCIA CARDENAS BLANCA AMPARO

31/03/2026 08:10 Con previo lavado de manos, uso de epp y cumpliendo los 15 correctos (1 Realizar higiene de manos, 2 Indagar antecedentes alérgicos correctos,3 Toma de signos vitales, Medicamento correcto,5 Dosis correcta,6 Vía administración correcta,7 Hora correcta,8 Pte correcto, 9 Técnica administración correcta,10 Velocidad de infusión correcta,11 Verificar

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

fecha de caducidad, 12 Prepare y administre usted mismo el medicamento,13 Realice usted mismo el registro de los medicamentos después de administrar,14 No administrar medicamento bajo orden verbal,15 Educar al familiar y el pte sobre el medicamento que se administro)se administra 1 tableta de esomeprazol x20mg vo

GARCIA CARDENAS BLANCA AMPARO

31/03/2026 08:20 se administra medicamento ordenado por vo

GARCIA CARDENAS BLANCA AMPARO

31/03/2026 08:20 Con previo lavado de manos, uso de epp y cumpliendo los 15 correctos (1 Realizar higiene de manos, 2 Indagar antecedentes alérgicos correctos,3 Toma de signos vitales, Medicamento correcto,5 Dosis correcta,6 Vía administración correcta,7 Hora correcta,8 Pte correcto, 9 Técnica administración correcta,10 Velocidad de infusión correcta,11 Verificar fecha de caducidad, 12 Prepare y administre usted mismo el medicamento,13 Realice usted mismo el registro de los medicamentos después de administrar,14 No administrar medicamento bajo orden verbal,15 Educar al familiar y el pte sobre el medicamento que se administro)se administra 1 tableta de amantadina x100mg vo

GARCIA CARDENAS BLANCA AMPARO

31/03/2026 08:30 Con previo lavado de manos, uso de epp y cumpliendo los 15 correctos (1 Realizar higiene de manos, 2 Indagar antecedentes alérgicos correctos,3 Toma de signos vitales, Medicamento correcto,5 Dosis correcta,6 Vía administración correcta,7 Hora correcta,8 Pte correcto, 9 Técnica administración correcta,10 Velocidad de infusión correcta,11 Verificar fecha de caducidad, 12 Prepare y administre usted mismo el medicamento,13 Realice usted mismo el registro de los medicamentos después de administrar,14 No administrar medicamento bajo orden verbal,15 Educar al familiar y el pte sobre el medicamento que se administro)se administra 1 tableta de citicolina x250mg vo

GARCIA CARDENAS BLANCA AMPARO

31/03/2026 08:30 se administra medicamento ordenado por vo
*Ingresa al Domicilio con previo lavado de manos y utilizando elementos de protección personal Fisioterapeuta Andrés Rodríguez (particular)quién realiza terapia física,con grua,karo en MII más arnés deambula en la sala por 40',luego la colocas en la cama,retira arnés,queda cómoda en cama

GARCIA CARDENAS BLANCA AMPARO

31/03/2026 09:00 pte duerme tranquila,sin novedad

GARCIA CARDENAS BLANCA AMPARO

31/03/2026 10:00 se realiza cambio deposición en decúbito lateral izquierdo y se lubrica piel
*pte viendo television

GARCIA CARDENAS BLANCA AMPARO

31/03/2026 11:00 pte viendo televisión,se observa tranquila

GARCIA CARDENAS BLANCA AMPARO

31/03/2026 11:30 Con previo lavado de manos, uso de epp y cumpliendo los 15 correctos (1 Realizar higiene de manos, 2 Indagar antecedentes alérgicos correctos,3 Toma de signos vitales, Medicamento correcto,5 Dosis correcta,6 Vía administración correcta,7 Hora correcta,8 Pte correcto, 9 Técnica administración correcta,10 Velocidad de infusión correcta,11 Verificar fecha de caducidad, 12 Prepare y administre usted mismo el medicamento,13 Realice usted mismo el registro de los medicamentos después de administrar,14 No administrar medicamento bajo orden verbal,15 Educar al familiar y el pte sobre el medicamento que se administro)se administra 1 tableta de asa x100mg vo

GARCIA CARDENAS BLANCA AMPARO

31/03/2026 11:33 se administra medicamento ordenado por vo

GARCIA CARDENAS BLANCA AMPARO

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

31/03/2026 12:00 se realiza cambio deposición en decúbito lateral derecho y se lubrica piel

GARCIA CARDENAS BLANCA AMPARO

31/03/2026 12:45 Con previo lavado de manos, uso de epp y cumpliendo los 15 correctos (1 Realizar higiene de manos, 2 Indagar antecedentes alérgicos correctos,3 Toma de signos vitales, Medicamento correcto,5 Dosis correcta,6 Vía administración correcta,7 Hora correcta,8 Pte correcto, 9 Técnica administración correcta,10 Velocidad de infusión correcta,11 Verificar fecha de caducidad, 12 Prepare y administre usted mismo el medicamento,13 Realice usted mismo el registro de los medicamentos después de administrar,14 No administrar medicamento bajo orden verbal,15 Educar al familiar y el pte sobre el medicamento que se administro)se administra 20cc de escitalipram (bruliva) 120ml vo

GARCIA CARDENAS BLANCA AMPARO

31/03/2026 12:50 recibe y tolera dieta ordenada por vo
*se administra medicamento ordenado por vo

GARCIA CARDENAS BLANCA AMPARO

31/03/2026 13:00 Con previo lavado de manos, uso de epp y cumpliendo los 15 correctos (1 Realizar higiene de manos, 2 Indagar antecedentes alérgicos correctos,3 Toma de signos vitales, Medicamento correcto,5 Dosis correcta,6 Vía administración correcta,7 Hora correcta,8 Pte correcto, 9 Técnica administración correcta,10 Velocidad de infusión correcta,11 Verificar fecha de caducidad, 12 Prepare y administre usted mismo el medicamento,13 Realice usted mismo el registro de los medicamentos después de administrar,14 No administrar medicamento bajo orden verbal,15 Educar al familiar y el pte sobre el medicamento que se administro)se administra 1 capsula de acido valproico x250mg vo

GARCIA CARDENAS BLANCA AMPARO

31/03/2026 13:10 Con previo lavado de manos, uso de epp y cumpliendo los 15 correctos (1 Realizar higiene de manos, 2 Indagar antecedentes alérgicos correctos,3 Toma de signos vitales, Medicamento correcto,5 Dosis correcta,6 Vía administración correcta,7 Hora correcta,8 Pte correcto, 9 Técnica administración correcta,10 Velocidad de infusión correcta,11 Verificar fecha de caducidad, 12 Prepare y administre usted mismo el medicamento,13 Realice usted mismo el registro de los medicamentos después de administrar,14 No administrar medicamento bajo orden verbal,15 Educar al familiar y el pte sobre el medicamento que se administro)se administra 20cc de escitalipram (bruliva) 120ml vo

GARCIA CARDENAS BLANCA AMPARO

31/03/2026 14:00 se realiza cambio deposición en decúbito supino y se lubrica piel

GARCIA CARDENAS BLANCA AMPARO

31/03/2026 15:00 recibe y tolera una dona más agua vo sin novedad

GARCIA CARDENAS BLANCA AMPARO

31/03/2026 16:00 se realiza cambio deposición en decúbito lateral derecho y se lubrica piel
*se toma signos vitales y se registra

GARCIA CARDENAS BLANCA AMPARO

31/03/2026 17:00 recibe y tolera un pastel de pollo más un vaso de Coca-Cola vo sin novedad
*pte viendo television

GARCIA CARDENAS BLANCA AMPARO

31/03/2026 18:00 se realiza cambio deposición decúbito lateral derecho y se lubrica piel
*pte viendo televisión
*con previo lavado de manos y epp se realiza higiene en genitales con jabón y agua se aplica crema y cambio de pañal

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

GARCIA CARDENAS BLANCA AMPARO

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

31/03/2026 19:00

Recibo paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: Encefalopatia hipoxica,crisis epilépticas, cuadriplejia flácida y polineuropatia no especificada, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable tranquila presenta pequeños hematomas en miembros inferiores y superiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en cama hospitlaria posición decubito supino colchón antiescaras ,paciente en el programa de atención domiciliaria con barandas de seguridad elevadas en posición lateral derecho.

Paciente estable desorientada en las 3 esferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara con olor fuerte , extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO:
Paciente se mantiene despierta. Durante el turno paciente Tolera adecuadamente la vía oral para la administración de medicamentos. Se realizo los cambios de posicion.

OBSERVACIONES
• Dentro del domicilio Se observa hace tiempo material mecánicos, a fuera llenos de polvo y mugre.(a Jefe de ruta ordeno cerrar las ventan que va directo del paciente).
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.
•Se evidencia que la grúa de movilización presenta fallas en su funcionamiento,
Utilizado para la movilización de la paciente se encuentra deteriorado.(presenta desgaste en sus sujeciones) Por lo tanto requiere mantenimiento, se decide suspender su uso apartir de la fecha

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)
• Pendiente terapias fisioterapeuta
• pendiente terapias ocupacional
•Pendiente terapias fonoaudiologo

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50 pm un a dosis adicional por orden médica
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (++)
Deposición (-)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral(desayuno, almuerzo)
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal.
terapia con la pelota ejercicios en miembros superiores e inferiores.
Recibe Aux- Adriana Beltrán
Entrega Aux- Amparo Garcia

31/03/2026 19:00

Con previo lavado de manos y EPP, Queda paciente adulto mayor femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: Encefalopatia hipoxica
*crisis epilépticas
*cuadriplejia flácida *polineuropatia no especificada
*hipertensión esencial, *incontinencia urinaria, no especificada
*constipación
*fractura de pelvis (resuelta) *fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso
*Transtorno mixto de ansiedad y depresión

Amparo G.
B. Amparo. Garcia. C.
Auxiliar de Enfermeria
CC. 60317067
Reg 6.1-3966

GARCIA CARDENAS BLANCA AMPARO

ANTECEDENTE PATOLOGICO PERSONALES :
*secuelas post covid 19, *hipertensión arterial esencial primaria, *encefalopatía hipoxemica apraxia verbal
*síndrome de movilidad reducida.

VALORACION CEFALOCAUDAL:se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara con olor fuerte , extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).pte desorientada en tiempo,lugar,espacio,Glasgow 14/15,afebril,pte alerta al llamado,lenguaje incoherente
Pte en domicilio con cama hospitalaria con barandas elevadas en compañía del familiar,hija Carmen Ramírez,Cuñado José,esposo Carlos omar.

OBSERVACIONES:
• Dentro del domicilio Se observa hace tiempo material mecánicos, a fuera llenos de polvo y mugre.(a Jefe de ruta ordeno cerrar las ventan que va directo del paciente).
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)
• Pendiente terapias fisioterapeuta
• pendiente terapias ocupacional
•Pendiente terapias fonoaudiologo

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50 pm un a dosis adicional por orden médica
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (+)
Deposición (-)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS DEL TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal.
terapia con la pelota ejercicios en miembros superiores e inferiores.
•se a compañía en la terapia con el Dr fisioterapeutica Andrés sin novedad
SIGNOS VITALES:
TA: 100/70mm/Hg
FC: 80x'
FR: 16x'
SPO2:95 %
T:36.2°C

31/03/2026 19:16 Se retira ropa de vestir y se realiza lubricación de la piel con crema corporal. Posteriormente, se coloca bata limpia y seca, paciente estable con ropa limpia piel hidratada.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

31/03/2026 20:00 Se administra tableta losartan 50mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

31/03/2026 20:15 Se brinda asistencia al paciente durante la cena con dieta sólida, permitiendo el tiempo necesario para la masticación y deglución de cada bocado. Paciente tolera adecuadamente

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

31/03/2026 20:20 Se administra capsula Amantadina 100mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

31/03/2026 20:30 Se administra tableta Citicolina 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

31/03/2026 20:50 Se administra dos cápsulas de Ácido valproico 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

31/03/2026 21:00 Se administra Quetiapina 200mg, mas dos tabletas Quetiapina 25mg un total administrados 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

31/03/2026 21:27	Se realiza revisión y organización de los medicamentos correspondientes al mes de abril. Se verifica nombre del medicamento, dosis, horario de administración y fecha de vencimiento. Los medicamentos quedan organizados en su respectivo pastillero para facilitar su administración diaria. Paciente queda con tratamiento disponible según indicación médic	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
31/03/2026 22:35	Se realiza higiene bucal al paciente con cepillo eléctrico, efectuando limpieza de cavidad oral. Paciente tolera el procedimiento adecuadamente	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
31/03/2026 22:50	Se realiza cambio de pañal. Se aplica crema antipañalitis Instacalm (nistatina + óxido de zinc) y crema Almipro (óxido de zinc) en región glútea, con el fin de prevenir y tratar irritación por pañal. Paciente tolera el procedimiento sin complicaciones	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
31/03/2026 23:02	Se realiza cambio de posición a decúbito lateral izquierdo, colocando almohadas de soporte en región dorsal y entre miembros inferiores para favorecer alineación corporal y confort del paciente. Durante el procedimiento, paciente presenta episodio de nerviosismo.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
31/03/2026 23:47	Se observa paciente dormida con buen patrón respiratorio.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
01/04/2026 01:18	Se realiza cambio de posición a decúbito lateral derecho, colocando almohadas de soporte en región dorsal y entre miembros inferiores para favorecer alineación corporal y confort del paciente. Durante el procedimiento, paciente presenta episodio de nerviosismo.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
01/04/2026 02:03	Se observa paciente dormida con buen patrón respiratorio.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
01/04/2026 03:10	Se realiza cambio de posición a decúbito lateral izquierdo, colocando almohadas de soporte en región dorsal y entre miembros inferiores para favorecer alineación corporal y confort del paciente. Durante el procedimiento, paciente dormida con buen patrón respiratorio.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH
01/04/2026 04:40	Se realiza cambio de posición semifowler, paciente estable con episodios de nerviosismo.	BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

IPS CLINICAL HOUSE S.A.S

NOTAS ENFERMERIA

Consulta Externa

FECHA : 01/03/2026

INGRESO : 167536

RAMIREZ CARRILLO LUZ BELEN

CC - 37320742

Edad : 58A 0M 28D **Sexo :** Femenino

Nacimiento : 3/03/1968 **Teléfono :** 3028554391

Dirección : CLLE 3AN 2E 75 BR CASTILLANA

Empresa : ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

01/04/2026 05:00 Se administra Acido valproico 250mg por vía oral, paciente la ingiere y tolera sin complicaciones.

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

01/04/2026 07:00 Entrego paciente femenino, 58 años de edad, paciente LUZ BELÉN RAMIREZ CARRILLO
DX: Encefalopatia hipoxica,crisis epilépticas, cuadriplejia flácida y polineuropatia no especificada, hipertensión esencial, incontinencia urinaria, no especificada, constipación, fractura de pelvis (resuelta) fractura de pubis(resuelto) provocados por evento adverso Transtorno mixto de ansiedad y depresión
Antecedentes patológicos personales: secuelas post covid 19, hipertensión arterial esencial primaria, en encefalopatía hipoxemica apraxia verbal, síndrome de movilidad reducida.

Paciente en unidad domiciliaria en acompañamiento de familiar cuñado(José), hermana (Carmen Ramirez), conocido(Carlos Omar) y aux de turno la cual le informo estado de la paciente se encuentra estable dormida con buen patrón respiratorio presenta pequeños hematomas en miembros inferiores y superiores izquierdos y derechos por causa de las terapias físicas particulares, se le hidrató piel con crema corporal(lubriderm), y se realiza cambio de posiciónes.

Paciente se encuentra estable, en cama hospitlaria posición decubito supino colchón antiescaras ,paciente en el programa de atención domiciliaria con barandas de seguridad elevadas en posición decúbito supino.

Paciente estable desorientada en las 3 esferas(tiempo, espacio y lugar), glasglow 15/15, paciente alerta al llamado, lenguaje incoherente, afebril, tolerado oxígeno ambiente, manejando buen patrón respiratorio, en buenas condiciones generales e higiénicas

Valoracion cefalocaudal: se observa cabeza normocefalica,
Ojos normoreactivos a la luz,
Mucosa nasal húmeda sin laceraciones,
Mucosa oral húmeda y labios hidratados, con piezas dentales presentes,encías en buen estado con un tono rosado claro
Cuello simétrico con cicatriz de traqueotomía, con movilidad reducida no doloroso a los movimientos de flexión, extensión , adenopatias no visibles ni palpables, No presenta soplo carotideo, tórax expandible, Pectorales sin presencia de masas, Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos a la auscultación pulmonar, sin ruidos respiratorios sobre agregados, Abdomen blando, globoso, depresible no masas, no doloroso a la palpación, Con cicatriz de gastrotomía en región fosa ilíaca izquierda, Genitales íntegros en buenas condiciones higiénicas sin presencian, de quemaduras, pañal limpio apto para su uso, diuresis espontánea, clara con olor fuerte , extremidades superiores normales con flexión y extensión, miembro inferiores no doloroso al momento de flexión y extensión, no presento molestias en la parte izquierda de cadera, se observa piel integra e hidratada, con presencia cicatrización en la zona sacra epitelizada y recuperada, descubierta con presencia de crema(antipañalitis).

NOVEDADES PRESENTADAS ENTREGA DE TURNO:
Paciente se mantiene despierta. Durante el turno paciente Tolera adecuadamente la vía oral para la administración de medicamentos. Se realizo los cambios de posicion, concilio sueño temprano.

OBSERVACIONES
• Dentro del domicilio Se observa hace tiempo material mecánicos, a fuera llenos de polvo y mugre.(a Jefe de ruta ordeno cerrar las ventan que va directo del paciente).
•Se evidencia presencia de pápulas primarias en la piel, en fase de resolución con aspecto seco
•observo cicatriz de lesion sacra fase final epitelizada y Recuperada.
•Hematomas en miembro superior e inferiores presentadas por cabestrillos utilizados en terapias físicas.
•Se evidencia que la grúa de movilización presenta fallas en su funcionamiento,
Utilizado para la movilización de la paciente se encuentra deteriorado.(presenta desgaste en sus sujeciones) Por lo tanto requiere mantenimiento, se decide suspender su uso apartir de la fecha

PENDIENTES:
•pendiente orden laboratorio (nutriciónista Amauri Villalba)
•Control con médico del dolor en 6 meses (junio).
•Control con neurología.
•Pendiente visita domiciliaria medico general(Marzo)
•Pendiente Visita domiciliaria jefe de ruta.
•Pendiente Cita con odontología.
• Pendiente Fisiatria (perdida por parte de transporte, ambulancia)
• Pendiente cita con psiquiatría.
• Pendiente cita psicóloga (Mayo)
• Pendiente terapias fisioterapeuta
• pendiente terapias ocupacional
•Pendiente terapias fonoaudiologo

ALERGICOS: DIPIRONA

PACIENTE SE ENCUENTRA ADHERIDO AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO:
•Losartán 50mg: 1 tableta por vía oral, C/12 H
•Esomeprazol 20mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Amantadina 100mg: 1 cápsula vía oral, C/12H
•Amlodipino 5mg: 1 tableta vía oral, C/24H; No administrar. si la tensión arterial se encuentra en rangos bajos o fuera

BELTRAN SUAREZ ADRIANA JULIETH

ANOTACIONES DE ENFERMERIA

de lo normal
•Citicolina 250mg: 1 tableta vía oral, C/12H
•Ácido acetilsalicílico 100mg: 1 tableta vía oral, C/24H
•Escitalopram jarabe 20cc, administrar vía oral después del almuerzo
•Quetiapina 250mg: administrar vía oral, C/24H (según orden de psiquiatría administrar de último en horas de la noche)
•Ácido valproico 250 mg: administrar vía oral, C/8H, En la noche a las 08:50 pm un a dosis adicional por orden médica
•Acetaminofén: administrar en caso de dolor o fiebre
•Polietilenglicol 3350 mg: administrar como laxante en caso de estreñimiento
•Gotas naturales (esencial floral o pasifloral): administrar en caso de nerviosismo, llanto o insomnio. (Suministro solo bajo responsabilidad de familiar a familiar Carmen Elena)

Líquidos administrados y eliminados:
Elimino (++)
Deposición (-)

ACTIVIDADES DE ENFERMERA REALIZADAS Entrega de TURNO:
•Asistir a la hora del alimento del paciente oral(cena)
•Realizar cambios de posiciones, se lubrica piel con crema lubriderm, se utilizo almohadas para mayor soporte y seguridad ala paciente
•lubricar con crema (Lubriderm) corporal miembros superiores e inferiores
•Cambio de pañal y aseo genital siempre cuando lo adquiera
Higiene aseo personal.
terapia con la pelota ejercicios en miembros superiores e inferiores.
Entrega Aux- Adriana Beltrán
Recibe Aux- Astrid Herrera